

건강증진연구사업
(정책, 08-14)

노인건강증진을 위한 종합대책 및 관리방안 개발

(A Development of Comprehensive Health Plan
and Management Strategy for the Elderly)

2009. 1

전 남 대 학 교
건강증진기금사업지원단

이 보고서는 보건복지부에서 주관하는 국민건강증진기금에 의해 수행된 것이며, 이 보고서에 수록된 내용은 연구자 개인적인 의견이며 보건복지부의 공식견해가 아님을 밝혀드립니다.

제 출 문

보건복지가족부장관 귀하

이 보고서를 “노인건강증진을 위한 종합대책 및 관리방안 개발” 과제의
최종보고서로 제출합니다.

2009. 1. 3.

주관연구기관명

전남대학교

연구책임자

이정애(전남의대 예방의학)

연구원

신준호(전남의대 예방의학)

박종춘(전대병원 순환기내과)

신일선(전대화순병원 정신과)

정은경(전남의대 의학교육학)

신민호(전남의대 예방의학)

이영훈(서남의대 예방의학)

연구보조원

최성우(전남의대 예방의학)

김혜연(전남의대 예방의학)

윤우준(전남의대 예방의학)

김진희(전남의대 연구원, 보건학)

박민정(전남의대 연구원, 간호학)

요 약 문

I. 제 목

노인건강증진을 위한 종합대책 및 관리방안 개발

II. 연구의 목적 및 필요성

21세기는 지금까지 경험해보지 못한 고령화 사회로서, 노인들의 만성퇴행성 질환 및 장애가 가장 중요한 사회문제로 대두될 것으로 전망된다. 즉 거동할 수 없는 노인이나 치매환자와 같이 일상생활을 하는데 있어서 누군가의 도움에 의존해야 하는 노인들이 증가하게 된다. 의존적인 노인들의 대부분은 만성퇴행성질환의 합병증으로 인한 것이며 또한 이러한 상태가 장기화되는 경향이 있어 노년기의 삶의 질의 저하뿐 아니라 노인의료비가 급증하게 되어 개인뿐 아니라 국가의 큰 부담이 될 것이다.

이 연구의 목적은 우리나라 노인의 건강수명 연장과 삶의 질 향상을 위하여 고령인구가 점증하고 있는 우리나라의 사회, 경제, 문화적 여건 변화 속에서 노인계층을 위한 노인 건강유지 및 증진을 위한 종합대책 및 관리방안을 개발하기 위함이다.

III. 연구의 내용 및 범위

- 1) 우리나라 노인의 건강수준과 주요 건강문제(질병), 그리고 노인의료비에 대한 실태를 파악하였다.
- 2) 보건복지가족부의 부서별, 정책별로 분산되어 있는 노인관련 정책, 법률 그리고 의사결정과정 등을 파악하였다.
- 3) 현재 시행중인 노인 건강대책의 사업범위 및 주요 사업(프로그램)을 분석하였다.

- 4) 노인 건강관리를 위한 정책 및 사업범위의 우선순위 설정을 위한 기준을 마련하고 이에 의해 우선순위를 설정하였다.
- 5) 근거중심의 노인 건강증진 종합대책을 위한 국가 비전과 장·단기 목표를 개발하였다.
- 6) 노인 건강증진의 목표를 달성할 수 있는 국가차원 및 지역사회(보건소)차원에서의 관리전략과 평가지표항목을 개발하여 효과적인 추진전략을 제시하였다.

IV. 연구결과

노인건강을 위한 종합대책의 국가 비전/목적(Goals)은 첫째 건강수명의 연장, 둘째 사회계층간 건강격차의 감소, 셋째 노년기 생활의 질 향상으로 설정하였다. 구체적 목표로는 건강노인에서부터 고위험 노인(high risk group), 만성질환 노인, 기능장애 및 삶의 질과 관련된 다빈도 질환을 가진 노인 그리고 말기환자에 이르기까지 5단계로 나누어서 각 대상그룹에 따라 목표를 설정하였다. 첫째 건강노인을 중심으로 한 건강증진(바람직한 생활습관), 둘째 고위험노인에 대한 질병의 조기발견 및 주기적 관리, 셋째 만성질환노인에 대한 등록 추후관리로 합병증 발생예방, 넷째 기능장애노인 및 삶의 질과 관련된 다빈도 질환을 가진 노인에 대한 재활 및 삶의 질 유지, 마지막 말기환자 노인에 대해서는 보살핌 및 요양 등으로 설정하였다. 이러한 목표 달성을 위한 인프라 및 접근전략으로는 근거중심 정책(evidence-based policy)를 위한 노인건강조사(surveillance)와 data system 구축, 생애주기별 건강증진계획과 연계, 취약계층 노인에 대한 우선순위 건강보호 강화 등에 역점을 두어야 한다. 또한 노인의료전달체계를 구축하여 각 기관별 기능과 역할 분담을 함으로서 보건, 의료, 복지의 연계를 통한 적정의료 서비스 및 노인의료비 절감의 가능성을 접근전략으로 제시하였다.

V. 연구결과의 활용계획

이 연구는 우리나라 노인의 건강과 관련된 정책, 사업, 법 등을 조사하여 분석하였으므로, 노인을 위한 보건정책과 관련된 서비스를 개발하기 위한 기초 자료를 제공하였다. 특히 국가의 노인보건정책에 관한 비전과 목표 및 평가지표 항목들을 제시하였으므로 중장기 노인건강증진을 위한 실제적이고 구체적인 종합 대책을 수립하는데 활용이 가능하다.

또한 보건복지가족부의 노인 정책 관련 부서의 연계가능성 및 문제점들을 제시하였고, 물론 노인에게 직접 서비스를 제공하는 보건소에서도 노인을 위한 통합적 관리방안을 수립하는데 기여할 것으로 기대된다.

SUMMARY

I . Title

A Development of Comprehensive Health Plan and Management Strategy for the Elderly

II.The purpose and necessity of the study

In the twenty first century which is an aging society we've not experienced so far, the number of the dependent elderly is increasing because the greater number of the elderly is suffering chronic degenerative diseases and disability.

This situation tends to last for long, so it causes to lower the quality of life. Also, rapid increase in the elderly's medical expenses will be a burden to the country as well as to the individuals.

III. The contents and scope of the study

- 1) We investigated the condition of the elderly's health status, major health problems, and medical expenses.
- 2) We investigated the elderly-related policy, law, and decision-making process that are dispersed according to departments of Ministry of health, welfare, and family.
- 3) We analyzed the ongoing elderly health program in community.
- 4) We determined the priority of the policy and program for the elderly's health care.

- 5) We set the national visions and long-term goals for the comprehensive plans to enhance the elderly's health.
- 6) We developed management strategy and performance indicator at the national and local community level.

IV. Results of the study

We set the national visions and goals as follows; firstly, extension of healthy expectation life, secondly, decrease in health gap between social classes, thirdly, improvement in the quality of later life. We set specific objectives according to the each group which is divided into five groups; the healthy elderly, the high risk group, the elderly with chronic degenerative disease, the disabled elderly, the terminal elderly. Firstly, for the healthy elderly we provide the service of health promotion such as regular exercise and good nutrition etc. Secondly, for the high risk group, early diagnosis by health examination. Thirdly, for the elderly with chronic degenerative disease, continuous registration and follow up. Fourthly, for the disabled elderly, prevention of recurrence and rehabilitation. Last, for the terminal elderly, long-term care service.

In order to achieve these goals, we should put emphasis on surveillance and data system for the evidence-based policy, the linkage with health promotion plans according to life cycles, decrease in health gap between social classes, and policies to reduce medical expenses of the elderly.

Also, It is necessary to establish the health delivery system for the elderly in order to provide comprehensive, total health care service.

목 차

제 1 장 서론.....	12
1. 연구의 배경 및 필요성.....	12
2. 연구 목적.....	23
제 2 장 국내외 현황.....	25
1. 국외 사례.....	25
2. 국내 사례.....	33
제 3 장 연구수행 내용 및 결과.....	40
제 1 절 연구대상 및 방법.....	40
1. 연구 대상.....	40
2. 연구 분석의 틀.....	40
제 2 절 연구내용 및 결과.....	43
1. 노인의 건강상태, 만성질환 유병률, 노인의료비 등 조사.....	43
2. 보건복지가족부의 노인관련 정책 및 사업 분석.....	56
3. 우리나라 노인건강 관련 법령 분석.....	61
4. 보건소의 노인관련 사업 조사.....	66
5. 노인건강과 관련된 정책의 의사결정과정 및 환경조사.....	68
6. 우리나라 노인건강정책의 주요 문제점.....	73
7. 노인건강문제에 대한 공중보건학적 우선순위 설정.....	74
8. 노인건강증진의 비전, 목표 및 기본 접근 전략.....	88
9. 보건복지가족부 노인건강종합대책 T/F (안).....	94
10. 노인건강지표 항목 개발.....	98
11. 향후 계획.....	99
제 4 장 연구목표 달성도 및 대외기여도.....	101
1. 연구목표 달성도.....	101
2. 대외 기여도.....	101

제 5 장 연구결과의 활용계획	103
1. 활용계획	103
2. 추가연구의 필요성	103
참고 문헌	104
부록	106

표 목 차

<표 1> 노인인구 추이	13
<표 2> 인구 고령화 속도 추이	14
<표 3> 연령계층별 인구 및 노령화 지수 추이	15
<표 4> 고령자의 이혼건수	17
<표 5> 노인부부 가구의 이전소득 수지	17
<표 6> 장성군의 노인인구의 가구형태별 분포와 전국과의 비교	18
<표 7> 일본의 특정건강진단 항목	29
<표 8> 평균수명 추이	44
<표 9> 노인과 30세 이상 일반성인의 건강행태	44
<표 10> 노인의 만성질환 유병률	45
<표 11> 65세 이상 노인의 다빈도 만성질환	46
<표 12> 노인의 입원 다발성 진료 순위(2007년)	47
<표 13> 노인의 외래 다발성 진료 순위(2007년)	47
<표 14> 우리나라 치매 노인수 추계(2000~2020)	48
<표 15> 우리나라 치매환자의 정도별 유병률	48
<표 16> 최근 5년간 의료이용 치매환자수와 진료비 추이	49
<표 17> 최근 5년간 건강보험급여 중에서 치매 환자수와 진료비의 비중	49
<표 18> 주요 국가의 성별, 연령별 인구 100명당 치매 유병률	51
<표 19> 65세 이상 인구의 사망원인	54
<표 20> 10년간 노인의료비 지출 10배 증가	55
<표 21> 65세 이상 노인의료비 추이	56
<표 22> 보건복지가족부 담당부서의 보건소 관련 사업	57
<표 23> 보건복지가족부 담당부서의 노인관련 정책과 사업	58
<표 26> 보건소의 노인 관련 사업	66
<표 27> 보건복지가족부 내 노인관련 부서의 업무분장 내용	71
<표 28> 허약의 범주와 지표내용	83
<표 29> 외국의 우선순위 결정기준에 따른 우선순위 설정	84
<표 30> 우리나라 노인건강증진을 위한 우선순위 설정	85

<표 31> 보건소 설문조사 결과 1.	86
<표 32> 보건소 설문조사 결과 2.	86
<표 33> 보건소 설문조사 결과 3.	87
<표 34> 보건소 설문조사 결과 4.	87
<표 35> 노인건강종합대책 T/F	95
<표 36> 노인건강지표 항목	98

그림 목차

<그림 1> 노인인구 비율 및 고령화율.....	13
<그림 2> 생산가능인구의 추이.....	16
<그림 3> 노인병의 범주 개념도.....	20
<그림 4> Nagi의 장애발생과정.....	22
<그림 5> Care continuum for dementia patients.....	33
<그림 6> 사례관리기반 보건복지 통합 프로그램의 흐름도.....	36
<그림 7> 대구광역시 고혈압·당뇨병 관리사업 네트워크 구축 개념도.....	39
<그림 8> 연구 분석 과정.....	41
<그림 9> Life expectancy and healthy life expectancy.....	43
<그림 10> 최근 5년간 건강보험급여 중에서 치매 환자수와 진료비의 비중.....	50
<그림 11> 65세 이상 노인의 건강상태 및 기능장애 정도.....	52
<그림 12> 65세 이상 인구의 사망원인(2006).....	54
<그림 13> 자살 사망률 인구 10만명당(2007).....	55
<그림 14> 보건소 조직도(광역단위).....	67
<그림 15> 보건소 조직도(농촌단위).....	67
<그림 16> 신체자립성 유지/향상을 위한 노인보건의료서비스 개입.....	81
<그림 17> Frailty: Working Framework.....	82
<그림 18> 허약성과 장애의 개념적 모델.....	82
<그림 19> 비전과 목표.....	89
<그림 20> 노인의료전달체계.....	90
<그림 21> 국가차원의 노인정책 결정과정 및 접근전략.....	93
<그림 22> 지역사회(보건소)의 노인정책 기본접근 전략.....	94

제 1 장 서 론

1. 연구의 배경 및 필요성

21세기는 지금껏 경험해보지 못한 고령화 사회로서, 노인들의 만성퇴행성 질환 및 장애가 가장 중요한 사회문제로 대두될 것으로 전망된다. 즉 거동할 수 없는 노인이나 치매환자와 같이 일상생활을 하는데 있어서 누군가의 도움에 의존해야 하는 노인들이 증가하게 된다. 만성퇴행성질환은 생활행태와 관련이 높으며 대부분 여러 복합요인에 의하여 유발된다. 의존적인 노인들의 대부분은 복합적인 욕구를 가지고 있을 뿐 아니라 이러한 욕구가 장기화되는 경향이 있어 노년기의 삶의 질뿐만 아니라 노인의료비의 급증으로 인해 환자, 가족 그리고 국가의 경제적 부담이 크게 증가할 것이다. 따라서 노인의 질병에 대한 관리사업은 단순한 치료서비스의 차원을 넘어 예방, 조기발견과 조기치료, 추후관리, 재활 및 요양 등 종합된 범국가적인 사업으로 추진되어야 할 것으로 보인다. 이와 같이 노인의 건강을 위하여 국가가 적극적으로 개입하기 위해서는 근거 중심의 노인건강정책을 수립하기 위한 기초적이고 종합적인 분석이 필요하다.

1) 노인인구 증가 추이

□ 우리나라 인구 10명 중 1명이 노인인구

- 2008년 현재 우리나라의 65세 이상 인구는 502만 명으로 총인구의 10.3%를 차지하고 있다. 2000년 7.2%로 「고령화 사회」에 진입한 후로 2018년에는 14.3%로 「고령사회」, 2026년에는 20.8%로 「초(超)고령사회」에 도달할 것으로 전망하고 있다.
- 또한 2050년에는 38.2%로서 세계 ‘최고령국’이 될 전망이다.



<그림 1> 노인인구 비율 및 고령화율

자료 : 통계청, 「전국장래인구추계(2006)」, 「2007 고령자 통계」

<표 1> 노인인구 추이

(단위: 천명)

구분	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2018	2030
전인구	25,012	32,241	38,124	42,869	47,008	48,875	49,340	48,635
65세 이상 (%)	726 (2.9)	991 (3.1)	1,456 (3.8)	2,195 (5.1)	3,371 (7.2)	5,032 (11.0)	7,056 (14.3)	11,818 (24.3)

자료: 통계청, 장래인구추계, 2006.11

□ 고령화로 진행되는 속도가 세계에서 가장 빠름

- 노인인구의 비율이 7%에서 14%로 되는 기간이 프랑스는 115년, 미국은 73년, 일본이 24년인데 비해 우리나라는 18년밖에 걸리지 않을 것으로 전망되고 있다.
- 또한 14%에서 20%가 되는데 걸리는 소요년수는 프랑스 39년, 미국 21년, 일본 12년 걸리는데 우리나라는 8년밖에 걸리지 않을 것으로 전망된다.
- 따라서 이는 오랜 기간에 걸쳐 인구고령화에 대처해 온 선진국과는 달리 우리나라의 경우 고령화 사회에 대한 준비가 그만큼 시급함을 의미한다.

<표 2> 인구 고령화 속도 추이

	도달년도			증가소요년수	
	7%	14%	20%	7%→14%	14%→20%
일 본	1970	1994	2006	24	12
프 랑 스	1864	1979	2018	115	39
독 일	1932	1972	2009	40	37
영 국	1929	1976	2021	47	45
이탈리아	1927	1988	2007	61	19
미 국	1942	2015	2036	73	21
한 국	2000	2018	2026	18	8

자료 : UN, 「The Sex and Age Distribution of World Population」, 각년도
국립사회보장·인구문제연구소, 「인구통계자료집」, 2000
통계청, 「전국장래인구추계」, 2006.

□ 노인부양비의 급증

- 노인부양비는 2007년 13.7%에서 2018년 약 20%, 2026년 30.9%까지 증가할 것으로 예상된다. 따라서 2007년에는 15~64세 생산가능인구 7.3명당 노인 1명을 부양했는데 2026년에는 3.2명당 1명, 2050년에는 1.4명 당 1명이 될 것으로 전망하고 있다.
- 2007년 노령화지수(65세 이상 인구/0~14세 인구)는 55.1이었는데 2016년에는 100.7로 노년인구가 유년인구를 추월할 것으로 예측한다.

<표 3> 연령계층별 인구 및 노령화 지수 추이

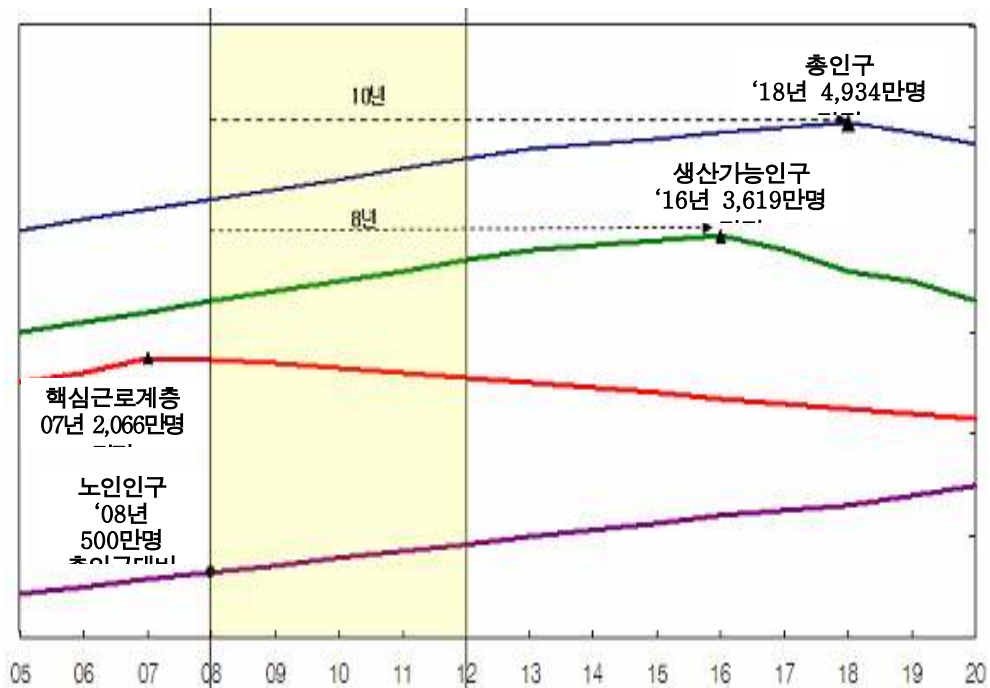
(단위 : 천명, %)

	1990	1997	2000	2006	2007	2010	2016	2018	2026
총 인 구	42,869	45,954	47,008	48,297	48,456	48,875	49,312	49,340	49,039
65세이상	2,195	2,929	3,395	4,586	4,810	5,357	6,585	7,075	10,218
<구성비>	5.1	6.4	7.2	9.5	9.9	11.0	13.4	14.3	20.8
노년부양비	7.4	8.9	10.1	13.2	13.8	15.0	18.2	19.7	30.9
노령화지수	20.0	28.6	34.3	51.0	55.1	67.7	100.7	112.5	178.6
노인 1명당 생산가능인구 (명)	13.5	11.2	9.9	7.6	7.3	6.6	5.5	5.1	3.2

자료 : 통계청, 「장래인구추계」, 2006

□ 생산가능인구는 2016년을 정점으로 감소

- 현재와 같은 추세가 지속될 경우, 총인구는 앞으로 10년 후인 2018년에는 4,934만 명을 정점으로 감소하기 시작하며, 생산가능인구(15~64세)는 2016년에 3,619만 명을 정점으로 감소한다.
- 그러나 핵심근로계층(25~49세)은 2007년 2,066만 명을 정점으로 감소하고 있다.



<그림 2> 생산가능인구의 추이

자료: 주요 인구구조 변동, 통계청 2006

저출산고령화 대책 특별위원회 업무보고 인용, 2008

2) 노인의 사회경제학적 측면

□ 노인인구의 이혼 증가 추세

- 고령자의 이혼건수를 보면 남자의 경우, 1996년 총 이혼건수 중 약 1%를 차지하였던 것이 2006년에는 2.5%를 차지하여 2.5배 증가하였으며, 여자는 1996년 0.2%에서 2006년 1.0%를 차지하여 약 5배로 증가하고 있다. 이는 여성의 경제적 보호가 법제화 되는 등 소득보장 영향으로 보인다.

<표 4> 고령자의 이혼건수

(단위 : 건, %)

	남 자					여 자				
	1996	2000	2004	2005	2006	1996	2000	2004	2005	2006
이혼 건수	79,895	119,982	139,365	128,468	125,032	79,895	119,982	139,365	128,468	125,032
65세이상	773	1,354	2,373	2,612	3,087	198	430	837	922	1,251
구성비	1.0	1.1	1.7	2.0	2.5	0.2	0.4	0.6	0.7	1.0

자료 : 통계청, 「인구동태통계」, 각년도

□ 노인부부가구의 소득은 이전소득(연금, 사회보장수혜 등)이 56.9%인

- 노인부부 가구의 이전소득은 2003년 전국가계조사 이후 연금 및 사회보장수혜에서 지속적인 증가세를 보이고 있다.

<표 5> 노인부부 가구의 이전소득 수치

(단위 : 천원, %)

	2003		2004		2005		2006	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비
총 소 득	959.0	100.0	1,117.4	100.0	1,159.8	100.0	1,208.9	100.0
이 전 소 득	489.8	51.1	607.5	54.4	633.4	54.6	687.3	56.9
연금및사회보장	231.6	24.2	272.5	24.4	293.7	25.3	313.5	25.9
기 타	258.2	26.9	335.1	30.0	339.7	29.3	373.8	30.9
연금 수급률	10.8		13.2		16.1		19.0	

자료 : 통계청 「가계조사」, 각년도

주 : 연금수급률은 국민연금통계, 공무원연금통계 및 사학연금통계의 합계

□ 노인단독가구와 노인부부가구가 증가

- 노인단독가구는 전국 20.1%에 비해 농촌은 23.6%로 높고, 또한 노인부부가구도 전국 21.6%에 비해 농촌은 27.5%로 높게 나타나고 있다. 이미 농촌은 고령사회에 진입함을 알 수 있다.

<표 6> 장성군의 노인인구의 가구형태별 분포와 전국과의 비교

(단위:%)

구 분	장성군	전국	읍면부
노인단독가구	30.6	20.1	23.6
노인부부가구	26.0	21.6	27.5
15세 미만 아동과 동거하는 노인가구	6.1	58.3	48.9
15세 이상 자녀와 동거하는 노인가구	37.3		
계(가구수)	100(6,966)	100(1,958)	100(705)

자료: 장성군 내부자료, 2001.

한국보건사회연구원, 1998년도 전국 노인생활실태 및 복지욕구조사, 1998.

3) 보건복지가족부의 평생건강관리체계의 문제점

- 2000년 제정된 보건의료기본법에는 사전예방적 평생건강관리에 관한 규정이 있어서 국가 및 지방자치단체가 이를 수행하도록 하고 있다. 또한 복지부 발표 역대 보건시책 가운데서도 사전예방적 평생건강관리 관련 내용이 있다.

1999년: 사전예방, 건강관리, 생애주기별 평생건강관리체계 구축 강조, 이를 위해 보건소 등 지역공공보건의료 역할 확대 제시

2000년: 평생건강관리체계 확립 원년으로 확정

2005년: 건강생활실천, 만성질환 예방 및 관리, 생애주기별 건강증진을 연계하여 추진, 이를 위해 역시 보건소 등 지역공공보건기능 강화와 재정 인력 확보 등 제시

- 그러나, 사전예방적 평생건강관리 구축을 위한 인프라 확충방안, 부처간의 연계 등 체계 개편방안, 정책 등 프로그램 개발 그리고 관련 예산 등 구체적인 방안 제시가 부족하고, 특히 건강보험진료비의 30%에 육박하는 수준으로 증가하는 노인의료비를 볼 때 노인건강관리에 대한 대책이 시급함에도 불구하고 대책강구는 미흡하다.

4) 우리나라의 치매 대책의 문제점

- 우리나라는 1995년 치매 10년 대책을 발표하여 1996년부터 10년간 치매노인 특별대책을 시행하였으며 그 내용을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 치매 예방 또는 치매환자 조기발견사업 강화, 둘째, 치매전문요양시설의 확충, 셋째, 치매전문의료기관 건립, 넷째, 치매노인 및 가족을 위한 방문서비스 강화 등 이었다.
- 그러나 이러한 노력에도 불구하고 치매정책에는 몇 가지 문제점을 발견할 수가 있다. 첫째, 치매노인 관련 의료법, 복지법, 국민건강보험법 등 정비가 미흡하여 노인전문병원은 일반병원으로 취급되는 등의 혼란이 초래되고 있고 둘째로는 치매환자를 위한 지역사회 의료, 보건, 복지서비스 전달체계의 불합리성 또는 연계 미비하고 셋째로는 치매와 관련된 정보제공의 미흡, 넷째, 치매노인과 가족을 위한 서비스 프로그램의 부족, 다섯째, 시설 및 전문 인력의 부족, 여섯째로 치매관련사업의 예산이 따로 편성되어 있지 않고 노인복지예산에 포함되어 있어 예산의 부족 등을 문제점으로 지적할 수 있다.

5) 노인질환의 특징

□ 노인질환의 특징은 특히 장애발생 위험이 높음

노인병을 정의하기는 쉽지 않다. 그러나 기본적 질병에 세월의 경과(노화)가 보태어진 노인병의 양상은 다양하고 복잡하여 정의하기가 더욱 어렵다. 따라서 노인병이 무엇이나? 고 물으면 대개는 노인병의 특성을 나열하거나 <그림 3>과 같이 노인병의 개념으로 설명한다(유형준, 2008).

- 노인에 많은 질환: 고혈압, 당뇨병, 뇌졸중, 심장질환, 암, 만성폐질환 등



- 노인 특유 질환: 노인성 치매, 노인성 골다공증, 노인성 백내장, 노인성 난청 등

<그림 3> 노인병의 범주 개념도

- 노인질환의 특징을 보면 다음과 같다.

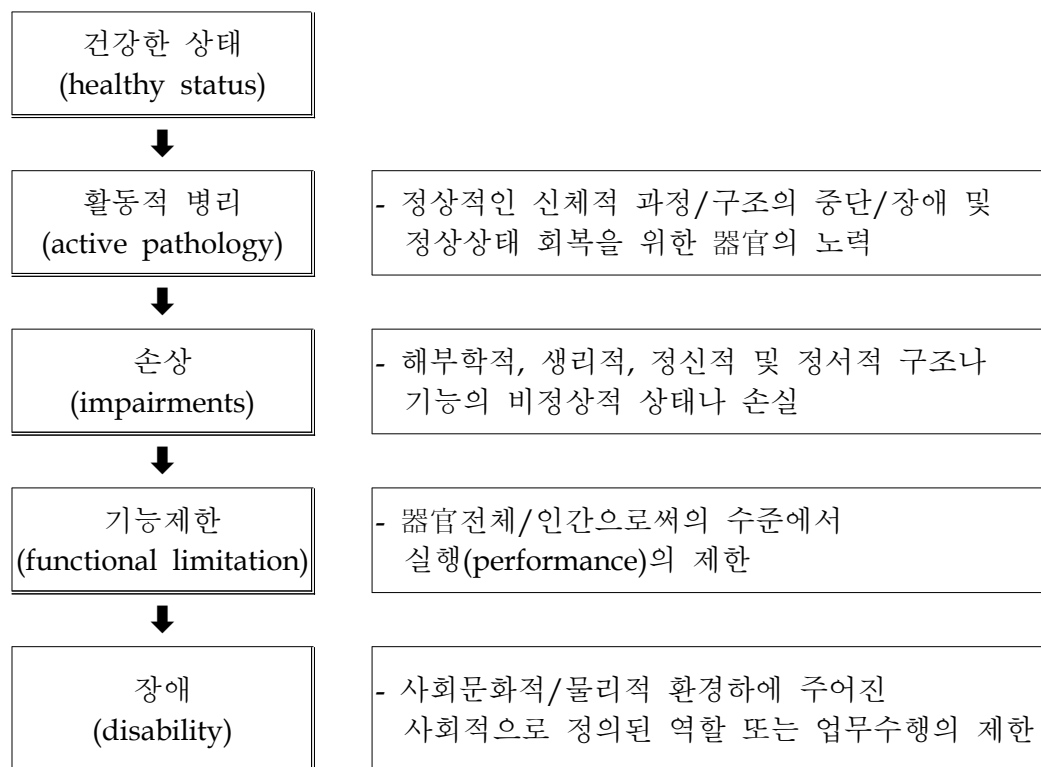
- ① 노년기 특유의 질병이 없다.
- ② 1인이 여러 개의 병을 갖는다(질병 다발성, multiple pathology).
- ③ 증상과 경과가 자주 비전형적이다.
- ④ 기능의 병이다. (3M: Mobility, Mentation, Micturition, 5I: Iatrogenic disease, Incompetence, Incontinence, Immobility, Impaired homeostasis)
- ⑤ 합병증이 잘 생긴다.
- ⑥ 병이 중해지기 쉽고 회복은 늦다.
- ⑦ 정신증을 보이는 경우가 많다.
- ⑧ 수분과 전해질 균형이 잘 깨진다.
- ⑨ 여러 약물을 복용한다(다약물복용, polypharmacy).
- ⑩ 약물에 대한 반응이 청장년과 다르다.

- 따라서 허약 노인집단, 즉 주요 만성질환이 있거나 일상생활 수행능력의 장애가 발생할 위험성을 지닌 신체적 기능제한이 있는 집단을 중심으로 이들에게서 합병증 또는 기능저하, 낙상 등에 의한 장애로 다른 사람의 수발을 받지 않도록 사전에 예방함이 중요하다.

- 허약(frail)노인과 장애(disabled)노인의 개념을 비교하면, 허약노인은 상해가 발생할 위험에 처해 있는 상태가 장기간 지속되어 있거나 전반적인 건강수준이 위험에 빠질 수 있는 상태에 있는 노인으로 보고 있고, 반면에 장애

노인은 이미 기능의 하락으로 정상적인 일상생활동작을 수행하기 위하여 제 3자로부터 실질적인 도움을 필요로 하는 자로 정의하여 명백하게 허약 노인과 구별하고 있다(OECD, 1996).

- 집단별 유형화의 기준으로 만성질환의 보유여부와 일상생활 수행능력을 고려할 수 있는데, Nagi 등에 의해서 장애발생과정(disablement process)을 다음과 같이 개념화하였다.
 - ① 건강한 집단: 주요 만성질환이 없고 일상생활 수행능력의 장애가 없는 집단
 - ② 신체적 자립 집단: 주요 만성질환은 있지만 일상생활 수행능력의 장애가 없는 집단
 - ③ 허약 집단: 주요 만성질환의 유무와 관계없이 일상생활 수행능력의 장애가 발생할 위험성을 지닌 신체적 기능제한이 있는 집단
 - ④ 장애 집단: 일상생활 수행능력에 장애가 있어 타인의 간병수발이 필요한 집단



<그림 4> Nagi의 장애발생과정(1964년, 1979년, 1991년)

출처: Nagi SZ. A study in the evaluation of disability and rehabilitation potential: concepts, method, and procedures. American Journal of Public Health 1964;54. Nagi SZ. Disability concepts revised: implications for prevention. In:Pepe Am, Tarlov AR(eds). Disability in America: toward a national agenda for prevention. National Academy Press; 1991. Nagi SZ. The concept and measurement of disability. Disability policies and government programs. National Academy Press; 1979

6) 노인 건강증진을 위한 종합대책 및 관리방안 개발의 필요성

- 이제까지 노인의 질병관리는 치매를 제외하고는 거의 단편적이고 개인적 차원에서 이루어져 왔으며, 공중보건학적 관점에서의 접근은 부족한 실정이다.
- 또한 노인의 문제를 사회적, 복지적, 경제적 측면에서 주로 연구되고 서비스 개발도 활발히 이루어지고 있는 반면에, 정작 노인의 삶의 질과 직결

된 질병 관리체계에 대한 연구와 정책은 개별적 과제로 접근하거나 산발적으로 이루어지고 있다.

- 따라서 노인에게 직접적인 서비스를 제공하는 보건소에서는 여러 종류의 노인보건사업이 시행되고 있지만 지원하는 중앙 정부의 부서가 서로 다르기 때문에 현장에서의 사업들은 연속적이지 못하고 단편적이고 중복되기도 하여 비효율적이고 비효과적인 문제를 안고 있다.
- 노인환자 특성에 맞는 의료서비스를 제공하도록 유도하기 위한 제도 장치가 필요하며 현재의 고비용 저효율 구조를 저비용 고효율 구조로 개선해야 한다.
- 노인들에게 주로 발생하는 주요 만성질환의 등록 및 관리 제도를 도입하여 지속적 건강관리의 체계화가 필요하다.
- 노인의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해서는 질병의 예방과 건강증진, 질병의 치료 및 지속적 관리, 그리고 재활 또는 잠재적 기능 개발 등 연속적이고 체계적이며 총괄적인 접근이 필요하다.

2. 연구의 목적

이 연구의 목적은 우리나라 노인의 건강수명 연장과 삶의 질 향상을 위하여 고령인구가 점증하고 있는 우리나라의 사회, 경제, 문화적 여건 변화 속에서 노인계층을 위한 노인 건강유지 및 증진을 위한 종합대책 및 관리방안을 개발하기 위함이며, 이를 위한 구체적인 목표는 다음과 같다.

- 1) 우리나라 노인의 건강수준과 주요 건강문제(질병), 그리고 노인의료비에 대한 실태를 파악한다.
- 2) 보건복지가족부의 부서별, 정책별로 분산되어 있는 노인관련 정책, 법률 그리고 의사결정과정 등을 파악한다.

- 3) 현재 시행중인 노인 건강대책의 사업범위 및 주요 사업영역(프로그램)을 파악한다.
- 4) 노인 건강관리를 위한 정책 및 사업범위의 우선순위 설정을 위한 기준을 마련하고 이에 의해 우선순위를 설정한다.
- 5) 근거중심의 노인 건강증진을 위한 종합대책 및 관리방안의 주요 장·단기 목표 및 실행목표를 개발한다.
- 6) 노인 건강증진의 목표를 달성할 수 있는 국가차원 및 지역사회(보건소)차원에서의 관리전략과 평가지표항목을 개발하여 효과적인 추진전략을 제시하였다.

제 2 장 국내·외 현황

1. 국외 사례

- 국가 전반에 걸친 질환관리체계에 대한 논의는 알마아타 선언 이후, 선진국에서는 국가차원의 건강증진 및 질병예방의 국가보건의료계획을 수립하기 시작하였다. 그러나 노인을 위한 별도의 정책을 따로 수립하는 경우는 일본의 일부 정책을 제외하고는 없었다.

1) 미국

- (1) 미국의 Health Plan 2010에서 제시하고 있는 10대 보건지표(Health Plan 2010)는 다음과 같다.

- 운동
- 과체중과 비만
- 흡연
- 약물남용
- 책임성 있는 성행태
- 정신보건
- 상해와 폭력
- 환경보건
- 예방접종
- 보건의료에 대한 접근성

(2) 미국의 치매노인 복지정책

- 정부정책은 다음과 같은 3가지 기본 목표에 의해 이루어져 있다. 첫째는 보호의 접근을 향상시키는 것, 둘째는 비용을 억제하는 것, 셋째는 보호의 질을 확보하는 것이다.

- 미국 치매정책의 주요 현안은 문제의 예방·진단·치료를 위한 연구의 촉진과 환자에 대한 서비스전달의 용이성 등이다.
- 미국의 치매관리정책은 의뢰체계의 확립 및 통합적 서비스 제공체계의 정립에 역점을 두고, 치매노인의 상담단계에서부터 가능한 빨리 서비스 계획을 수립하고자 하는 것이다. 즉 의학적 평가를 수행할 당시에 환자의 평가와 이에 따른 장기요양 서비스 계획, 사회 서비스에 연계시키는 서비스 체계를 수립하고, 이를 통해 치매노인의 요구 변화에 따라 서비스를 제공하도록 이를 통합하는 노력을 기울이고 있다. 서비스 내용을 보면 다음과 같다.
 - 재가보호 및 가족지원 프로그램인 가정중심의 서비스
 - 상담 서비스
 - 주간보호자나 가족들을 위한 지지집단
 - 노인일일보호 및 단기간 주거보호 등

2) 영국의 national policy(Key Topics in public health, 2005)

- Cancer
 - White Paper Saving Lives(1999): 'to reduce the death rate from cancer in people under 75 years by at least a fifth by 2010- saving up to 100,000 lives in total'
 - cancer services;
 - preventive services such as screening;
 - key determinants of general health and exposure to specific carcinogens (smoking, diet, alcohol etc.).
- Coronary heart disease and stroke
 - 'to reduce the death rate from CHD and stroke and related diseases in people under 75 by at least two-fifths by 2010'
- Diabetes
- Smoking

- Obesity
- Physical activity
- Injury prevention
- Drug alcohol use and misuse
- Mental health
- Inequality in health

3) 노인을 위한 질병예방과 건강증진(HEALTH PROMOTIONS)

- Hypertension screen(혈압측정)
- Environmental screen for safety issues(안전한 주거환경)
- Apnea during sleep screen(수면 무호흡증)
- Loss of weight(체중감소)
- Tetanus vaccination(파상풍예방접종)
- Hear in a noisy environment(청력)
- Pain screen and treatment(통증)
- Resistance and other exercise(운동)
- Osteoporosis screen(골다공증)
- Mood (depression) screen(우울증)
- Occult blood in stool(잠혈)
- Testosterone deficiency(호르몬검사)
- Influenza and pneumococcal vaccination(인플루엔자예방접종)
- Oral screen(구강검사)
- Nicotine education(smoking)(금연)
- Sugar screen(당뇨병)

4) Swedish Health Promotion for The Elderly

- Health promotion in healthy elderly
 - Intentions of general community and life style interventions : Healthy environment, Individual such as stress reduction, reduce tobacco and alcoholic use

- Preventive medical intervention programs : Focus on cardio-vascular prevention such as hypertension and hyperlipidemia, cognitive assessment (70 year of age), Fall prevention programs, Preventive home visits
- Health promotion in disabled elderly
- Major health problems in the elderly
 - Dementia
 - Cardio-vascular disorders
 - Musculo-skeletal disorders
 - Infections, psychiatric disorders such as depression, COPD

5) 일본

(1) '건강일본 21' 사업

- 후생성이 2010년을 목표로 2000년부터 실시
- 제3차 건강증진 사업
- 식생활(영양), 신체활동(운동), 휴양(마음의 건강), 담배, 알코올, 치과, 당뇨병, 순환기계 질환, 암 등 9개 분야에 구체적 지표 설정

(2) Gold Plan 21

- 활력 있는 고령자상 구축
- 고령자 존엄의 확보 및 자립지원
- 서로 돕는 지역사회 형성
- 이용자로부터 신뢰를 받을 수 있는 개호서비스 확립

(3) 일본의 특정건강진단

- 40-74세 의료보험가입자 약 5,600만명(2008년 실시)
- Metabolic syndrome(내장지방증후군)에 주목한 건강진단 High risk approach

<표 7> 일본의 특정건강진단 항목

기본항목	정밀검사 항목
·질문표(복약력, 흡연력 등)	·의사가 필요하다고 인정한 경우 실시
·신체계측(신장, 체중, BMI, 복위)	·심전도
·혈압측정, 이학적 검사(신체진찰)	·안저검사
·소변검사(뇨당, 뇨단백)	·빈혈검사 (적혈구, 혈색소량, 헤마토크리트)
·혈액검사: 지질검사(중성지방, HDL-콜레스테롤, LDL-콜레스테롤), 혈당검사(공복시 혈당 또는 HbA1c), 간기능검사(GOT, GPT, γ -GTP)	

(4) 특정 보건지도

- 특정건강진단 결과에서 생활습관병의 발생 위험이 높은 경우, 생활습관의 개선에 따른 생활습관병의 예방효과를 기대할 수 있도록 도움
- 특정보건지도에서는 위험 정도에 따라 동기부여 지원과 적극적인 지원으로 구분
- 처음 면접: 개별면접은 20분, 이상, 8명이하의 그룹 면접은 80분 이상
- 동기부여 지원: 스스로(행동목표) 생활습관 개선을 실천토록 함
- 적극적 지원: 면접, 전화, 메일, 팩스, 편지 등을 이용하여 생활습관 개선을 지원(약 3개월)
- 실적 평가는 개선상황을 6개월 후에 확인

(5) 일본의 치매노인 복지정책

- 일본의 치매노인 복지정책은 1986년에 '치매성 노인대책본부'를 후생성에 설치하고, 치매노인에 대한 조사, 연구, 치료, 관리방법 등에 대하여 정부가

10개년 계획을 실시하였다. 특히 치매노인 복지서비스에 대한 비용을 부담하기 위한 방안으로 2000년부터 개호보험(care insurance)을 실행하였다.

- 일본의 경우 치매관리를 위해 보건소에 ‘서비스 조정추진위원회’를 설치하였고, 이를 통해 지역사회 내에서 일원적이고 체계적인 서비스 체계망을 구축하였다. 또한 치매를 노인대책의 일환으로 지역사회를 중심으로 서비스 체계를 구축하여 왔다. 일본은 다른 나라에 비해 거택 서비스가 잘 발달되어 있어서 가능한 가정을 중심으로 치매관리가 이루어지도록 하고 있다. 1991년부터는 모든 보건소와 노인 종합상담센터의 상담원이 치매노인과 그 가족의 고충에 대한 상담을 하고 있다.
- 노인요양시설은 인구 약 3만 명당 1개소를 갖도록 되어 있으며, 정부가 75%에 해당되는 건축비를 지원한다.
- 치매환자를 위한 보호서비스
 - 가정봉사원 파견
 - 치매노인가족에 대한 세제혜택
 - 방문지도 및 방문간호
 - 주간보호와 야간보호
 - 기능훈련
 - 특별양호노인홈
 - 단기입소
 - 일상생활 영구대여
 - 주택개조

6) 호주의 치매노인 복지정책

- 호주의 경우 노인을 위한 정신건강 서비스는 가능하면 지역사회에서 제공되며, 더 이상 독립된 생활이 불가능한 경우에만 병원에 입원하거나 시설

에 입소하게 된다. 지역사회 내에서 노인이 정신건강에 문제를 가지는 경우 가정의(family doctor)나 PGAT(psychogeriatric assessment and treatment) 서비스에 도움을 구할 수 있다. 기억력의 장애로 치매가 의심되는 경우에는 노인관리 평가팀(aged care assessment teams: ACAT)이 포괄적인 치매 선별검사를 수행한다.

- ACAT는 호주정부에 의해 주로 재정적 지원을 받으며 전국적인 연계망(120여 개)을 갖고 있다. ACAT의 기능은 노인 또는 치매노인의 상태 및 복지요구도를 평가하고 재가 또는 주거보호서비스에 관한 정보를 제공하며 또는 필요한 지원을 한다. 지역별 팀은 의사(주로 노인병 전문의사), 간호사, 사회복지사, 작업요법사, 물리치료사로 구성되어 있다.
- 가정·지역사회 복지(home and community care, HACC): 가정과 지역사회 관리자를 통해 가정에 있는 노인과 이를 돌보는 사람들에 대한 가정봉사 서비스를 제공한다. 서비스는 가정에서의 도움(청소, 요리, 목욕과 옷입기 등의 자기관리), 가전도구 수리와 같은 가정관리, 가정으로 배달되는 식사, 쇼핑도움, 교통, 지역사회 의료서비스, 지역사회 간호 등을 제공한다. 치매노인에게 제공된 서비스의 결과에 대하여 정기적으로 표준 감시방문을 시행하여 서비스의 만족도 여부를 평가하고 있다. 이러한 체계적인 관리를 통하여 치매노인 각자에게 적절한 서비스를 제공하고, 또 제공된 서비스에 대하여 객관적인 기준에 따른 정기적인 평가를 통하여 서비스의 적절성과 질 관리를 하고 있다.

7) 네델란드의 치매노인 복지서비스

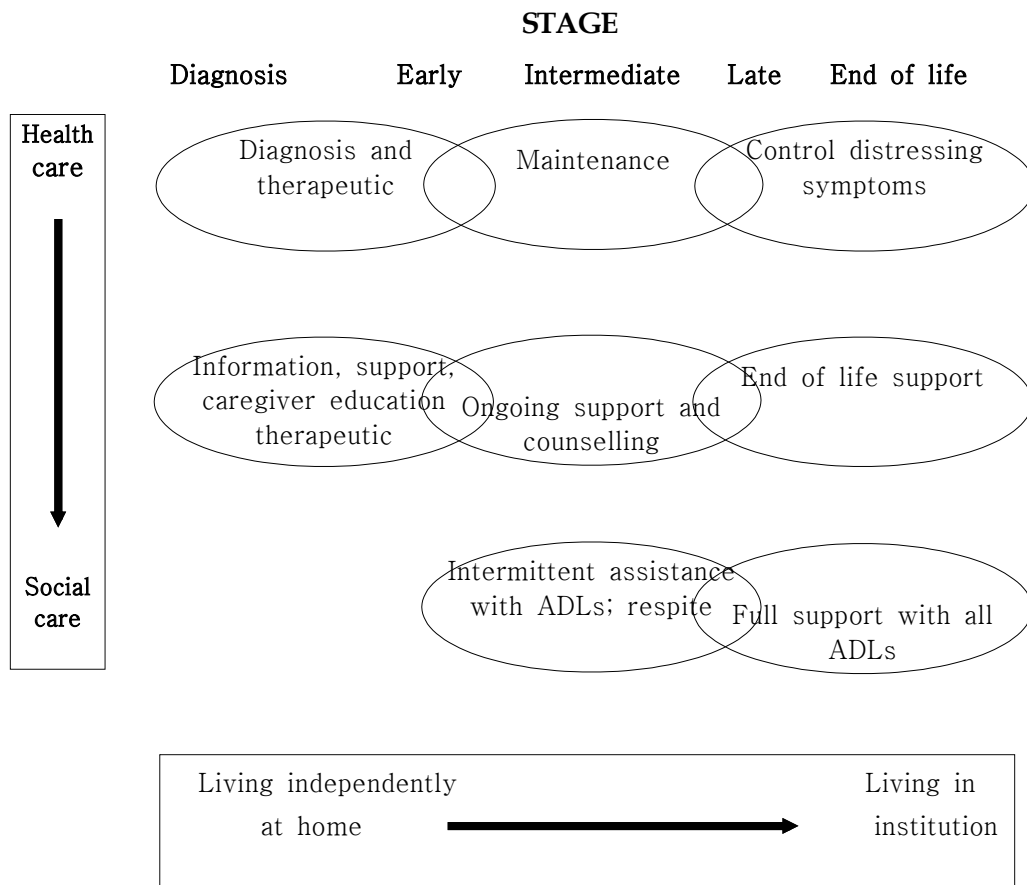
- 사례관리서비스(case management): 치매가족의 부담을 줄이고 치매노인이 가정에서 더 많은 시간을 체류하도록 하는 목적으로 지역간호사 제도를 실시하고 있다. 이는 사례관리자를 통하여 가정을 방문하여 치매환자에 대한 최적의 보호계획을 세워주며 가족의 부담을 줄이는 서비스를 제공한다.
- 휴식보호(respite care): 장기보호병원, 노인보호센터 및 가정간호 조직 등은 가족을 위한 휴식보호를 제공하고 있다

- 중간보호시설: 요양시설과 독립적 주거사이의 중간시설의 성격을 띤 Gray Area가 되어 지방정부, 보호 서비스그룹, 주택회사의 협력을 통해 운영되며, 대개 75-150개 아파트 세대로 구성, 각 세대는 2-3개의 방을 지니고 있어 독립적 주거형태의 삶을 영위할 수 있다.
- 그 외 간호보호센터, 24시간 보호 서비스 등이 있다.

8) common policy principles in relation to dementia

(source: Marshall 1999, Riggs 2001)

- remain at home as long as - delay institutionalization
- support carers in order to achieve this
- patients need as much control over their care as possible
- co-ordination of services at local level where possible
- institutional care, when required, should be as home-like as possible
- equate service provision with need
- early diagnosis should be encouraged



SETTINGS

<그림 5> Care continuum for dementia patients

2. 국내 사례

1) 만성퇴행성질환 국가관리체계 구축연구(정두채, 건강증진기금 연구, 1998)

- 만성퇴행성질환의 실태파악 및 분석
- 관리 모형에 근거한 만성퇴행성질환 국가관리체계안 제시
- 공공부분 만성퇴행성질환 관리를 위한 구체적 실시방안 제시

- 만성퇴행성질환의 국가의 행정조직체계는 질병관리본부를 중심으로 한 국가전반의 자원이 동원되는 체계이며, 구체적 조직체계로는 만성퇴행성질환관리 업무영역을 가진 질병관리과와 국립보건원의 기초연구 영역을 통합하는 체제 정비가 필요하다.

- 또한 국가 관리체계 안에서 중앙정부의 역할에 대해 질병관리과를 중심으로 단계적인 역할 확대 범위를 제시하였다.

1단계: 만성퇴행성질환의 중요성 평가를 위한 정책 수행

2단계: 측정 가능한 만성퇴행성질환 관리 목표 설정을 위한 정책 수행

3단계: 만성퇴행성질환관리를 가능하게 하는 실천 전략 개발 및 평가를 위한 정책 수행

4단계: 초기만성퇴행성질환관리 활동의 우선순위 결정을 위한 정책 수행

- 보건소의 만성퇴행성질환 관리의 현황분석을 통해 보건소에서 우선적으로 실시하여야 할 만성퇴행성질환으로 고혈압과 당뇨병을 선정하고, 등록사업 중심의 고혈압 및 당뇨병 관리체계를 구성하였고, 보건소 환자 등록사업 창구를 통해 고혈압과 당뇨병 관리의 핵심인 환자의 건강관련 행위 및 태도의 변화를 위한 보건교육과 환자 추구관리 체계를 개발하였다.

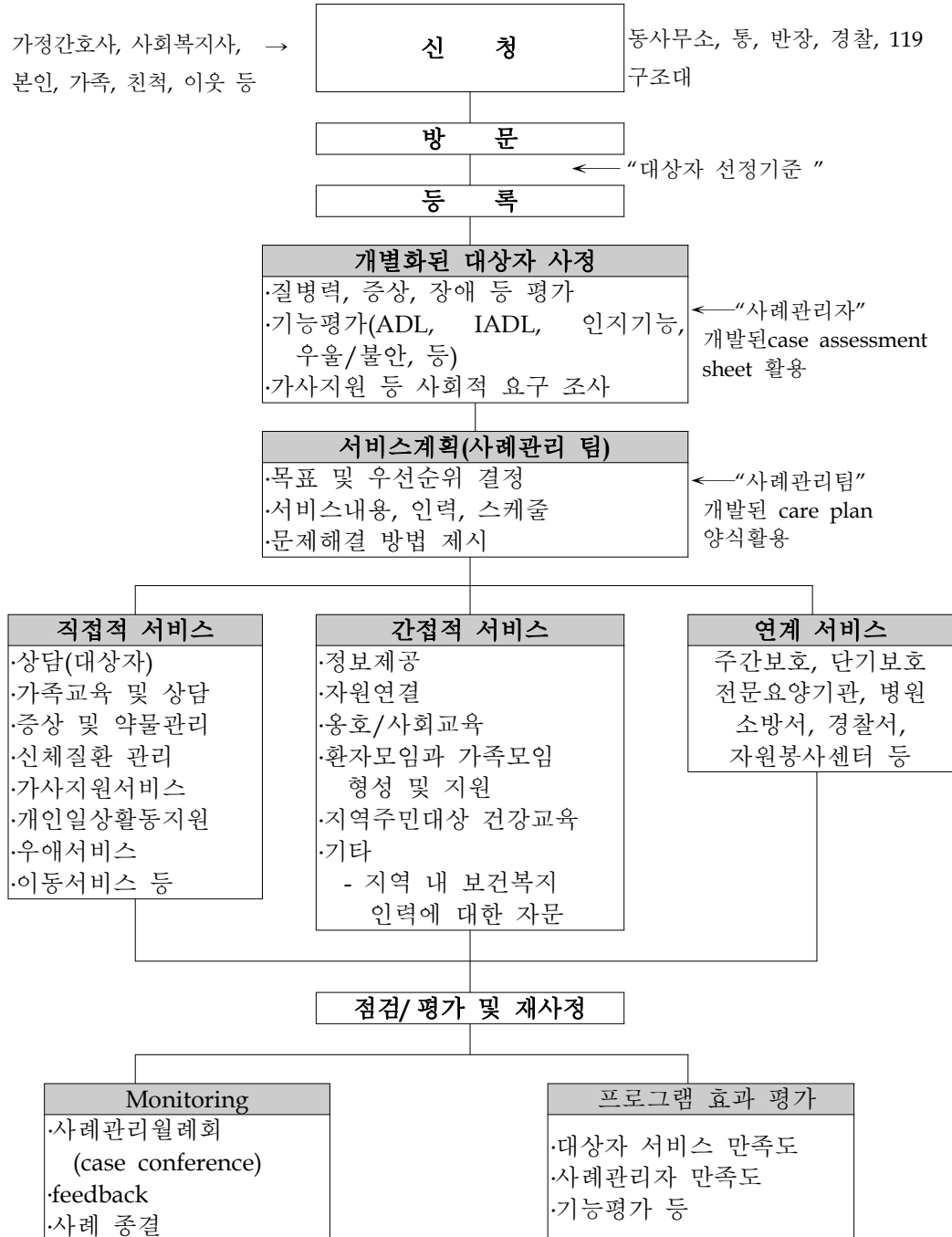
2) 사례관리기반 보건복지통합프로그램 개발(이정애, 건강증진기금연구, 2003)

- 이 연구에서는 우리나라의 보건복지 조직이 분리되어 있어 조직간 연계나 통합이 쉽지 않은 점을 감안하여 '사례관리' 방식을 도입하여 보건복지서비스 통합을 시도하였다. 사례관리는 상이한 보건복지서비스 제공자간의 구조적 장벽을 극복하면서 욕구에 따른 서비스제공을 가능하게 할 수 있는 방법으로서 특히 복합적인 욕구나 문제를 가진 농촌노인들을 대상으로 보건기관과 복지기관 및 지역사회 자원(공식적, 비공식적)의 협력을 통해 지속적이고 효율적인 서비스를 제공하는 데에도 효과적인 것으로 평가되었다.

- 이 연구에 의하면, 직접 서비스를 주는 인력간의 협력을 통한 사례관리 서비스는 다음과 같은 가능성을 보여주었다.
 - 협력상대 전문직(보건의료와 복지) 업무에 대한 이해와 경험의 기회 증대
 - 서비스 접근성의 향상
 - 대상자의 요구에 맞춘 질적 서비스 제공
 - 노인과 가족의 만족도 증대
 - 지역사회에 관심 제고 등이었다.

- 그러나 이 프로그램을 일개 군에서의 연구사업이기 때문에 다른 지역으로의 확대를 위해서는 몇 가지의 문제점을 여전히 가지고 있다.
 - 서로 다른 기관들의 통합/연계를 위한 중심 역할을 할 수 있는 기관 부재와 역할분담의 미비
 - 서비스 제공자들의 사례관리에 대한 체계적이고 지속적인 교육의 필요,
 - 정보체계와 지역자원들의 네트워크 구축의 미비
 - 지역공무원 및 주민들의 참여 부족 등

- 위와 같은 문제들을 해결하기 위하여 개발된 모형을 실용화하고 확대하기 위한 전략이 필요하며, 또한 현재 각 시도 보건소에서 시범적으로 추진 중인 ‘보건복지연계사업’과도 경험을 공유함으로서 좀 더 현실적이고 실현 가능한 모형을 정형화할 수 있을 것으로 생각한다.



<그림 6> 사례관리 기반 보건복지 통합 프로그램의 흐름도

3) 노인건강증진 허브보건소 사업(이정애, 건강증진기금연구, 2006)

- 2006년도 사업 기간이 짧았기 때문에 16개 보건소의 전체 사업의 효과를 평가 하기에는 무리가 있었으나, 경로당 및 시설을 중심으로 운동 프로그램을 실시한 노인그룹에서는 기초조사시보다 모든 지표가 개선되었다.
- 노인건강증진허브보건소 사업참여자(대상노인) 만족도 조사에서 “만족 또는 매우 만족한다”(90%이상)고 대부분 응답하였고, 사업의 지속성과 새로운 사업으로 영양과 스트레스 관리의 요구가 많았다.
- 자문위원회에서도 2007년 추가하는 프로그램이나 서비스로 영양 영역(평가기준/프로그램)과 건강체력평가(평가기준/프로그램) 대한 의견이 있었다.
- 노인건강증진허브 보건소사업의 차별성
 - 기존의 노인보건사업 등과의 명료한 차별성과 역할 정립의 필요성에 따라 앞에 언급한 것과 같이 다른 점 및 개념의 틀을 정립하였다.
 - 일본의 개호예방사업처럼 경미한 허약노인을 주 대상으로 건강관리능력을 향상시켜 요양/수발이 필요할 만큼 건강이 악화되지 않도록 예방하는데 주력을 하는 것이 중요한 전략이 될 수 있다.
- 노인건강수준을 평가하는 도구와 기준, 기준에 따른 신체활동 프로그램의 제시하였다.
 - 미국의 노인신체적성평가도구(SFT)의 기준을 적용한 결과, 허약하다고 평가되는 노인이 대다수를 차지하고 있어서 우리나라 노인에 적합한 신체적성평가 기준의 마련이 시급하였다.
- 담당자 교육/훈련을 실시
 - 담당자 교육을 실무적인 기술뿐 아니라 사례 중심의 프로젝트관리 기술을 병행하여 추진

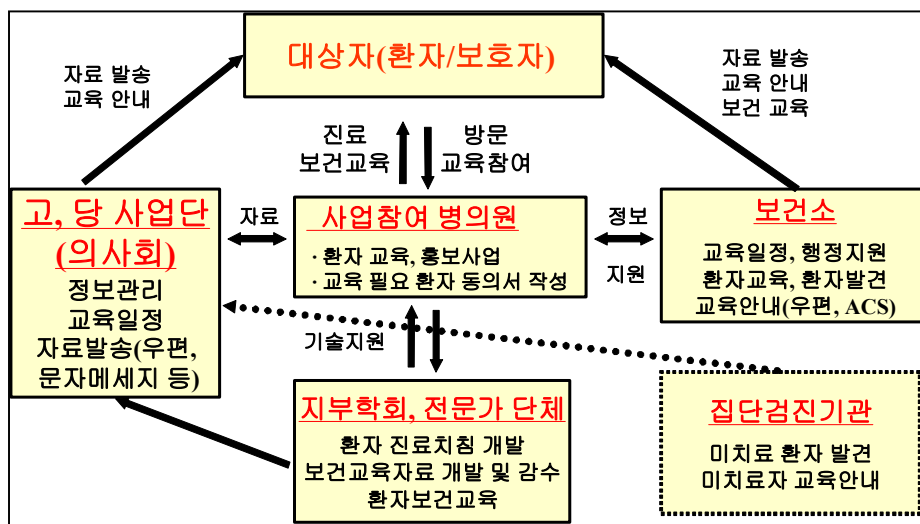
- 특히 다른 단위사업에서 소홀히 다루어지기 쉬운 추구관리, 지역사회 연계와 관련된 교육을 강화
 - 사업단의 현장지도를 강화하고, 자문위원 1인당 1보건소 이상 정기적으로 모니터링하고 지도하도록 유도
- 사업 평가 모형
 - 목표의 위계화에 따른 결과평가(최종목표 : 삶의 질, 이환 및 의료이용, 중간/영향목표 : 규칙적인 신체활동/운동습관을, 영향목표 : 신체/정신/사회적 건강)와 평가의 스펙트럼(총괄적 평가와 프로그램별 평가), 결과에 이르는 절차 및 체계에 대한 평가 구조평가(사업운영/추진체계 등)를 고려한 평가 모형을 개발 중
 - 단기간 사업을 수행하였음에도 상당한 성과를 거둔 것으로 평가되며, 2차년도 사업을 통해 장기발전을 위한 초석을 다질 수 있을 것으로 사료된다.

4) 대구시 만성질환(고혈압, 당뇨병, 고지혈증) 관리사업(대구광역시 만성질환 관리사업단, 2008)

- 사업대상
 - 1차 예방사업은 지역사회 전 주민을 대상
 - 2차 예방사업: 병·의원과 보건소를 이용하는 고혈압·당뇨병 환자, 발견된 의료 미이용환자(검진경험자), 새로이 발견된 환자
- 교육내용
 - 고혈압, 당뇨병 질병관리
 - 고혈압, 당뇨병 관리를 위한 위험요인 관리
 - 고혈압, 당뇨병 관리를 위한 영양관리 등
- 고혈압·당뇨병 관리 수첩
 - 고혈압, 당뇨를 함께 관리할 수 있는 통합 형태로 개발하여 개인별 측정치 기입, 그래프를 통한 시각적 효과 및 흡연, 음주, 운동 등의 건강 위험행위를 체크할 수 있도록 디자인 함

- 사업성과

- 표준 진료지침 개발과 보급으로 인한 의료의 질 향상
- 주민의 건강관심도 증가로 건강도시 기반 마련
- 지역사회자원의 네트워크 구축으로 자원 활용의 효율성 증가
- 민간과 공공부문의 파트너십 형성으로 상호 신뢰도 증가 → 민간 병의원의 참여가 확대되고 있음, 대구광역시 의사회가 ‘건강대구’ 프로젝트 추진 선포(2005.3.3)
- 사업효과의 계량적 평가 기반 마련
- 국제수준의 연구 가능으로 지역 대학의 위상 제고



<그림 7> 대구광역시 고혈압·당뇨병 관리사업 네트워크 구축 개념도

제 3 장 연구수행 내용 및 결과

제 1 절 연구 대상 및 방법

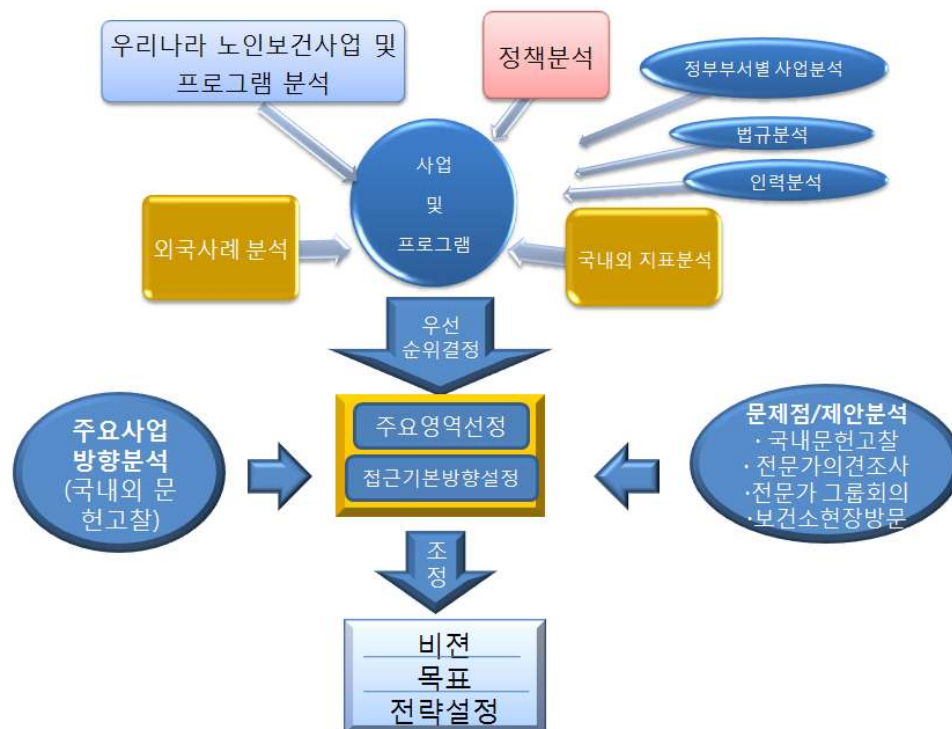
1. 연구 대상

- 1) 우리나라 노인의 건강상태, 질병상태, 유병율, 노인의료비, 사망원인을 분석하기 위하여 통계자료, 연구보고서 등을 파악하였다.
- 2) 주요 선진국가의 노인건강 정책관련 정보를 분석하고 정리하였다.
- 3) 보건복지가족부의 각 부서별 노인관련 정책과 사업내용 그리고 의사결정 과정 등을 파악하였다.
- 4) 우리나라 노인 건강관련 법령을 조사하였다(의료법, 노인복지법, 국민건강보험법, 건강증진법, 기타).
- 5) 노인에게 직접 서비스를 제공하는 보건소에서의 노인보건사업의 종류와 관리실태 그리고 문제점 등을 조사하였다.
- 6) 전문가(중앙부처, 전공교수, 보건소 실무자 등)의견, 전문가 그룹 회의 및 세미나 등을 개최하여 노인건강 문제에 대한 우선순위 결정 기준 및 우선순위를 설정하였다.
- 7) 우선순위 결정 기준에 대한 외국자료를 수집 분석하였다.

2. 연구 분석의 틀

우리나라 노인보건사업 및 프로그램의 분석, 정책분석, 정부부서별 사업분석, 노인관련 법규 분석, 노인관련 인력 분석, 국내외 지표 및 외국사례 분석을 통하여 우리나라 노인관련 정책의 문제점을 파악하였다. 노인건강에 대한 공중보건학적 우선순위 결정과정을 통해 우선순위를 결정하였으며, 결정된 우선 순위의 주요 영역에 대한 기본 접근방향을 설정한 후 국내외 문헌고찰을 통한 주요사업 방향 분석과 전문가 의견조사 및 그룹회의, 보건소 현장

방문을 통하여 도출한 문제점과 제안을 분석하여 결정된 우선순위를 다시 조정하여 본 연구의 비전과 목표, 전략을 설정하였다.



<그림 8> 연구 분석 과정

1) 문헌 고찰

문헌 고찰은 노인건강관리 관련 국내외 선행 연구를 중심으로 우리나라 노인의 건강상태, 질병상태, 유병률, 사망원인 등을 조사하고 비교하였다. 또한 우리나라 노인건강 관련 통계자료, 법령 및 기타 정보를 분석하고 정리하였다.

2) 직접 조사

(1) 보건소 현장 방문실시

: 전남과 광주 지역 보건소는 직접 현장 방문 조사하였다.

(2) 전국의 보건소를 대상으로 노인 건강관리사업의 종류와 사업대상, 참여도와 수용도, 운영 시 문제점들을 우편 설문조사하였다.

(3) 복지부의 정책 및 사업분석 그리고 의사결정과정 등은 전문가 의견을 듣고 분석하였다.

3) 노인 건강문제에 대한 공중보건학적 주요 영역 선정

(1) 주요 선진국가의 노인건강 정책관련 우선순위 결정방법을 분석

(2) 우리나라 노인건강 관련 정책 결정과정 및 환경 분석

(3) 공중보건학적 우선순위 방법에 의해 우선 주요영역을 설정한 후 국가비전, 목표 및 지표 항목 등을 개발하였다.

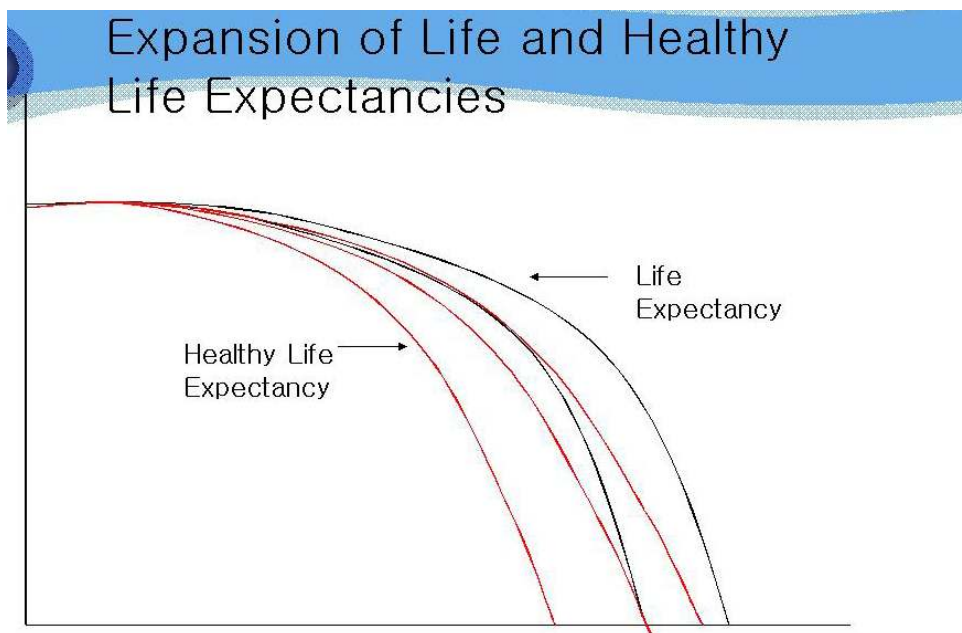
제 2 절 연구 내용 및 결과

1. 노인의 건강상태, 만성질환 유병률, 노인의료비 등 조사

1) 평균수명과 건강수명

□ 평균수명(life expectancy) 증가에 비해 건강수명(healthy life expectancy)은 매우 짧아 노인 케어의 부담이 급증

- 활동제한이 없는 건강여명은 남자는 63.3세, 여자는 65.4세로 아직은 일본에 비해 10년은 짧음(한국보건사회연구원, 2004). 평균수명과 건강수명이 함께 증가하지만 건강수명 증가는 평균수명 속도에 미치지 못하여 장기간의 노년기를 질병과 장애로 인해 의료비, 복지비 등의 부담이 급증하게 될 것이다.



<그림 9> Life expectancy and healthy life expectancy(조영채, 건강보험 30주년기념 국제세미나, 2006)

- 우리나라의 현재(2000년) 남자의 평균 수명은 75.9세, 여자는 79.5세이고, 2050년에는 남자는 80세, 여자는 86.2세로 평균수명은 점차 증가할 것으로 예상하고 있다.

<표 8> 평균수명 추이

(세, 천명)

평균수명	1971	1981	1991	2000	2010	2020	2030	2050
계	62.3	66.2	71.7	75.9	78.8	80.7	81.5	83.0
남 자	59.0	62.3	67.7	72.1	75.5	77.5	78.4	80.0
여 자	66.1	70.5	75.9	79.5	82.2	84.1	84.8	86.2
사망자수	238	238	250	247	298	390	500	732

2) 노인의 건강행태

- 노년기 건강은 청소년부터 청장년기까지의 건강관리에 좌우되나, 노인의 건강행태가 여전히 불량하고 스스로 건강을 개선하려는 노력 미흡하다.

<표 9> 노인과 30세 이상 일반성인의 건강행태

(단위: %)

항 목	노인	일반 성인
흡연율	19.7(남자 31.9, 여자 6.9)	28.9(남자 52.3, 여자 5.8)
고위험 음주율	22.1	61.2
규칙적 운동 실천율	21.7	32.2
적정체중 유지율	49.6	43.5
고혈압 관리율	27.2	51.0
당뇨 관리율	22.7	26.2

자료: 2005 국민건강영양조사

3) 만성질환 유병률

□ OECD(27개) 국가 중 뇌졸중 사망률은 4번째로 높고, 당뇨사망률은 10만명당 31.5명으로서 1위(OECD health data, 2007)

- 「2004년 전국 노인생활실태 및 복지욕구조사」에 따르면, 65세 이상 노인 중 90.9%가 만성퇴행성 질환을 가지고 있으며, 질병별로는 관절염(43.1%), 고혈압(40.8%), 요골·좌골통(30.6%), 신경통(22.1%), 골다공증(18.9%), 백내장(18.1%), 소화성궤양(16.5%), 빈혈(15.9%), 당뇨병(13.8%), 디스크(12.6%)의 순서로 유병률이 나타났다(한국보건 사회연구원, 2004).
- 이러한 만성질환을 앓고 있는 노인 중에서 만성질환으로 인하여 힘든 점(통증 제외)이 있다는 노인이 50.8%이며, 그 어려움으로는 일상생활수행의 제한이 43.3%로 가장 많았다. 노인에게서 일단 만성 퇴행성질환이 발생하게 되면 이 질환의 특성으로 인해 일상생활에서도 자립성과 활동성을 상실하게 되어 다시 회복할 수 없는 삶의 질 저하를 초래한다.

<표 10> 노인의 만성질환 유병률

(단위: %)

구분	전체	성별		연령(세)		
		남	여	65-69	70-74	75이상
없다	9.1	15.6	5.0	10.3	7.9	8.7
있다	90.9	84.4	95.0	89.7	92.1	91.3
1개	17.1	25.9	11.5	20.9	15.6	13.4
2개	19.0	21.3	17.5	18.9	17.4	20.7
3개 이상	54.8	37.1	66.0	49.8	59.1	57.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(명)	(3,029)	(1,171)	(1,858)	(1,214)	(903)	(911)

자료: 한국보건사회연구원, 2004년도 전국노인생활실태 및 복지욕구조사 자료

<표 11> 65세 이상 노인의 다빈도 만성질환

(단위: %)

질환명	전체	남자	여자
관절염	43.1	21.8	56.6
고혈압	40.8	34.4	44.8
요통, 좌골통	30.6	18.6	38.1
신경통	22.1	14.9	26.5
골다공증	18.9	3.5	28.6
백내장	18.1	11.3	22.4
소화성궤양	16.5	12.0	19.3
빈혈	15.9	8.3	20.7
당뇨병	13.8	12.3	14.8
디스크	12.6	8.0	15.4

* 3개월 이상 앓고 있는 질환

자료: 한국보건사회연구원, 2004년도 전국 노인생활실태 및 복지요구 조사 자료

4) 노인의 입원 및 외래 다발성 질환 순위

- 노인이 가장 많이 입원한 질환은 노인성백내장으로 99,266명이 입원하여 1,178억원의 진료비를 지출하였고 그 다음은 뇌경색, 폐렴, 당뇨병, 협심증 순으로 입원함. 1인당 진료비가 가장 많은 질환은 대퇴골 골절로 4,233,643원이었고, 위암 3,419,569원, 협심증 2,641,247원, 뇌경색 2,349,972원 순으로 지출되고 있다.
- 노인이 외래를 가장 많이 이용한 질환은 감기로 1,876,093명이 방문해 947억원 진료비를 사용했으며, 본태성고혈압 1,182,304명이 이용해 1,296억원 사용함. 1인당 진료비가 가장 높은 상병은 당뇨병으로 연간 140,015원이었고 무릎관절증 124,288원, 본태성고혈압 109,654원이었다.
- 이러한 노인의료비의 과중한 부담은 국민의료비 증가와 함께 가정과 국가 경제에 큰 부담을 주고 있다(건강보험심사평가원, 2005).

<표 12> 노인의 입원 다발성 진료 순위(2007년)

순위	상병명	진료 인원(명)	내원일수 (일)	진료비 (백만원)	1인당 진료비(원)
1위	노인성백내장	132,228	213,352	117,839	1,312,719
2위	뇌경색(중)	57,581	2,733,286	249,898	4,339,934
3위	폐렴	32,318	555,667	75,480	2,335,545
4위	협심증	29,052	226,898	102,931	3,542,998
5위	당뇨병	27,599	744,712	54,576	1,977,477
6위	무릎관절증	25,899	608,710	150,328	5,804,401
7위	기타 척추병증	22,726	400,810	55,168	2,427,539
8위	요추 및 골반골절	22,469	446,766	39,981	1,779,406
9위	고혈압	22,100	779,864	35,987	1,628,374
10위	골절	20,155	342,603	30,544	1,515,461

주: 지급기준, 분만실적은 제외
자료: 국민건강보험공단, 2008

<표 13> 노인의 외래 다발성 진료 순위(2007년)

순위	상병명	진료 인원(명)	내원일수 (일)	진료비 (백만원)	1인당 진료비(원)
1위	본태성고혈압	1,613,165	14,096,169	189,160	117,260
2위	배통	903,547	7,288,944	106,105	117,432
3위	무릎관절증	896,316	8,651,275	147,245	164,278
4위	치은염및치주질환	852,037	2,066,292	36,841	43,239
5위	급성기관지염	760,852	2,270,140	25,652	33,715
6위	위염,십이지장염	725,572	2,306,710	32,481	44,767
7위	감기	592,869	1,591,259	14,025	23,656
8위	치수및치근단주위조직의질환	549,239	2,313,448	44,590	81,185
9위	당뇨병	538,529	4,626,677	75,919	140,974
10위	백내장	486,585	1,799,333	31,078	63,869

주: 지급기준
자료: 국민건강보험공단, 2008

5) 치매 환자수 및 진료비 추이

- 치매의 유병률은 의료와 사회복지의 필요 정도를 파악하는 데에 중요한 척도가 됨. '05년 65세 이상 노인 중 치매노인은 약 364천명(전체 노인의 8.3%)으로 고령화 진행과 더불어 치매환자는 지속적으로 증가할 전망이다.

<표 14> 우리나라 치매 노인수 추계(2000~2020)

(단위: 명)

연령	추계 치매노인 수				
	2000	2005	2010	2015	2020
65~69	30,299	37,937	40,494	47,778	60,711
70~74	42,241	56,247	70,010	75,961	89,692
75~79	83,331	103,976	136,246	170,985	184,510
80세이상	121,877	165,628	213,694	285,326	368,977
치매노인수	277,748	363,789	460,444	580,050	703,890
치매유병률(%)	8.2	8.3	8.6	9.0	9.0

주) 1. 통계청, 「장래인구 특별추계결과」, 2005.1

2. 한국보건사회연구원, 치매관리 Mapping 개발연구, '97.12

<표 15> 우리나라 치매환자의 정도별 유병률

(단위: 명)

구 분	비 율	치매정도별 치매노인수 추계					비 고
		2000	2005	2010	2015	2020	
계	100.0	277,748	363,789	460,444	580,050	703,890	
경증	59.2	164,427	215,363	272,583	343,390	416,703	
중등증	27.2	75,547	98,951	125,241	157,774	191,458	
중증	13.6	37,774	49,475	62,620	78,886	95,729	

주) 경증 : 독립적인 생활영위 가능, 개인위생 유지, 비교적 온전한 판단력 보유

중등증 : 독립적인 생활이 위험하고, 타인에 의한 부분적인 감독과 간호 필요

중증 : 일상생활 수행능력 상실, 지속적인 감독이 필요, 개인위생 유지 불능

<표 16> 최근 5년간 의료이용 치매환자수와 진료비 추이

(단위: 명, 천원)

연도	진료실인원 (환자수)	총진료비	보험자부담금	법정 본인부담금	1인당 총진료비
2000	25,669	33,598,756.69	27,284,788.95	6,313,967.74	1,309
2001	35,481	44,385,176.25	36,019,331.23	8,365,845.03	1,251
2002	45,399	51,208,044.51	41,789,483.45	9,418,561.06	1,128
2003	54,032	65,317,999.09	53,216,953.30	12,101,045.79	1,209
2004	64,779	80,143,770.64	65,385,449.82	14,758,320.83	1,237

자료원: 건강보험통계연보, 2000,2001,2002,2003; 건강보험공단. 내부자료, 2005

주 : 본 자료는 건강보험과 의료급여를 합친 것임.

치매(주진단명) 관련 진단코드는 F00-F03임.

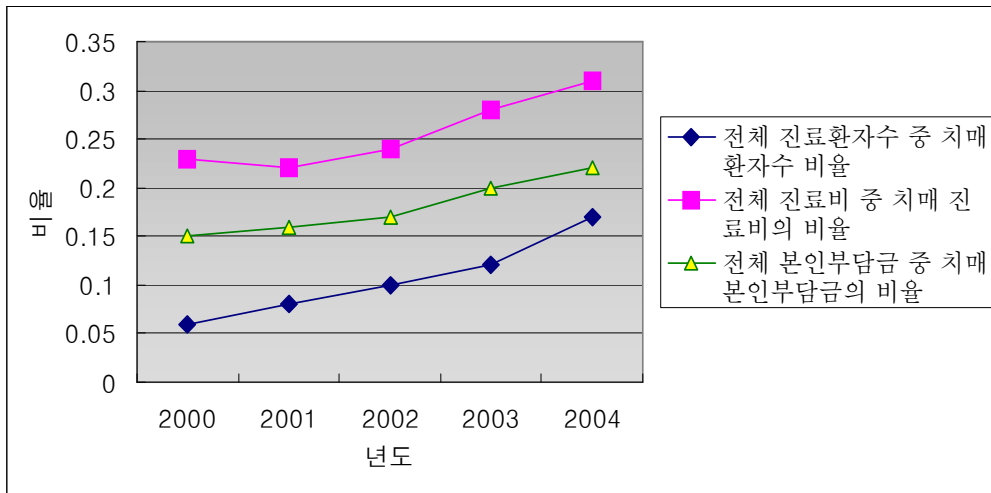
<표 17> 최근 5년간 건강보험급여 중에서 치매 환자수와 진료비의 비중

연도	1인당 총진료비 (천원)	전체 진료환자수 중 치매환자수 비율(%)	전체 진료비 중 치매 진료비의 비율(%)	전체 본인부담금 중 치매 본인부담금의 비율(%)
2000	1,309	0.06	0.23	0.15
2001	1,251	0.08	0.22	0.16
2002	1,128	0.10	0.24	0.17
2003	1,209	0.12	0.28	0.20
2004	1,237	0.17	0.31	0.22

자료원: 건강보험통계연보, 2000,2001,2002,2003; 건강보험공단. 내부자료, 2005

주 : 본 자료는 건강보험과 의료급여를 합친 것임.

치매(주진단명) 관련 진단코드는 F00-F03임.



<그림 10> 최근 5년간 건강보험급여 중에서 치매 환자수와 진료비의 비중

<표 18> 주요 국가의 성별, 연령별 인구 100명당 치매 유병률

남자	65-69세	65-69세	75-79세	80-84세	85-89세	90+세
미국	1.6	2.9	7.2	15.5	23.5	29.9
캐나다		4.5	8.2	15.1	22.6	30.4
호주	0.8	2.0	3.2	5.8	16.4	
영국	2.2		8.0		18.0	
프랑스			7.7	12.5	22.9	27.0
스페인	1.0	1.2	2.0	4.3	9.3	15.4
스웨덴	3.4		7.7		21.9	
일본	3.8					
여자	65-69세	65-69세	75-79세	80-84세	85-89세	90+세
미국	1.3	3.6	7.7	15.1	28.4	42.2
캐나다		4.6	9.1	17.4	28.1	41.1
호주	0.3	1.3	3.1	7.4	23.9	
영국	1.8		10.3		26.0	
프랑스			5.7	16.6	29.9	52.8
스페인	0.4	2.9	2.4	8.9	14.8	28.1
스웨덴	2.5		9.6		26.1	
일본	3.8					

1. 호주와 일본의 데이터는 Epi survey에 근거한 것임.(DSM-III-R 과는 별개)

2. 캐나다의 자료는 Ontario 주 만 해당됨

자료원 : Moise, et al. 2005

6) 노인인구의 기능장애

- 1998년 조사에 의하면 65세 이상의 전체노인 중 43.4%가 혼자서는 독립생활이 불가능한 노인으로 조사되었다. 즉 IADL만 제한된 노인은 11.5%이며, 31.9%의 노인이 최소한 한 가지 이상의 일상생활 수행능력(ADL)에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 또한 노인의 3.5%에 해당하는 약 15만 명이 일상생활을 위한 동작수행을 전혀 할 수 없는 것으로 조사되었으며 이렇게 높은 노인의 신체능력의 저하는 노인의료수요의 급증과 아울러 국가의 의료비용과 사회적 비용의 증대를 초래한다.

독립생활 가능노인 (56.6%)	독립생활 불가능 노인 (43.4%)		
	IADL만 제한노인 (11.5%)	ADL 제한노인 (31.9%)	
		ADL 일부제한 (28.4%)	ADL 모두제한 (3.5%)

<그림 11> 65세 이상 노인의 건강상태 및 기능장애 정도

주: 1) N = 2,224명

2) ADL : Activities of Daily Living

3) IADL : Instrumental Activities of Daily Living

자료 : 한국보건사회연구원, 1998년도 노인생활실태 및 복지욕구조사.

7) 노년기 삶의 질

2006년도 통계청이 발표한 우리나라의 평균 수명은 79세이고 건강수명은 68세로 점차 평균 수명은 증가하나 약 10년의 기간을 질환상태 또는 와병으로 남의 도움을 필요로 한다. 또한 급격히 증가하고 있는 만성질환으로 인한 활동장애 및 건강손실로 노년기 삶의 질이 급격히 저하되고 있다. 삶의 질 지수(EQ-5D, 1에 근접할수록 만족)는 19~44세는 0.95인데 반해 65~74세는 0.75에 불과하다. 더욱이 삶의 질을 저해하는 다빈도 질환의 발생이 늘어나고 있는데 노인의 44%가 안경을 써도 시력장애를 나타내며, 노인의 23%가 보청기를 사용해도 청력장애를 호소함으로써 사회적 활동에 제약을 받고 있다.

8) 사회계층간 건강격차가 심화됨

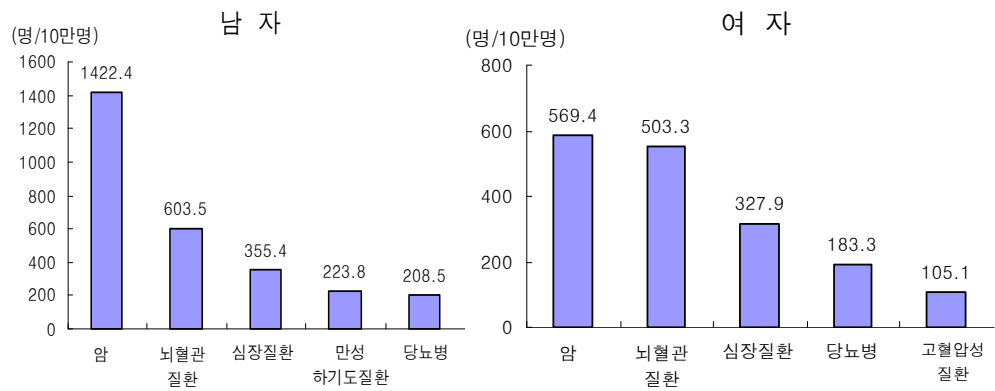
노인들에서 만성질환으로 인한 의료비용은 점차 증가하는데 많은 노인들에 있어 소득이 낮아 적절한 치료를 받지 못하고 있다. 즉, 빈곤은 질병의 악화로 연결되고 다시 질병은 빈곤으로 연결되는 악순환의 구조를 가지고 있다. 2008년 한국노동연구원이 발표한 자료에 의하면 노인(65~75세)이 빈곤가구에 속한 비율은 34.2%로 OECD 평균인 11.4%의 3개 수준에 달하고 있다. 또한

건강보험료 수준에 따라 10분위로 구분하였을 경우 가입자의 하위 10%가 진료실인원이 2007년도에 9만명으로 가장 많았다. 보험공단의 자료에 의하면 2002년 노인성질환자는 건강보험의 경우 10만명당 951명인데, 의료급여의 경우 4,168명으로 4.38배 많았고, 2007년의 경우는 4.61배로 지속적인 증가 추세에 있다.

노인의 소득계층별 뇌졸중 유병률(인구 1,000명당 명수)을 보면 하위층은 1998년도에 15.0명이었던 것이 2001년에는 18.2명으로, 2005년에는 27.1명으로 높은 증가율을 보이는 반면 상위층은 1998년도에는 11.6명에서 2001년에는 13.5명, 2005년에는 12.6명으로 하위층에 비하여 완만하게 증가하고 있다.

9) 노인인구의 사망원인과 사망률

- 2006년 65세이상 인구의 사망원인 1위는 암(악성신생물)으로 인구 10만명당 905.9명이 사망하였고, 다음은 뇌혈관질환(542.8명), 심장질환(338.8명) 순으로 나타났다.
- 성별로 보면, 남·녀 모두 암(악성신생물)으로 인한 사망이 남녀인구 각각 10만명당 1,422.4명과 569.4명으로 가장 많았다.
- 노인자살 증가: 70세 이상 노인인구의 자살사망률(2007)은 인구 10만명당 195.3명으로 전 연령층에서 가장 높은 수치였다.



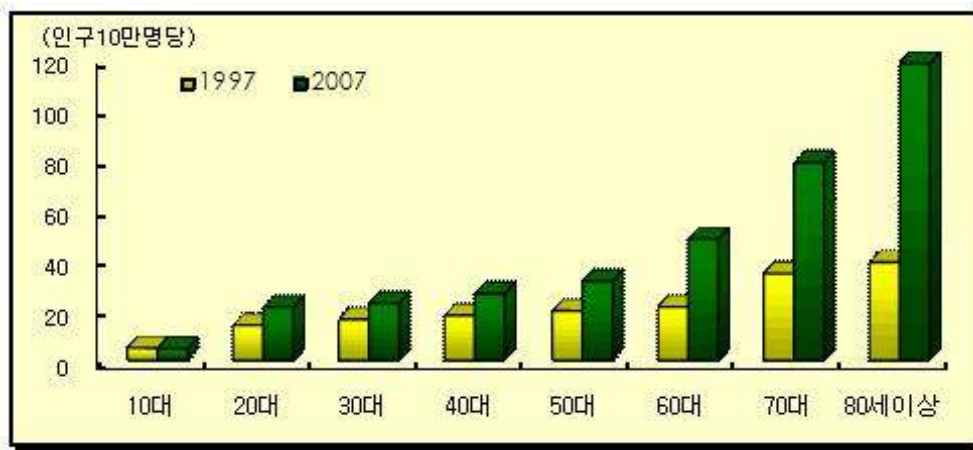
<그림 12> 65세 이상 인구의 사망원인(2006)

<표 19> 65세 이상 인구의 사망원인

(단위: 해당인구 10만명당 명)

	1 위	2 위	3 위	4 위	5 위
1986	뇌혈관 질환 1,101.0	암 676.1	고혈압성 질환 591.8	심장질환 499.9	만성 하기도 질환 208.6
1996	뇌혈관 질환 886.9	암 851.3	심장 질환 355.4	만성 하기도 질환 196.3	고혈압성 질환 178.5
2006	암 905.9	뇌혈관 질환 542.8	심장 질환 338.8	당뇨병 193.2	만성 하기도 질환 142.5
남	암 1,422.4	뇌혈관 질환 603.5	심장 질환 355.4	만성 하기도 질환 223.8	당뇨병 208.5
여	암 569.4	뇌혈관 질환 503.3	심장 질환 327.9	당뇨병 183.3	고혈압성 질환 105.1

자료 : 통계청, 「사망원인 통계」, 각년도



<그림 13> 자살 사망률 인구 10만명당(2007)

10) 노인 의료비 증가

□ 노인의료비는 7조4천억원으로 매년 증가 추세

- 2006년 65세이상 노인의료비는 7조4천억원으로 전체의료비의 25.9%를 차지하고 있으며, 매년 증가 추세를 보이고 있다.
- 노인의 증가에 따라 이들을 관리하기 위해 의료시설 이용량과 의료비가 급격하게 상승하고 있는데 1990년 65세 이상 노인인구는 전체의 5%, 노인의료비는 전체 의료비의 10.8%를 차지하였으나 2003년에는 노인인구가 전체의 8.3%, 노인의료비는 전체의 21.3%였고, 2005년에는 22.9%로 2003년에 비해 1.6% 늘었고 지난 1990년보다 두 배 이상 증가하였다.

<표 20> 10년간 노인의료비 지출 10배 증가

구 분	1990년	1995년	2000년	증가지수 (1990=100)
노인급여비 (구성비)	1,621억원 (8.6%)	4,892억원 (12.8%)	1조 5,821억원 (18.0%)	976 -
노인대상자 (구성비)	196만명 (4.9%)	248만명 (5.6%)	302만명 (6.6%)	154 -

주) 현물급여비 기준

자료: 「2000건강보험통계연보」, 2001

<표 21> 65세 이상 노인의료비 추이

(단위: 억원, %)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
전체의료비	178,195	190,606	205,336	223,559	247,968	285,580
노인의료비	31,681	36,811	43,723	51,364	60,556	73,931
구성비	17.8	19.3	21.3	23.0	24.4	25.9

자료 : 건강보험심사평가원

2. 보건복지가족부의 노인 관련 정책 및 사업 분석

1) 복지부의 각 부서별 노인관련 정책과 사업내용 파악

- 2국 2실 24과에서 노인관련 42개 업무를 담당하고 있다(2008. 11).
- <표 22>는 노인과 관련된 보건소 사업에 대하여 보건복지가족부 담당부서의 업무를 정리 한 것이다.
- <표 23> 보건복지가족부내의 노인관련 정책과외 그 담당 업무를 정리하였다.

<표 22> 보건복지가족부 담당부서의 보건소 관련 사업

담당부서	보건소 관련 과제	담당 업무
건강증진과	보건소 건강증진 사업	·임산부 및 영유아 보충영양관리사업 ·기타 영양사업 관련 ·국민건강영양조사(영양부문) ·비만관련 대책 ·운동 및 신체활동 활성화 관련
건강정책과	맞춤형 방문건강관리 사업	·농어촌의료서비스 개선 사업 ·도시보건지소 사업 ·주민건강지원센터 사업
암정책과	국가암 조기검진 사업	·국립암센터 지원육성 ·암관련 사업 총괄 ·호스피스 기관지원 ·지역암센터 운영 ·재가암관리 사업 ·국가암정보센터 운영 ·암관련 단체 지원
질병정책과	-만성질환(고혈압, 당뇨)등록 관리 사업 -전립선, 골다공증, 관절염, 만성폐질환 등 노인성질환 예방관리 사업	·심뇌혈관질환 예방관리 ·심근경색, 뇌졸중 등록관리 ·비만클리닉 시범사업 ·아토피, 천식 관리 종합계획 ·기후변화적응 및 건강피해 감소기획
노인정책과	-노인보건예방사업(노인건강 진단사업, 노인 안검진 및 개안수술사업) -치매 및 중풍 등 중증질환 노인대책수립(치매상담센터 운영, 치매조기 검진사업)	·노인정책 포럼 운영 ·노인복지생활 실태조사 ·노인복지 관련 국제협력 ·노인관련 법인, 단체지원 및 육성
건강보험과	-생애주기별 건강검진 -의료급여	·건강보험관련 법제정 ·건강보험 조사, 연구
질병관리본부	-눈, 귀 건강관리 강화 -낙상 등 손상방지를 위한 대책 -골다공증, 관절염 등 근골격계질환 관리 -노인건강통계 실시	·결핵정보감시체계 ·인플루엔자 표본감시체계 ·에이즈 정보망 ·전염병 감시체계 ·만성병관리 사업 ·항균제 내성 모니터링

<표 23> 보건복지가족부 노인관련 정책과의 담당 업무

국 또는 실	과	담당 업무
보건의료정책실	의료제도과	종합전문요양기관 인정제도 및 운영
	의료자원과	장기요양병상 확충사업
	공공의료과	노인보건의료센터 건립지원
	보험급여과	건강보험요양급여에 관한 종합계획
	보험약제과	건강보험요양급여 대상 약제의 상한금액 산정 및 조정기준 수립
	보험평가과	건강보험요양급여의 사후관리 관련 종합계획 수립 및 시행
건강정책국	건강증진과	생애전환기 건강검진 사업, 보건소 건강증진 사업
	건강정책과	맞춤형 방문건강관리 사업
	질병정책과	만성질환(고혈압, 당뇨, 심뇌혈관질환)등록관리 사업, 전립선, 골다공증, 관절염, 만성폐질환 등 노인성질환 예방관리 사업
	암정책과	국가암 조기검진 사업, 재가 암관리 사업, 말기 암환자 전문기관 운영지원
	정신건강정책과	노인정신건강증진 사업
사회복지정책실	기초생활보장과	국민기초생활보장 관련 사항
	국민연금정책과	기초노령연금 관련사항
	국민연금급여과	고령근로유인형 급여관련 사항
	기초노령연금과	기초노령연금 관련 사항
	사회서비스정책과	노인돌보미 바우처 지원사업
저출산고령사회 정책국	고령사회정책과	노후생활 관련 정책
	저출산인구정책과	노인적합형 일자리 창출에 관한 사항
	고령친화사업과	고령친화사업
	노인정책과	노인보건복지에 관한 종합계획, 노인건강증진 및 치매 예방관리사업
	노인지원과	노인학대예방, 독거노인 보호, 노인 자원봉사활동 성화, 재가노인보건복지, 노인일자리 및 사회활동 지원에 관한 사항
	요양보험제도과	노인요양보장, 노인장기요양보험에 관한 사항
	요양보험운영과	노인요양보장 관련 인프라 확충, 노인복지관련 법령 개정
	가족지원과	존속가족 지원 관련 사항
질병관리본부	만성병조사팀	심뇌혈관질환예방관리 사업, 생애전환기 건강진단 사업지원

2) 보건복지가족부 노인건강종합대책 T/F 운영(2008. 9 - 12)

- 보건복지가족부의 노인정책에 대한 의사결정과정을 보면 복지부 부서간 정책에 대한 의사결정과정이 부재하여 정책 또는 사업간 연속성 및 연계성이 미흡하다.
- 복지부 내 노인관련 부서간 노인정책에 대한 기본 방향에 대한 합의가 있어야 하며, 전체 종합대책에 대한 책임부서가 결정이 되어야 함에도 불구하고 그러한 논의가 이루어지고 있지 않다.
- 2008년 9월 장관님의 노인건강종합대책 수립에 대한 지시에 따라 T/F 구성하여 운영 중에 있다.

가. 취지

- (1) 예방중심의 정책관점을 강화하고, 중요하고 성과달성이 가능한 핵심적 과제 선정
 - 노년기에 가장 큰 건강손실과 의료비 지출을 유발하는 중증질환에 대한 조기 발견 및 기저질환 관리에 주력
 - 노년기는 1차 예방(건강증진)보다 2차(조기 발견), 3차(기저질환관리)예방이 보다 효과적
- (2) 삶의 질을 저하하는 주요 다빈도 질병 관리 강화
- (3) 취약계층 노인에 대한 건강보호 강화
- (4) 생애주기를 포괄한 건강증진종합계획은 별도 수립
 - 제3차 건강증진종합계획('11-'20) 수립 조기 착수('08 하반기)

나. 부분별 주요 검토과제

- (1) 노령기 기초건강증진 강화
 - ① 운동, 영양, 금연 등 건강행태개선 토털케어체계 마련
 - ② 취약계층 노인을 위한 건강관리 강화
 - ③ 제3차 국민건강증진종합계획('11-'20) 수립
- (2) 중증질환의 조기 발견
 - ① 5대암 검진 수검률 제고
 - ② 노령기 중증질환을 목표로 한 건강검진체계 개편
 - ③ 직장내 건강검진률 향상

- (3) 기저질환의 적정관리로 중증질환 악화 방지
 - ① 고위험군에 대한 건강검진 사후관리 서비스 제공
 - ② 고혈압, 당뇨병 등 만성질환 관리체계 혁신
- (4) 중증질환자 사후관리로 재발방지
 - ① 중증질환자 사후관리 모형 개발 및 역할 재정립
 - ② 간병, 가정간호서비스의 질적 수준 제고
- (5) 삶의 질을 악화시키는 다빈도 질환 예방관리
 - ① 치매 조기 검진 및 예방관리 강화
 - ② 눈, 귀 건강관리 강화
 - ③ 노인 의치보철 지원 확대 및 구강건강 예방 강화
 - ④ 낙상 등 손상방지를 위한 대책 수립
 - ⑥ 골다공증, 관절염 등 근골격계 질환 관리 강화
- (6) 노인 건강정책 인프라 확충 및 효율화
 - ① 노인건강 통계 신설 및 정책 평가기반 강화
 - ② 노인 건강전달체계 기능 재정립 및 연계체계 구축
 - ③ 노인 건강정책을 위한 재정 투자 확대

3. 우리나라 노인 건강 관련 법령 분석

1) 노인 관련 법제 개관

「헌법」 제34조제4항은 국가의 노인복지 향상을 위한 정책 실시의무를 규정하고 있고, 「노인복지법」은 이를 구체적으로 실현하기 위하여 주거·보건·여가 및 안전·권익보호 등의 분야로 나누어 다양한 노인복지 관련 내용을 담고 있다.

노인복지와 관련된 법령에는 「노인복지법」, 「노인장기요양보험법」 및 「기초노령연금법」 등이 있다.

① 노인복지법

노인복지에 관한 주된 법령은 「노인복지법」이다. 이 법은 노인의 질환을 사전에 예방하거나 조기에 발견하고 질환상태에 따른 적절한 치료·요양으로 심신의 건강을 유지하며, 노후의 생활안정을 위하여 필요한 조치를 강구함으로써 노인의 복지증진에 기여함을 목적으로 한다(「노인복지법」 제1조).

② 노인장기요양보험법

고령이나 노인성 질병(치매, 중풍 등) 등으로 일상생활을 혼자서 하기 어려운 노인 등에게 신체활동 또는 가사활동을 지원하는 장기요양급여를 제공하여 노후생활의 안정과 그 가족의 부담을 덜어주는 장기요양보험이 2008년 7월 1일부터 시행되었다.

③ 기초노령연금법

기초노령연금은 노후생활의 안정을 위해 생활이 어려운 노인(전체 노인의 60%, 약 300만명)에게 매월 일정액의 연금을 지급하여 국가발전과 자녀양육에 헌신해 온 노고에 보답하려는 제도이다.

65세 이상인 자로서 본인 및 배우자(사실상의 배우자 포함)의 소득인정액이 40만원 이하(노인단독) 또는 64만원 이하(노인부부)인 경우에 기초노령연금을 받을 수 있다(「기초노령연금법」 제3조, 「기초노령연금법 시행령」 제2조제1항 및 「2008년도 선정기준액 고시」).

④ 그 밖의 법령

다른 법령에 따른 보호의 수준이 「국민기초생활보장법」에서 정하는 수준에 이르지 않는 경우에 같은 법에 따른 급여를 받을 수 있다.

「장애인·노인·임산부등의 편의증진보장에 관한 법률」은 노인 등이 일상생활을 할 때 안전하고 편리하게 시설 및 설비를 이용하고 정보에 접근하도록 보장함으로써 이들의 사회활동참여와 복지증진에 이바지함을 목적으로 한다.

그 밖에 노인복지와 관련된 법령에는 「사회복지사업법」 및 「노인보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」 등이 있다.

2) 노인 관련법의 개정방향

(1) 노인복지법 개정방향

노인관련 단체나 학계 등에서 현행 노인복지법 중 개정의 필요성을 제기해 온 사항 중 대표적인 사항 몇 가지를 제시하면 다음과 같다.

① 현행 노인복지법 제1조 목적에 의하면 “노인의 질환을 사전 예방 또는 조기발견하고 질환상태에 따른 적절한 치료·요양으로 심신의 건강을 유지하고 노후의 생활안정을 위하여 필요한 조치를 강구함으로써 노인의 보건복지증진에 기여함을 목적으로 한다.”라고 명시돼 있다. 최근 노인 장기요양보험법이 마련되어 장기요양보호에 필요한 요양시설 등 인프라를 확충하고 서비스가 제공되고 있지만, 노인들 대부분이 노인성 질환을 가지고 있음에도 불구하고 노인복지법에는 노인의 질환을 사전예방·조기발견, 적절한 치료를 보장하기 위한 실효성 있는 내용이 미비한 실정이다.

② 가족제도의 유지·발전(제3조)의 경우 “국가와 국민은 경로효친의 미풍양속에 따른 건전한 가족제도가 유지·발전되도록 노력하여야 한다.”고 규정되어 있는데, 우리나라의 전통적인 경로효친 사항에 대한 규정 자체에 대해서는 문제를 제기할 순 없겠지만, 광의의 개념으로 해석하면 노인문제의 해결과 노인부양에 대한 책임을 가정과 사회가 공동으로 대처해 나간다는 뜻으로 해석할 수 있다. 따라서 노인문제 해결에 대한

사회와 정부의 책임을 약화시키는 규정이 되어서는 안 되며, 가정해체 현상의 방지 등 가정문제를 사전에 예방하고 위기가정문제 해결을 위해 정부와 사회가 적극적으로 지원해야 한다.

- ③ 보건복지증진의 책임(제4조)과 관련하여 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 국가와 지방자치단체와 함께 ‘노인의 일상생활에 관련되는 사업을 경영하는 자’로 명시되어 있어 실현성의 문제가 제기되고 있고, 구체적으로 어떠한 책임인지에 대한 내용의 언급이 없다. 책임소재와 관련 국가나 지방자치단체에서 수행하는 모든 복지프로그램에 대한 책임은 국가나 지방자치단체가 맡아야 한다는 원칙이 정해져야 할 것이다.

그리고 현행 노인복지법에는 노인에게 제공되는 서비스에 대한 중앙정부, 지방자치단체의 역할과 책임에 관련된 규정이 정확하게 명시되지 않고 있는데, 이를 개선할 필요가 있다. 미국 노인복지법의 경우 노인들에게 제공되는 프로그램 및 그에 소요되는 재정 지원과 관련하여 연방정부, 주정부, 지방정부의 역할 및 책임영역이 구체적으로 명시돼 있다. 예컨대 최고기관인 주정부 노인국은 주단위의 정책과 기획을 담당하고 하부기관인 지역노인과에 예산을 분배하며, 지역노인과는 직접 노인들에게 서비스를 제공하는 체계적인 ‘노인복지서비스 연계망’을 구축하고 있다.

- ④ 노인사회참여 지원(제23조)과 관련하여 “국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사활동기회를 넓히고 노인에게 적합한 직종의 개발과 보급을 시책을 강구하고 근로능력이 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.” 라고 규정하고 있다. 그러나 ‘국가 및 지방자치단체가 관리하고 있는 공공단체는 저원의 5% 범위내에서 노인 일자리를 확보하여 제공하여야 한다.’ 등 구체적인 항목이 추가될 필요가 있으며, 일반기업도 노인의 일자리 제공에 적극 협조할 수 있도록 개선할 필요성이 있다.

- ⑤ 제31조는 노인복지시설의 종류로 노인주거복지시설, 노인의료복지시설, 노인여가복지시설, 재가노인복지시설 등을 나열하고 있는데 이는 노인 복지를 사업별로 구분하는 것이 아니라 예산지원의 편의성을 앞세운

시설 중심의 복지로 제한하고 있다는 지적을 받고 있다. 따라서 이를 시설중심이 아닌 사업중심으로 개정하고, 그 대상도 복지수요의 다양성을 반영하여 노인주거복지, 노인의료복지, 노인여가복지, 재가노인복지, 노인주거복지, 노인문화복지, 노인고용복지 등으로 다양화하여 분야별 복지대책을 마련할 필요성이 있다는 주장이다.

- ⑥ 미국 등 선진국의 노인복지법에는 노인들의 존엄성을 보장하고 노인의 권익을 옹호하기 위한 방법으로 노인학대, 옴부즈만제도, 노인권익 옹호와 관련된 규정이 명시되어 있어 그에 소요되는 프로그램과 연구 활동에 재정을 지원하고 있지만 우리나라의 노인복지법에는 그러한 규정이 없다. 그러한 규정을 신설하는 방안을 검토해야 할 것이다.

(2) 노인장기요양보험의 개정방향

2008년 7월 1일부터 시행된 우리나라 노인장기요양보험의 문제점 및 해결 방안을 검토한 결과는 다음과 같다.

- ① 이 사업의 주체인 국민건강보험공단은 본 사업의 주체로서 무엇보다 보험수급자(보험수익자)와 그 가족에게 만족한 급부가 제공될 수 있도록 최선을 다해야 할 것이며 그러기 위해서는 기존의 중앙집권적이고 관료적이며 일방적인 조직의 특성을 과감하게 탈피하고 낮은 자세로서 국민에게 봉사하도록 해야 할 것이다. 또한 중앙정부는 기존의 노인복지업무 책임자인 지방정부가 공단과 협조 할 수 있도록 중재자의 역할을 다해야 함은 물론 본제도가 정착될 때까지 중앙정부와 지방정부 그리고 공단이 삼위일체가 되어 긴밀한 협조체제를 이루어나가야 할 것이다. 또한 본법의 시행초기에는 여러 가지 여건상 부득이 급부대상자를 한정하고 축소하여 시행할 수밖에 없는 처지에 있지만 향후에는 모든 국민이 본 보험의 혜택을 누릴 수 있도록 준비해 나가야 할 것이다.
- ② 2008년 현재 본 법에서 정해 놓은 보험수가는 그 반대급부인 보험료와 비교해 볼 때 적은 편은 아니라고 생각되므로 현실적으로 큰 무리는 없는 것으로 보이나 수급자측면에서 볼 경우 중등증(3등급)이하의 자에게는 본 보험 급부의 혜택을 근본적으로 제한해 놓음으로 인해 이에 대한 불

만의 소리와 민원이 제기될 가능성이 있다고 보아진다. 따라서 향후 이러한 문제를 해결할 수 있는 대책을 마련해야 할 것이다.

- ③ 재원조달방식에 대하여는 앞에서 기술한 바와 같이 보험료를 올리느냐 국가 부담을 늘리느냐 아니면 자기부담을 늘리느냐의 문제인데 대체적으로 일본이나 독일의 경우 자기부담금은 10% 이내로 하고 정부의 지원을 늘리는 추세이기에 우리도 향후 자기부담금은 줄이고 국가부담을 늘리는 쪽으로 가는 것이 바람직하다고 생각된다. 왜냐하면 자기부담금이 10%이상일 경우에는 수급자의 부담이 커지므로 그럴 경우에는 본 보험의 본래의 목적이 희석되기 때문이다. 그러나 정부의 지원금을 늘릴 경우 그것은 국민에게 세금의 증액이라는 문제가 발생 될 수 있으나 그것은 국민 전체에 부가하는 경우 개인에게서 큰 금액이 아니기에 국민의 합의만 있다면 특별한 문제가 없다고 보아진다.
- ④ 노인장기요양보험의 수급절차에 관한 문제에 대하여는 앞에서 기술한바와 같이 역시 신속하고도 공정한 등급판정이 이루어지도록 해야 할 것이며 그러기 위해서는 본 수급에 필요한 충분한 의료진의 확보와 본 판정에 대한 엄격하고 체계적인 등급규정 그리고 요양수급자의 의견의 진술의 기회 및 재심 절차 등의 조치가 필요할 것이다.
- ⑤ 노인장기요양보험의 장기요양기관이 지나치게 난립되어 사회에 무리가 일어나지 않도록 각 지방자치단체의 장은 사전에 이 문제를 점검하고 그 지역에 알맞은 수의 요양기관이 설립되어 질 좋은 서비스가 제공될 수 있도록 최선의 준비를 다해야 할 것이다.

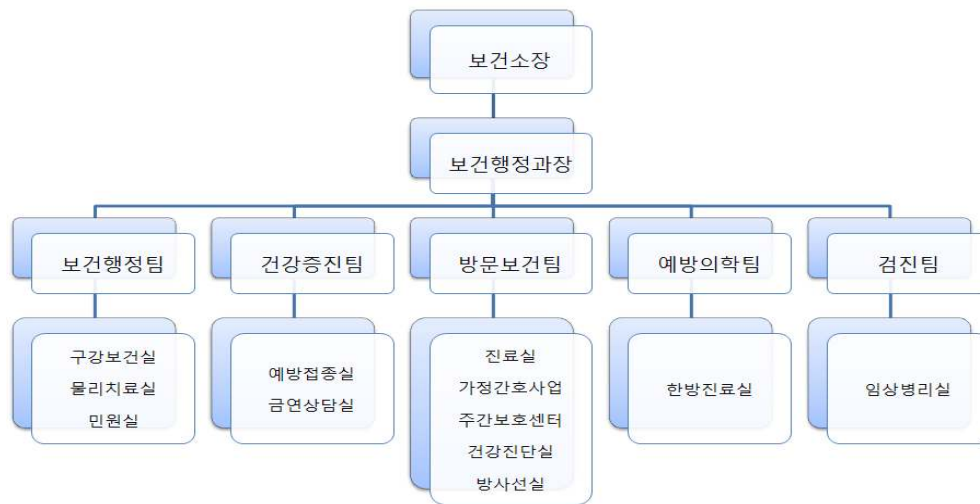
4. 보건소의 노인관련 보건사업 조사

<표 26> 보건소의 노인 관련 사업

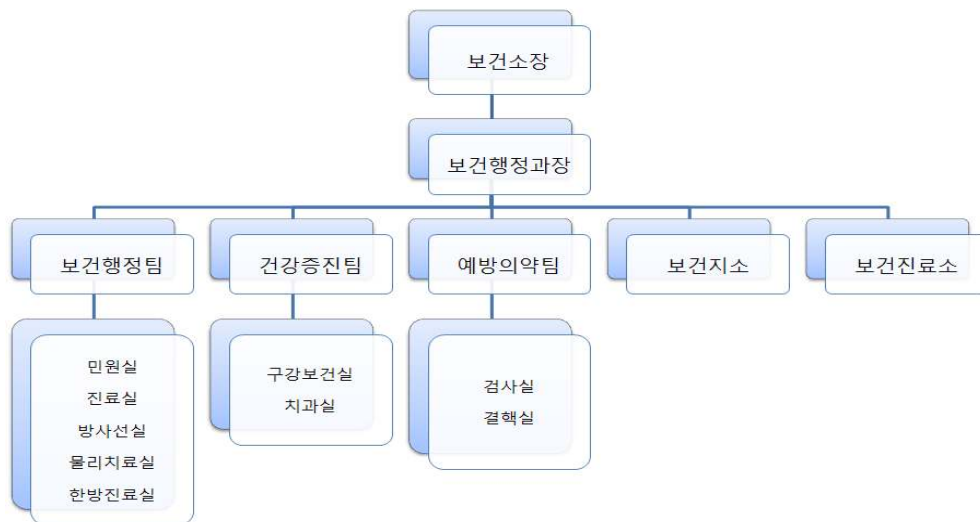
사업명	대 상	사업 내용
맞춤형 방문보건 사업	65세 이상 지역노인인구	·기존의 취약계층, 만성질환자에게 서비스를 전달하는 좁은 의미의 방문보건사업에서 질병이 발생하여 병의원에 가기 전단계 혹은 후속조치에 행해지는 질병예방 및 건강증진 활동을 총칭하는 넓은 의미의 새로운 환경, 새로운 변화에 맞추는 방문 보건사업 추진
만성질환 관리사업	만성질환자 대상	·100세 건강강좌 ·고혈압 자조관리교실 ·당뇨병 자조관리교실 ·짜게 먹는 식습관, 고혈압 저염식이 조리실습 ·건강한 식습관 형성을 위한 당뇨병 시식회 ·고혈압, 당뇨병, 고지혈증 합병증 검사 등
어르신 무료의치 보철사업	65세 이상 국민기초생활보 장수급노인	·보건소에서 정신건강상태 기록 및 구강상태를 1차로 검진한 후 의치보철이 가능한 대상자를 선정하여 치과의원에 시술의뢰 ·경로당 방문 구강보건가업: 구강검진, 잇솔질 교습, 틀니 관리방법, 구강위생용품 배부, 불소도포
치매, 정신보건 사업	지역노인	·어르신 정신건강조사 ·치매선별검사 ·재가 치매 어르신을 위한 서비스: 의료재활서비스, 사회재활서비스, 사회복지서비스 ·치매예방교육: 치매상담센터 운영, 지역 어르신을 위한 치매예방 교육, 치매예방 홍보
운동, 영양, 절주사업	60세 이상 관내 주민	·노인운동 프로그램: 낙상예방운동, 요실금 예방운동, 유연성 운동(요가), 근력강화운동 ·노인 영양상담 프로그램: 기본 영양상담, Can-pro를 이용하여 전체 영양소 섭취 비율과 영양소별 권장비교섭취 정도 분석, 과잉 및 부족 영양소와 올바른 섭취 방법 상담

- 자세한 내용은 부록에 부침<부록 3. 참조>

- 보건소의 노인관련 보건사업 분석 및 보건소 조직을 보면 노인건강을 책임지는 부서는 따로 조직되어 있지 않고, 건강증진팀(계), 방문보건팀(계)에서 분산되어 실시하고 있었다. 또한 사업이나 프로그램도 복지부에서 시달되어 내려오는 사업을 그대로 받아서 실시하고 있는 실정으로 지역 특성을 고려하지 않고 있었으며 특히, 운동프로그램은 효과가 확실하지 않는(evidence-based) 경우도 많았다.



<그림 14> 보건소 조직도(광역단위)



<그림 15> 보건소 조직도(농촌단위)

5. 노인건강과 관련된 복지부 정책의 의사결정과정 및 환경 조사

노인관련정책을 결정하고 수행하는 과정은 여러 요인에 의해 결정된다. 그동안 우리나라 중앙정부의 노인정책은 실수요자인 노인의 필요나 관련 전문가의 요구보다는 정치적인 필요, 행정부의 결정에 의해 결정되어 왔다. 이는 우리나라의 인물중심의 정당정치와 지정학적 특성으로 인해 어느 정당이든 간에 보수적인 이념을 가질 수밖에 없어 피할 수 없는 일이라고 치부되면서도 오랫동안 비판의 대상이 되어 왔다.

이와 같은 비판은 네 가지 측면에서 논의할 수 있다.

- 1) 정책형성과정과 절차상의 문제점
- 2) 의사결정체계가 갖춰야 할 요소의 구비여부
- 3) 의사결정에서의 윤리성
- 4) 지방자치제도의 발전과 노인정책

또한 이런 비판 내용은 노인정책에만 관계되는 고유한 문제와 대부분의 정책에 공통되는 문제로 나누어 볼 수도 있다. 정책형성과정과 절차상의 문제는 정책의제의 형성, 대안제시 및 채택과 밀접한 관련이 있다. 정책의제형성에는 통상 철의 삼각을 이루는 행정관료, 의회, 이익집단이 영향을 주는 것으로 알려져 있다. 전술한 바와 같이 지정학적 특성과 인물중심의 정당정치는 노인정책에 대한 우선순위가 떨어지고 상대적으로 거리를 두게 되어 있었다. 또한 중앙집권식 정치구조와 대통령제는 행정의 능률성을 추구하였고 노인이나 관련 전문가의 의견보다는 고위정책결정자나 정책입안 행정가의 견해가 일방적으로 반영되는 경향을 보여 왔다. 최근 들어 노인집단이 노인의 권익 보호활동에 전에 비해 늘어나고 있으나 아직 미흡한 수준이다. 이와 같은 정책결정과정의 폐쇄성과 함께 지적되는 것은 정책결정권자에 여론을 투입하는 과정조차 비공식적이라는 것이다. 개인의 친분, 학연, 지연 등 비공식적 통로를 통해 의견이 전달되므로 다른 분야에 비해 상대적으로 더 활성화되지 못하고 정책으로 자리를 잡지 못하는 경우가 많다. 또한 정책결정과정 상명하달식이기 때문에 노인이나 실무자의 의견이 반영되기 어려우며 이익집단 중 상대적인 열세에 있는 노인집단의 의견은 더 더욱 반영되기 어려웠다.

정책대안제시와 채택에서는 두 가지의 문제가 지적되고 있다. 첫째는 의제형성과 같이 의견을 수렴하고 반영하는 정책과정에서의 참여 개방이고 둘째는 대안선정의 과학적 근거이다. 캐나다의 일부 주정부는 프로그램 평가가 정책과정의 필수적 요소로 이런 근거를 토대로 대안을 정하고 있다. 우리의 경우도 국내외 사례를 검토하고 이를 토대로 결정을 하고 있으나 대안채택을 위한 구체적인 기준이나 방법론이 공식화되어 있지 않다. 정책과정에서의 참여도 일부 정책에서 가지고 있는 공청회나 정책 최종결정 전의 의견 수렴 절차가 있으나 방향이 정해진 이후의 세부 내용의 조정이라는 성격이 강하며 주요 내용을 결정하는 데는 큰 영향을 주고 있지 않다.

의사결정체계가 갖춰야할 요소는 사회적 통념이나 이념적 지향에 따라 다소 다르나 캐나, 호주 등 외국의 사례를 보면 정확성, 투명성, 책임성, 공정성 등이 주요한 요소로 지적되고 있다. 이 중 중앙정부 등 철의 삼각에 공통적으로 적용되는 주요한 요소는 투명성과 공정성이다. 투명성은 정책과정의 경과와 내용을 관련된 관계자 및 이해당사자에게 공개하는 것을 의미하며 정책의제형성에서 수행하고 평가하는 최종단계까지 모두 적용되는 사항이다. 우리의 경우 대선공약 등 비롯해 대부분의 정책이 비공식적인 통로를 통해 시작하고 결정과정에는 이해당사자가 제한적으로 참여하는 경우가 대부분이었다. 노인정책의 경우 투자라기보다는 안전망의 구축자원에서 최소한의 내용만 제공되는 경우가 많았다. 정책과정의 공정성은 주로 노조 등에서 통해 주장하는 주요 골자이었다. 노인정책의 경우 공정성을 책임지고 논의할 단체가 사실상 없었고 또한 그와 같은 논의의 상대자도 거의 없었다고 할 수 있다.

정책과정의 윤리성은 세 가지 관점(공리주의, 개인의 권리, 공정성)에서 논의할 수 있다. 공리주의는 대부분의 정책에서 기본적인 시각으로 최대다수 최대행복이라는 현실적인 결과에 집중하는 방식이다. 노인이 상대적인 소수일 때는 노인에 대한 암묵적인 무시의 근거가 되었고 노인이 사회의 주요구성원인 지금도 경제적인 이익의 관점에서 상대적인 우선순위를 조정하는 근거가 되기도 한다. 또한 다수의 편익을 위해 장애인 등 소수의 의견과 권익을 무시하는 근거로 제시되고 있다. 개인의 권리는 공리주의와 서로 배치될 수 있지만 개개인의 권리 또한 보호 받아야 한다는 관점에서 출발하고 있

다. 우리의 경우 잘 지켜지지 않는 측면이기도 하며 특히 소수자의 권익이 보호받지 못한다는 비판에 직면하고 있기도 하다. 공정성은 이미 논의 된 바와 같이 모두에게 정책결과가 전달되도록 한다는 시각이나 노인의 경우 이와 같은 입장을 대변하는 단체가 없다는 것이 문제이기도 하다.

우리나라는 지자체의 실시로 노인정책의 실제적인 문제 중 많은 부분이 지방자치단체의 몫으로 남아 있으며 실제로 많은 시군구청장의 우선사업 중 하나가 노인관련사업이기도 하다. 그러나 이와 같은 우선순위에도 불구하고 노인사업과 관련한 정책채택이 정과정의 절차와 의사결정과정의 요건을 만족하기보다는 표심으로 대표되는 노인 여론의 지지를 구하는 방안으로 활용되고 있다. 이와 관련하여 지방정부에서 노인관련단체의 목소리가 점차 힘을 얻어가고 있다. 하지만 중앙정부에서의 상대적인 소외와 마찬가지로 노인문제의 본질을 천착하기 보다는 소수의 관계자를 통해 정책이 결정되는 폐쇄성은 동일하게 발생하고 있다. 여기에는 중앙정부와 지방정부 간의 정책결정과정의 공유 미흡, 지방정부의 노인정책수행과정에 대한 중앙정부의 지원 부족이 또한 영향을 주고 있다.

현재 보건복지가족부 내에서 노인정책과 직접적으로 관련되어 있는 부서는 노인정책과, 노인지원과, 요양보험운영과, 요양보험제도과, 고령사회정책과, 고령친화산업과, 구강생활위생과, 질병정책과가 있으며, 건강정책과, 건강증진과 등이 간접적으로 관련을 가지고 있다(구체적인 내용은 아래의 표 참조). 업무는 부서별 업무분장에 따라 추진하며 비포함 업무나 중첩업무는 부서 간 협의를 통해 결정하고 있다. 이와 같이 정책결정과정 및 절차와 관련하여 정립된 사항은 보건복지가족부 내 부서 간 업무분장에 대한 기본적인 입장만 있을 뿐이다.

<표 27> 보건복지가족부 내 노인관련 부서의 업무 분장 내용

과명	관련업무	관련 수준
노인 정책과	치매종합관리대책 수립 추진 노인소비자권익보호대책 수립추진 등 노인복지정책 개발·조사·연구 노인보건예방사업 등 노인보건사업종합계획 수립 노인실명예방관리 경로효친사상 양양 및 경로우대제에 관한 사항 노인복지법령 관리 노인복지관련 국제협력 업무(IAGG 회의 등) 신규 노인복지 이슈 개발(노인 자살 및 노인범죄 예방, 노인 성문제 등) 성년 후견인제 모니터링	직접
노인 지원과	노인 일자리사업 종합계획 수립 노인자원봉사 활성화 독거노인 보호정책 수립 노인돌봄서비스 운영 및 노인돌보미바우처 지원사업 독거노인 DB 구축 및 운영에 관한 사항 노인학대 예방 및 노인보호 종합계획 수립 노인보호전문기관 설치운영 노인복지관 육성 및 지원사업 노인의 날 행사 지원 노인 여가문화 및 교육 지원 등 결식노인(무료급식) 지원 매장·화장·묘지 등 장사 관련	"
요양 보험 운영과	노인요양보장 관련 인프라 확충 종합계획의 수립에 관한 사항 노인요양보장 관련 시설 인프라 확충에 관한 사항 노인요양보장 관련 전문인력의 양성 및 제도화에 관한 사항 노인장기요양기관 지정 및 운영지원에 관한 사항 노인요양시설·양로시설 및 재가노인복지시설의 지원 및 육성에 관한 사항 노인장기요양기관 운영평가에 관한 사항 노인요양대상 시설입소 제도에 관한 사항 노인복지주택 및 노인전문병원 확충 및 제도에 관한 사항 사할린 한인동포 지원에 관한 사항 노인복지시설 통계 생성 및 관리에 관한 사항	"

요양 보험 제도와	노인요양보장에 관한 종합계획의 수립 및 조정 노인요양보장 관련 법령에 관한 사항 외국의 노인요양보장제도에 관한 동향분석 및 국제협력 장기요양위원회의 운영에 관한 사항 노인장기요양보험 관련 재정 운영 및 재정 관련 정책에 관한 사항 노인장기요양보험의 가입자 관리 및 지원정책의 수립 및 조정 노인장기요양보험 대상자 선정기준 및 등급판정에 관한 사항 장기요양급여의 개발, 급여기준 및 수가 등에 관한 사항 장기요양급여의 청구, 심사 및 지불체계에 관한 사항 장기요양급여의 관리 및 평가에 관한 사항 노인요양보장제도에 관한 조사·연구·홍보 및 통계관리에 관한 사항	"
고령 사회 정책과	노후소득, 주택, 건강, 문화관련 정책의 총괄 및 조정 노인친화적 사회문화환경조성	"
고령 친화 산업과	고령친화제품 종합체험관 건립, 우수제품(사업자) 지정·표시제도 도입, 실버용품 대여·판매 시범사업 확대 및 관련 제품 표준화 고령친화산업 종합계획의 수립 조정 및 고령친화모델지역 사업 운용	"
구강 생활 위생과	불소 도포·스케일링 사업을 통한 노인치주질환 예방 및 저소득층 노인 의치보철보급사업	직간 접
질병 정책과	심뇌혈관질환 등 만성질환의 관리에 관한 종합계획의 수립 및 조정 관절염, 전립선질환 등 노인성 만성질환 종합계획 수립 및 조정	"
건강 정책과	국민건강증진사업에 관한 종합계획의 수립 및 조정 국민건강증진에 관한 조사·평가 및 연구 국민건강증진사업의 지원·평가 국민건강에 관한 교육 및 홍보 방문보건사업의 조정 및 평가	간접
건강 증진과	국민건강증진을 위한 교육 및 홍보 지역특화 건강행태 개선사업에 관한 사항 금연 확산을 위한 제도 정비 및 계획 수립·시행 금연클리닉 및 금연상담전화 등 운영에 관한 사항 신체활동 활성화를 위한 건강증진사업 지원 건강검진에 관한 종합계획의 수립 및 조정 건강검진 사후관리에 관한 사항	"

이와 같은 논의를 토대로 보건복지정책결정과정과 절차에 대한 개선점을 검토한다면 노인정책과정의 개방, 정책대안채택의 과학성, 정책결정과정의 투명성, 정책결과의 공정한 배분, 공리주의 뿐 아니라 개인적 권리 등을 고려한 윤리적 기준을 확보하고 지방정부의 노인정책을 지원하는 체계마련이 필수적이라고 할 수 있다. 이를 위해서는 정책개발과정에 이해관계자가 참여할 수 있도록 참여통로를 열고, 정책채택을 위한 기준 및 노인정책 관련 데이터베이스의 개발 및 운영, 정책과정을 이해당사자가 쉽게 알 수 있도록 공개하는 통로의 개발, 정책영향(수혜대상, 윤리적 파급효과 등)의 평가방법론 개발, 지방정부의 노인정책 지원체계 구축이 필수적이다.

위의 개선방안 중 많은 부분이 노인정책에만 고유한 것은 아니며 전체적인 정책과정과 관련한 개선이 필요한 내용이다. 그렇지만 노인정책과정의 개발, 노인정책 채택 기준 및 관련 데이터베이스 개발 및 정책영향평가는 노인의 고유한 영역으로 최소한 이에 대한 검토가 필요하며 노인정책과 관련하여 밀접한 관련이 있는 부서 간의 협의와 공조를 통해 개발하여야 할 영역이다.

6. 우리나라 노인건강정책의 주요 문제점

- 1) 노인건강정책에 관한 국가의 중장기 비전이 없어 목표중심의 계획안이 부재하였다.
- 2) 종합적이고 통합적 접근이 부족하였다. 국가는 그 동안 주로 복지측면(사회적 서비스)에서 노인문제를 접근하였다. 그 결과 의료적 측면(예방 및 질병관리)은 거의 민간의료기관에 맡김으로서 노인의 질병관리는 공공성이 매우 미약하였다.
- 3) 복지부 부서 간 노인 관련 정책에 대한 의사결정과정이 부재하였다.
- 4) 노인건강에 대한 정책 및 사업에 연속성 및 연계성이 미흡하였다.
- 5) 의료법, 노인복지법, 노인장기요양보험법 간 불분명하고 노인건강을 위한 별도의 법이 없어 법적 근거가 미흡하다.
- 6) 노인의료전달체계, 질적 관리체계, 평가체계가 없다.

- 7) 노인관련 자료의 정확성이 부족하여 근거중심 정책을 추진하는데 어려움이 있으며, 특히 노인건강통계기반이 부족하다.
- 8) 계층간 건강격차가 존재하는데 건강불평등해소 방안이 미흡하다.

7. 노인건강문제에 대한 공중보건학적 우선순위 설정

1) 노인건강문제에 대한 우선순위 설정 과정

(1) 전문가 의견 수렴

- 전문가(중앙부처, 전공교수, 보건소 실무자 등)조사를 통한 노인건강 문제에 대한 우선순위 결정 기준 및 우선순위를 설정하였다.
- 전문가 그룹 회의 및 세미나 등을 개최하여 노인건강 문제 해결방안을 모색하였다.
- 여러 분야의 전문가를 초빙한 워크숍을 개최하여 기본 안에 대한 의견을 듣고 보완해 나갔다.

(2) 우선순위 결정 기준에 대한 외국자료를 수집 분석 후 적용

- 노인 건강문제의 우선순위 결정 과정에서 중요성의 평가(PATCH), 변화가능성의 평가(PATCH), 우선순위 결정 기준의 보완(PEARL), 문제의 크계, 심각성, 추정효과를 고려(BPRS)의 과정을 거쳐 우선순위를 설정하였는데 그 내용은 다음과 같다. 첫째로 기준을 설정하고 자료를 검토하여 건강문제 목록을 작성하였으며 둘째로 건강문제 해결을 위한 지역사회 능력을 평가하였다. 셋째로 주요 보건문제의 변화가능성 및 중요성을 결정하였고 넷째로 보건문제 해결능력에 영향을 주는 사회적, 정치적, 경제적 요인들을 평가하였다. 다섯째로 해당 보건문제들을 위해 개발되어 있는 프로그램과 정책을 파악하였다.

(3) 미국 CDC의 PATCH(Planned Approach To Community Health)의 우선순위 결정기준가)

가) 중요성

- 중요성은 건강문제가 지역사회에 얼마나 심각한 영향을 주는가, 또는 건강문제를 변화시키면 건강수준에 얼마나 효과가 나타나는가를 평가하는 기준이며, 건강문제의 중요성을 판단하기 위해서는 첫째, 건강문제가 얼마나 흔한가를 평가하게 되며 주로 유병률이나 발생률을 이용하여 비교하게 된다.
- 건강문제의 중요성을 판단하는 두 번째 기준은 해당문제가 지역의 건강수준에 얼마나 심각한 영향을 미치는 가인데, 소위 건강문제의 위중도(危重度)라고 불리는 이 기준은 질병의 사망률이나 장애발생률, DALY 같은 질병부담 측정지표, 경제적 부담 등을 이용하여 측정하게 된다.

나) 변화가능성

- 변화가능성은 건강문제가 얼마나 용이하게 변화될 수 있는가를 평가하는 기준이며, 변화가능성을 평가하기 위해서는 문헌을 통해서나 다른 지역의 보건사업 경험을 통해 건강문제를 효과적으로 해결한 경험이 있는가를 확인하여야 한다. 즉, 과학적 근거(evidence)에 따라 건강문제의 변화가능성을 평가한다. 우리가 비교하고자 하는 건강문제가 질병이나 사망이 아니고 행태인 경우에는 행태가 생활습관으로 고착된 경우보다 그렇지 않은 경우를 변화가능성이 높다고 평가한다.

다) PATCH를 이용한 건강문제의 우선순위 선정 단계(미국 질병본부 권장)

- 1단계 : 브레인스토밍 등의 방법을 사용하여 지역에 흔한 건강문제를 취합하여 주요 건강문제의 목록을 작성한다.
- 2단계 : 1단계에서 취합된 건강문제를 건강문제의 중요성과 변화가능성을 고려하여 표로 정리한다.
- 3단계 : 중요하고 변화가능성이 높은 문제들을 중심으로 다시 한 번 우선순위를 정한다.

- 우선순위에 따른 건강문제의 정리 (예)

우선순위	사망	장애	건강위험	
			행위요인	비 행위요인
1	심장질환	사고	흡연	실업
2	암	뇌졸중	운동부족	의료서비스 부족
3	뇌졸중	치매	음주	열악한 도로 상태
4	사고	암		여가시설의 부족
5	당뇨병	심장질환		

(4) 문제의 크기, 심각성, 추정 효과를 고려한 방법: BPRS (Basic Priority Rating System)

- BPRS 방법에서는 우선순위를 결정하기 위하여 문제의 크기와 심각성, 그리고 이용할 수 있는 사업의 추정 효과를 다음의 공식을 통해 계산한다.

$BPR(\text{Basic Priority Rating}) = (A + 2B) \times C$
A: 문제의 크기
B: 문제의 심각도
C: 사업의 추정 효과

가) 건강문제의 크기

- 고려하는 보건문제에 의해 영향을 받는 인구의 비율을 반영하여 0점에서 10점까지 (비율이 높을수록 높은 등급을) 등급을 결정한다. 아래 표는 등급을 매기는 방법을 예시한 것.

<BPRS 방식에서 건강문제의 크기를 계산하는 등급화 기준 예시>

보건문제를 가진 인구 비율	문제의 규모 등급
25% 이상	9 또는 10
10%-24.9%	7 또는 8
1%-9.9%	5 또는 6
0.1%-0.9%	3 또는 4
0.01%-0.09%	1 또는 2
0.01% (1/10,000) 미만	0

나) 건강문제의 심각성(Severity) 등급화(B)

- 건강문제의 심각성이 클수록 더 큰 점수를 부여한다. 여기서는 건강문제의 심각성이 규모에 비해 더 큰 영향을 미친다고 가정하여 “심각성 등급”에 2를 곱하여 최종 점수를 산출한다. 모든 지역사회는 건강문제의 심각성을 등급화 할 기준을 마련해야 한다. 건강문제의 심각성을 등급화 하기 위한 기준이 작성되었으면 동일한 기준을 모든 건강문제의 심각성과 비교하여 등급을 부여한다.
- 아래의 질문들은 건강문제의 심각성을 등급화 하는데 도움이 되는 질문들이다.
 - 긴급성: 어떤 건강문제가 부상하고 있는 문제인가? 그 문제는 긴급히 개입해야 할 필요성이 있나? 대중이 관련된 문제인가? 그 문제는 건강문제인가?
 - 중증도: 그 문제의 심각성은 어떤가? 그 문제는 사망률이나 입원율이 높은가? 그 문제는 조유병(早有病)이나 조사망(早死亡)을 초래하는가?
 - 경제적 손실: 보건 문제와 연관된 실제적 또는 잠재적, 경제적 손실이 있는가? 그 보건 문제는 장기적 질환을 초래하는가? 지역사회는 경제적 부담을 담당해야 하는가?

- 타인에 대한 영향: 지역사회에서 다른 문제에 대한 실제적이거나 잠재적인 파급효과는 무엇인가?(예를 들면, 감수성 있는 인구에 대한 홍역의 전파)

<심각성 등급화 기준 예시>

건강문제는 얼마나 심각한가	심각성 등급
매우 심각	9 또는 10
심각	6 또는 7 또는 8
심각성 작음	3 또는 4 또는 5
심각하지 않음	0 또는 1 또는 2

다) 건강문제에 대한 가능한 사업의 효과 등급화(C)

- 건강문제를 개선하기 위한 사업의 효과는 우선 순위 결정에 있어 매우 중요하다. 그러나, 일반적으로 정확한 측정이 어렵다. 효과성의 상한과 하한을 설정하고 이와 비교하여 사업의 효과를 상대적으로 평가하는 것이 도움이 될 수 있다.

<사업효과성 등급화 기준 예시>

보건문제의 예방을 위한 개입의 효과성	“효과성 등급”
매우 효과적 80-100% 효과 (예, 예방접종)	9 또는 10
비교적, 효과적 60-80% 효과	7 또는 8
효과적 40-60%효과 (예, 시력상실을 예방하기 위한 당뇨병 망막증을 위한 레이저 치료)	5 또는 6
효과성 낮음 20-40%	3 또는 4
비교적, 비효과적 5-20%	1 또는 2
거의 효과 없음 5%미만	0

라) 건강문제에 대한 우선순위 계산

- 우선순위 점수는 건강문제에 대한 칸 A, B, C에서 계산하여 칸 D에 기록한다. 다음의 공식은 우선순위 점수를 계산하기 위한 것이다.

$$D = [A + (2 \times B)] \times C$$

- 우선순위 점수가 계산되었으면 우선순위 점수의 크기에 따라 각 문제에 대해 우선순위를 부여한다.

(5) 우선순위 결정 기준의 보완: "PEARL"검사

- 건강문제의 우선순위는 PATCH, BPRS 등을 이용하여 결정할 수 있으나 아무리 문제가 중요하고 효과적인 해결방법이 존재한다 하더라도 정치적인 이유, 경제적인 이유, 행정적인 이유, 시간적인 이유, 윤리적인 이유 등으로 인해 보건사업을 통해 문제를 해결하지 못한 경우가 많기 때문에 따라서 사업 우선순위 결정과 함께 사업의 실행가능성을 평가할 필요가 있다.
- 이런 목적으로 사용되는 기준이 PEARL이며("PEARL"이라는 단어는 PEARL 기준에서 고려하는 5가지 요소의 첫 글자를 따서 만든 합성어이다). PEARL은 주로 BPRS의 계산 후 사업의 실행가능성 여부를 판단하는 기준으로 상용되고 있다.

- **적절성(propriety)** - 해당기관의 업무 범위에 해당하는가?
- **경제성(economics)** - 문제를 해결하는 것이 경제적으로 적절한 일인가? 사업을 수행하지 않을 경우 경제적인 결과가 초래될 것인가?
- **수용도(acceptability)** - 지역사회가 그 사업을 수용할 것인가? 원하는 사업인가?
- **자원(resources)** - 그 사업을 위한 재정은 조달할 수 있거나 조달할 수 있는 가능성이 있는가?
- **합법성(legality)** - 현행법 아래에서 사업 활동을 수행할 수 있는가?

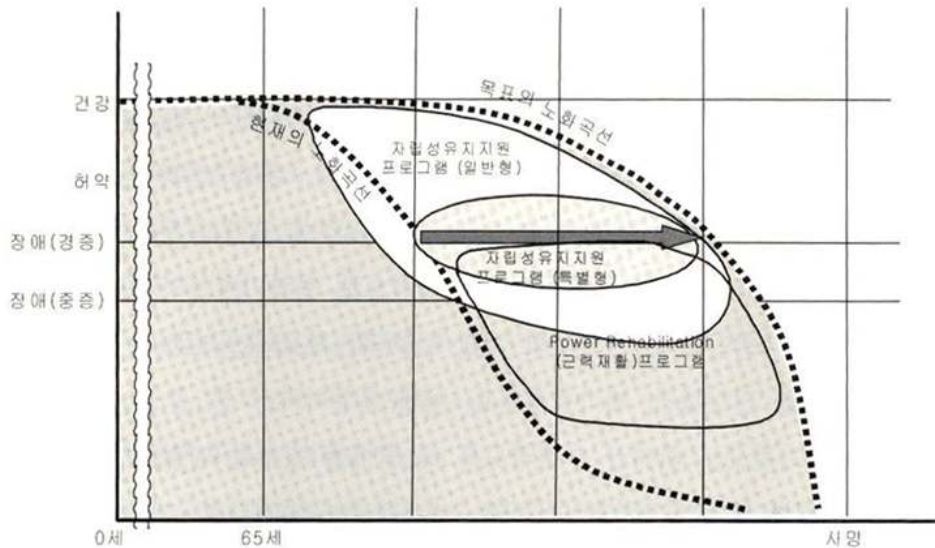
- 각 항목에 0점 또는 1점을 부여하고 5가지 항목의 점수를 곱하여 사업의 시행여부를 결정한다. 따라서 한 항목이라도 불가의 판정을 받으면 사업은 시작할 수 없다.

PEARL

건강문제	P 적절성	E 경제성	A 중요성	R 자원	L 적법성	PEARL (0 또는 1)

2) 우선순위 설정과정에서의 개념 정리(노인에 있어서 왜 기능이 중요한가?)

- 그 동안의 노인우선순위 설정이 건강행태와 질병위주로만 진행되어왔지만 실상 노인에게서는 drug-drug interaction, drug-disease interaction, disease-disease interaction으로 비전형적인 기능장애로 나타난다. 이것이 앞에서 언급한 3M과 5I이다. 그러므로 연속적인 서비스의 제공체계는 <그림 16>에서 볼 수 있듯이 건강한 상태에서부터 사망단계의 종말기까지 각종 서비스가 연계적으로 제공될 수 있어야 한다.

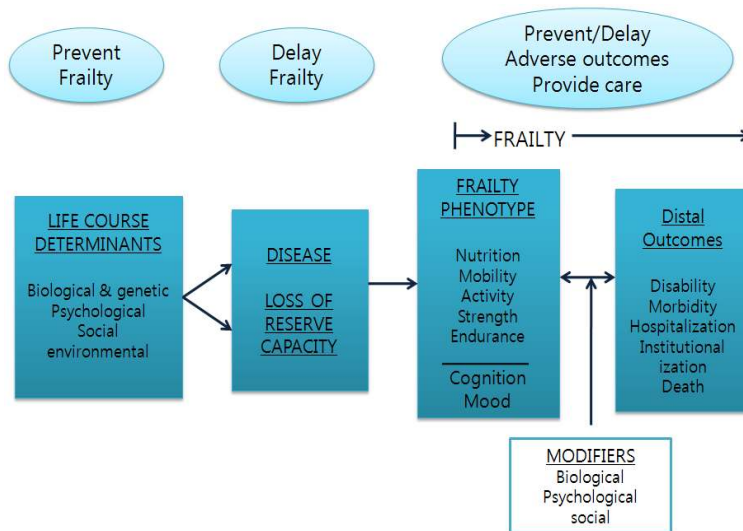


<그림 16> 신체자립성 유지/향상을 위한 노인보건의료서비스 개입

출처: 선우덕, 이윤환, 송현중, 김동진. 허약노인대상의 보건의료서비스 개발 및 효율적 운영체계구축방안. 한국보건사회연구원;2004

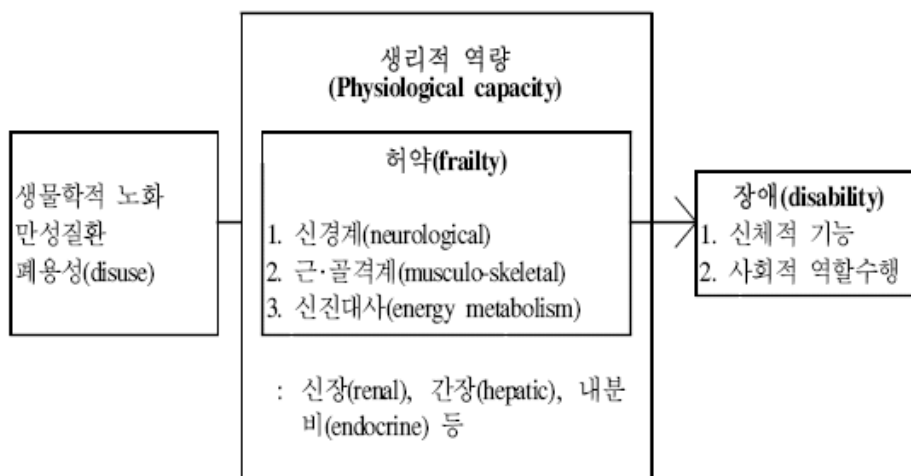
노인은 다른 연령대에서 보이지 않는 노인성 치매, 노인성 골다공증, 노인성 백내장, 노인성 난청 등 노인에서 보이는 특유 질환을 가지고 있는데, 이러한 노인들의 특징을 허약(Frailty)이라고 명하여 신체적, 심리적, 사회적 기능 감소와 질병이 동반되어 의존(dependency)이 높아진 상태로 정의내릴 수 있다 (이인숙, 서울대). 허약노인의 결과로 낙상, 사고, 육체적 결함(disability), 이동성의 악화(worsened mobility), 공공시설로 수용(institutionalization), 입원(hospitalization), 사망률(mortality)의 증가가 나타날 수 있다.

허약(frail)노인과 장애(disabled)노인의 개념을 비교하면, 허약노인은 상해가 발생할 위험에 처해 있는 상태가 장기간 지속되어 있거나 전반적인 건강수준이 위험에 빠질 수 있는 상태에 있는 노인으로 보고 있고, 반면에 장애인인은 이미 기능의 하락으로 정상적인 일상생활동작을 수행하기 위하여 제 3자로부터 실질적인 도움을 필요로 하는 자로 정의하여 명백하게 허약노인과 구별하고 있다(OECD, 1996).



<그림 17> Frailty: Working Framework
(이인숙, 한국농촌의학·지역보건학회 추계학술대회, 2008)

- 허약노인을 선정하는데 필요한 측정항목들은 연구자마다 차이를 보이고 있으며 표준화되고 타당한 허약상태의 측정방법이 없는 실정이다.



자료: Buchner and Wagner(1992)

<그림 18> 허약성과 장애의 개념적 모델

○ 허약노인을 정의하는데 있어 Fried 등(2001)의 연구에서 사용된 조작적 정의를 보면<표 28>, 체중손실, 정서적 고갈, 육체적 활동, 도보속도 및 약력의 5개의 범주로 구분하고, 이 중 3개 이상의 범주에 해당하면 허약노인으로 정의하고 있다.

<표 28> 허약의 범주와 지표내용

범주	지표내용
I. 체중손실 (weight loss)	- "체중이 지난해에 비해서 10파운드 이상 감소하였는가" (단, 고의적인 다이어트나 운동에 의한 경우는 제외) ○ "그렇다"고 응답하면, 허약으로 판정
II. 정서적 고갈 (exhaustion)	- "지난주 얼마나 자주 삶의 회의를 느끼고 있었는가" ○ 1주일에 3일 이상이면, 허약으로 판정
III. 육체적 활동 (physical activity)	- 1주일에 육체적 활동으로 인한 열량이 282kcal(남자), 270kcal(여자) 이하인 경우는 허약으로 판정 ○ 육체적 활동: 걷기, 집안일하기, 잔디 깎기, 정원 가꾸기, 하이킹, 조깅, 사이클링, 댄싱, 에어로빅, 볼링, 골프, 테니스, 라켓볼, 수영 등
IV. 도보속도 (walk time)	- 15피트 거리를 걷는 속도 - 속도가 각각 다음에 해당하면, 허약으로 판정 ① 신장 173cm 이하인 경우(남자): 7초 이상 소요 ② 신장 173cm 이상인 경우(남자): 6초 이상 소요 ③ 신장 159cm 이하인 경우(여자): 7초 이상 소요 ④ 신장 159cm 이상인 경우(여자): 6초 이상 소요
V. 약력 (grip strength)	- 남녀별 BMI 수준별로 구분하여 각각 다음에 해당하면 허약으로 판정 ① BMI ≤24인 경우(남자): 24kg 이하 ② BMI 24.1~26인 경우(남자): 30kg 이하 ③ BMI 26.1~28인 경우(남자): 30kg 이하 ④ BMI >28인 경우(남자): 32kg 이하 ⑤ BMI ≤23인 경우(여자): 17kg 이하 ⑥ BMI 23.1~26인 경우(여자): 17.3kg 이하 ⑦ BMI 26.1~29인 경우(여자): 18kg 이하 ⑧ BMI >29인 경우(여자): 21kg 이하

자료: Fried, et al., (2001)

3) 노인 건강문제의 우선순위 설정 결과

<표 29>는 앞에서 기술한 외국의 우선순위 결정기준의 과정을 통하여 우선순위를 설정하여 보았다. 질병요인으로서는 고혈압, 골다공증, 비만, 당뇨병, 고지혈증, 뇌졸중과 심장질환, 치매, 구강질환, 노인성 백내장, 낙상과 사고를, 행태요인에 있어서는 운동, 암검진, 음주, 흡연, 영양관리 등의 순서로 우선순위가 설정되었다.

<표 29> 외국의 우선순위 결정기준에 따른 우선순위 설정

순 위	질병요인	행태요인
1위	고혈압	운동
2위	골다공증	암검진
3위	비만	음주
4위	당뇨병	흡연
5위	고지혈증	영양관리
6위	뇌졸중, 심장질환	
7위	치매	
8위	구강질환	
9위	노인성 백내장	
10위	낙상, 사고	

<표 30>은 <표 29>의 결과, 보건소의 설문결과, 그리고 전문가 의견 조사를 통하여 노인건강증진을 위한 우선순위를 종합적으로 설정하였다. 그 결과 건강노인에 대한 생활습관 개선으로 건강증진강화(운동, 영양), 만성질환(고혈압, 당뇨, 고지혈증)의 관리, 암과 심뇌혈관 질환(뇌졸중, 심장질환)의 관리, 정신질환(치매, 우울증)의 관리, 구강질환, 노인성 백내장, 노인성 난청, 요실금, 간질환 및 만성폐질환(COPD), 낙상 등 사고를 우선순위를 설정하였다.

<표 30> 우리나라 노인 건강증진을 위한 우선순위 설정

우리나라의 노인 건강증진을 위한 우선순위 설정

건강증진강화: 건강노인에 대한 생활습관 개선

만성질환(고혈압, 당뇨, 고지혈증)

암, 심뇌혈관 질환(뇌졸중, 심장질환)

정신질환(치매, 우울증)

관절질환(골다공증, 관절염)

구강질환

노인성 백내장, 노인성 난청

요실금

간질환, 만성폐질환(COPD)

낙상 등 사고

4) 보건소 설문조사 결과

전국의 250개 보건소에 노인건강증진 담당자에게 전화, 이메일, 팩스 등의 통신수단으로 보건소에서 실시하고 있는 노인보건사업의 종류와 관리실태 등의 내용을 담은 설문지를 배포하였다. 총 56부가 회수되었으며 회수율은 22.4%였다.

지역사회에서 노인질환관리를 위한 프로그램으로 가장 필요하다고 생각하는 사업이 무엇이라는 물음에 고혈압 등록관리사업, 당뇨병 등록관리사업이라고 응답한 경우가 가장 높았으며, 그 뒤로 무료의치 보철사업, 고지혈증 등록관리사업, 뇌졸중 등록관리사업, 재가 암관리사업, 치매 등록관리사업, 심근경색 등록관리사업과 우울증 등록관리사업 순으로 나타났다.

<표 31> 보건소 설문조사 결과 1.

지역사회에서 노인질환관리를 위한 프로그램으로 가장 필요한 사업은?	
1위	고혈압 등록관리사업, 당뇨병 등록관리사업
2위	무료의치 보철사업
3위	고지혈증 등록관리사업
4위	뇌졸중 등록관리사업
5위	재가 암관리사업
6위	치매 등록관리사업
7위	심근경색 등록관리사업, 우울증 등록관리사업

지역사회에서 노인건강증진을 위한 프로그램으로 가장 필요한 사업이 무엇 이냐는 질문에는 운동 프로그램, 구강보건사업, 영양사업, 관절염 예방사업, 절주 프로그램, 눈질환 예방사업 순으로 나타났다.

<표 32> 보건소 설문조사 결과 2.

지역사회에서 노인건강증진을 위한 프로그램으로 가장 필요한 사업은?	
1위	운동 프로그램
2위	구강보건사업
3위	영양사업
4위	관절염 예방사업
5위	절주 프로그램
6위	눈질환 예방사업

국가에서 중점적으로 노인질환관리를 위해 가장 필요한 사업은 무엇으로 생각하느냐는 질문에는 고혈압 등록관리사업과 무료의치보철사업이 가장 많 은 응답을 차지하였고 그 다음으로 당뇨병 등록관리사업, 치매 등록관리사업, 고지혈증 등록관리사업, 뇌졸중 등록관리사업, 재가 암관리사업, 우울증 등록 관리사업, 심근경색 등록관리사업 순으로 응답하였다.

<표 33> 보건소 설문조사 결과 3.

국가에서 중점적으로 노인질환관리를 위해 가장 필요한 사업은?	
1위	고혈압 등록관리사업, 무료의치보철사업
2위	당뇨병 등록관리사업
3위	치매 등록관리사업
4위	고지혈증 등록관리사업
5위	뇌졸중 등록관리사업
6위	재가 암관리사업
7위	우울증 등록관리사업
8위	심근경색 등록관리사업

국가에서 중점적으로 노인건강증진을 위해 가장 필요한 사업을 무엇으로 생각하느냐는 질문에는 운동 프로그램이 가장 필요하다고 답하였고 영양사업, 구강보건사업, 낙상방지 예방사업, 관절염 예방사업, 절주 프로그램, 골다공증 예방사업, 눈질환 예방사업, 귀코목 질환 예방사업 순으로 응답하였다.

<표 34> 보건소 설문조사 결과 4.

국가에서 중점적으로 노인건강증진을 위해 가장 필요한 사업은?	
1위	운동 프로그램
2위	영양사업
3위	구강보건사업
4위	낙상방지 예방사업
5위	관절염 예방사업
6위	절주 프로그램
7위	골다공증 예방사업
8위	눈질환 예방사업
9위	귀코목 질환 예방사업

8. 노인건강증진의 비전, 목표 및 기본 접근 전략

1) 비전 및 목표

노인건강증진을 위한 국가의 비전/목적(Goals)은 첫째 건강수명(Health life)의 연장, 둘째 사회계층간 건강격차의 감소, 셋째 노년기 생활의 질 향상이다. 구체적 목표로는 건강노인에서부터 고위험 노인(high risk group), 만성 질환 노인, 기능장애 및 삶의 질과 관련된 다빈도 질환을 가진 노인 그리고 말기환자에 이르기까지 5단계로 나누어서 각 대상그룹에 따라 목표를 설정하였다.

첫째는 건강증진을 목표로 하여 신체활동 및 운동, 영양 및 식생활, 정신보건, 절주, 금연, 구강보건, 손상방지, 예방접종 등을 주요 방법 및 프로그램 내용으로 제시하였고, 이 단계의 주요 대상자는 건강노인이다. 두 번째로 질병의 조기발견과 주기적 관찰을 목표로 하여 조기검진, health exam, 검진가이드 라인을 방법 및 프로그램 내용으로 제시하였고 주 대상자는 질병의 발생가능성이 있는 Risk group 노인이다. 세 번째로 만성질환관리를 목표로 하여 고혈압, 당뇨, 고지질혈증, 암, 뇌졸중, 심혈관질환, 골다공증, 관절염 등 등록 관리하는 방법 및 프로그램 내용으로 제시하였고 주 대상자는 만성질환 노인이다. 네 번째로 일상생활 장애인관리를 목표로 하여 뇌졸중 후유증(기능장애), 치매, 시력 장애, 청력 장애, 요실금, 골절 등 재발방지 및 재활 방법 및 프로그램 내용을 제시하였고 주 대상자는 기능장애노인 및 삶의 질과 관련된 다빈도 질환을 가진 노인이다. 다섯 번째로 말기환자 노인을 목표로 하여 말기암환자, 와상노인 등을 위한 요양 및 보살핌 위주의 방법 및 프로그램 내용을 제시하였고 주 대상자는 말기환자 노인이다.

이와 같이 다섯가지 목표를 위한 인프라 및 접근전략으로는 Evidence-Based Health care policy를 위한 surveillance와 data system 구축이 필요하고, 이 다섯가지 목표를 생애주기별 건강증진계획과 연계하여 이루어질 수 있도록 하여야 한다. 또한 취약계층 노인에 대한 우선순위 건강보호를 강화하여야

할 것에 역점을 두어야 한다. 마지막으로 각 기관별 기능과 역할 분담을 통한 노인보건의료전달체계를 구축하여 보건의료복지 통합서비스를 제공함으로써 노인의료비를 절감 할 수 있는 접근전략으로 제시하였다.

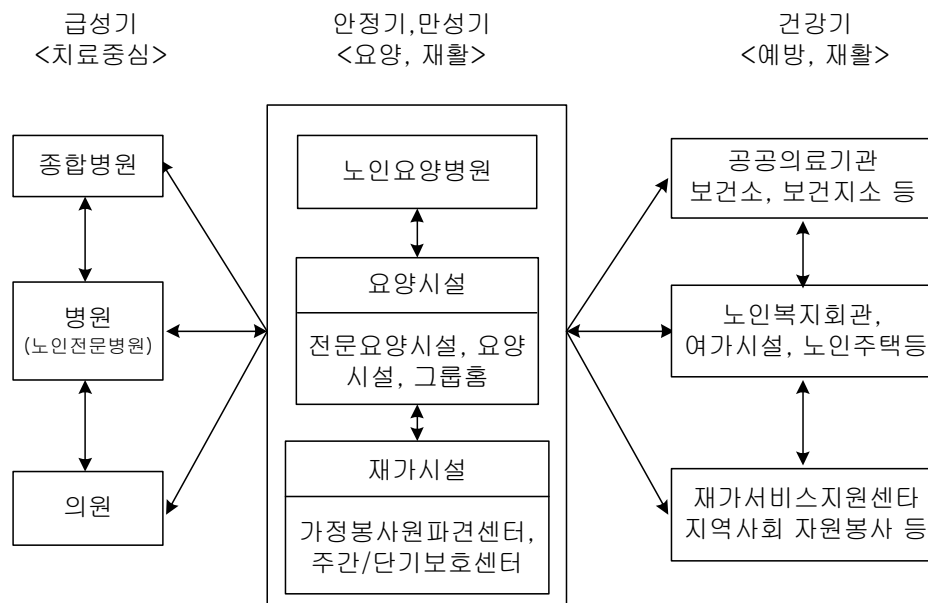


<그림 19> 비전과 목표

2) 노인의료전달체계 구축

- 노인보건의료 문제는 다양한 질환들이 병행되고 장기적인 진행 과정을 갖기 때문에 각 전문영역의 분화 및 담당기관의 유기적인 연계가 중요하다. 또한 집중적인 진료에서부터 요양서비스가 필요한 노인보건의료의 특성에 부합하기 위하여 장기요양보호(long-term care)에 관한 다양한 서비스가 개발되어 급성기 및 아급성기 병원과의 연계체계가 필요하다. 노인의 만성질환자를 위한 의료제공체계 구축의 기본방향은 향후 급증하리라 예상되는 노인의료비의 절감, 지역사회 중심 서비스 활성화 및 가족의 부담을 경감, 그리고 보건복지 연계서비스의 제공 등이 되어야 한다.

- 노인의료전달체계를 크게 세단계로 나누어 볼 수 있다. 첫 번째로는 급성기 단계로 치료가 중심이 되는 시기이다. 이 시기에 속하는 의료기관으로는 종합병원과 병원(노인전문병원), 의원 등이 있고 이들 의료기관은 서로 환자에 대한 정보를 연결시켜 적절한 서비스를 받을 수 있도록 한다. 다음 단계는 안정기 또는 만성기 단계로 요양이나 재활이 중심이 되는 시기이다. 이 시기에는 노인요양병원, 전문요양시설이나 요양시설 또는 그룹홈 등의 요양시설, 가정봉사원 파견센터나 주간/단기보호센터와 같은 재가시설 등이 이 시기에 속하는 의료기관이 된다. 다음 단계로는 건강기 단계로 예방이나 재활이 중심이 되는 시설이다. 이 시기에는 공공의료기관인 보건소나 보건지소, 노인복지회관, 여가시설, 노인주택, 재가서비스 지원센터나 지역사회 자원봉사 활동 등의 기관에서 이루어지는 시기이다. 각 단계의 노인의료전달체계를 도식화하면 <그림 20>와 같다.



<그림 20> 노인의료전달체계

출처: 의료정책과제. 의료개혁위원회. 1997

- 보건소(지소)의 노인보건사업 기능의 강화

우리나라는 재가보호서비스 제공을 통한 지역사회보호를 시설보호에 비해 정책적으로 우선순위를 갖고 접근하고 있다. 이는 노인이 오랫동안 생활해 온 지역사회 내에서 기초적인 서비스와 적절한 보호를 받는 것은 노인의 욕구에 부응하는 한편 삶을 질을 높일 수 있기 때문이다. 그러나 재가보호서비스를 활성화하기 위해서는 가정봉사원과견센터, 주간보호 및 단기보호시설의 확대 설치와 더불어, 기존 보건소(지소)의 공공기관에서 실시하고 있는 노인보건사업에 대한 기능강화를 통해 공공부문의 효율성 제고를 해야 한다. 또한 주간보호 및 단기보호시설은 현재 복지시설에서 주로 운영하고 있지만 보건소 및 병의원의 의료기관에 부설로 설치할 수 있도록 하여 기존의 시설을 활용토록 하는 방안도 모색해야 한다.

- 중앙정부와 지방자치단체의 합리적인 기능배분

- 노인보건복지 정책의 충실을 기하기 위해서는 중앙과 지방행정간의 합리적인 기능배분을 통해서 이루어져야 한다. 중앙은 지방정부에서 수행가능한 업무를 과감히 지방으로 이양하여 지역적 특성을 감안한 서비스를 계획하고 시행하도록 지원해야 한다.
- 또한 광역자치단체와 기초자치단체간 기능의 재조정도 시급한 과제이다. 특히 우리나라는 보건복지 업무와 관련해서 광역자치단체의 역할은 매우 미비하다고 할 수 있다.
- 보건의료와 복지의 종합적 계획을 위해 현재 지역보건법에 의하여 지방자치단체장은 4년마다 지역보건의료계획서를 작성하게 되는데 이때 보건 의료와 복지서비스를 통합적으로 제공할 수 있는 방안을 계획하도록 해야 한다. 이때 광역자치단체에서는 이를 지원하는 계획을 실체화하여 조정, 지원, 평가기능을 갖도록 해야 한다.

노인보건의료서비스는 노인복지의 초석이 된다. 이를 위해서는 중앙 및 지방정부의 의지와 사회적 지지가 바탕이 되어야 함은 당연하다. 효율적이고 효과적인 노인장기요양제도를 위해서는 노인에 대한 연구(욕구나 특성 등)를 바탕으로 근거에 입각한(evidence-based) 의사결정과 정책을 입안하고 현실가능한 장단기 계획을 세워 추진해 나가야 할 것이다. 그러나 보다 중요한 것은

노인에 대한 사회의 가치관을 설정하는 일이다. 노인에 대한 부정적 스테레오타입이나 사회적인 부담의 존재보다는 긍정적이고 권리의 주체로서 인식되도록 노인자신뿐 아니라 국민모두가 사회적 운동을 전개하여, 합리적인 시각으로 노인문제를 바라볼 수 있는 것이 가장 시급하고 중요한 과제라 생각한다.

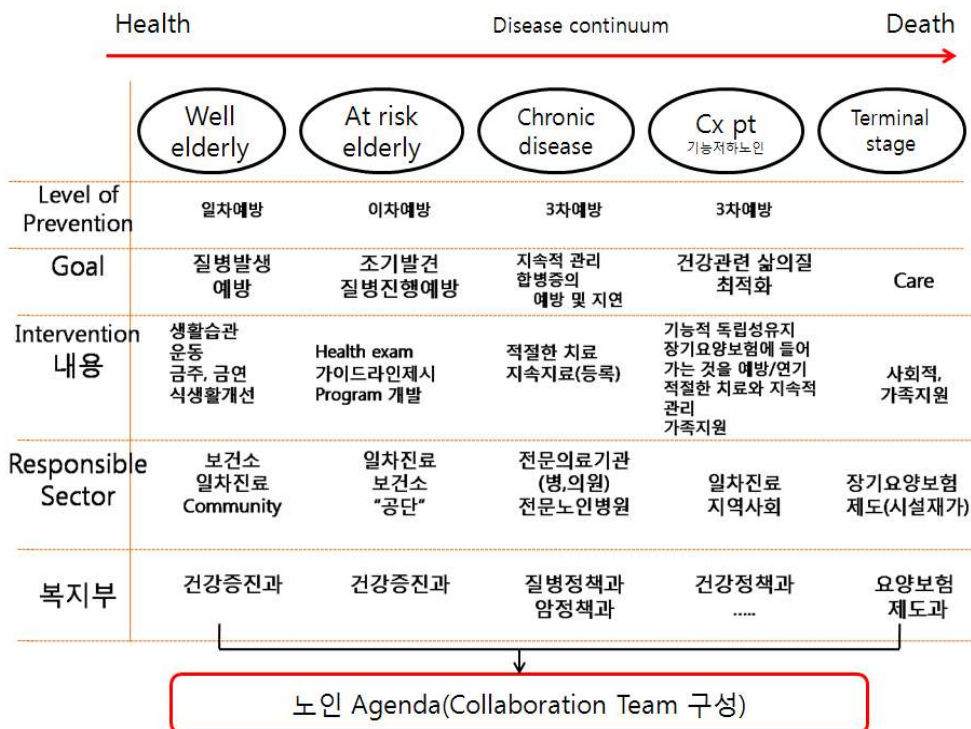
3) 국가 차원의 노인정책 결정과정 및 접근전략 모형

국가 차원의 노인정책 결정과정 및 접근전략을 5가지 노인의 건강상태에 따라 분류해 보았다. 분류한 과정을 도식화하면 <그림 21>과 같으며, 각각의 노인 건강상태에 따라 간략히 설명하면 다음과 같다.

- ① 건강한 노인(well elderly): 일차예방에 속하는 단계이며, 질병발생을 예방하는 것이 목표가 된다. 중재의 내용으로는 생활습관의 교정, 운동, 금주, 금연, 식생활 개선 등이 속하게 되고, 책임을 맡는 민간이나 공공 부문(responsible sector)은 보건소와 일차진료 기관, 지역사회가 속하게 된다. 보건복지가족부에서는 건강증진과가 담당을 하게 된다.
- ② 질병발생 가능성이 있는 노인(at risk elderly): 이차예방에 속하는 단계이며, 질병의 조기발견과 질병진행을 예방하는 것이 목표가 되는 단계이다. 중재의 내용으로는 Health exam, 검진 가이드 라인제시, program 개발이 속하게 되고, 이 단계를 책임지는 민간이나 공공 부문(responsible sector)은 일차진료기관과 보건소, 공단이 속하게 된다. 보건복지가족부에서는 건강증진과가 담당을 하게 된다.
- ③ 만성질환을 가진 노인(chronic disease): 3차예방에 속하는 단계이며, 질병의 지속적 관리와 합병증의 예방 및 지연을 목표로 하는 단계이다. 중재의 내용으로는 질환의 적절한 치료, 지속치료(등록)가 속하게 되고, 이 단계를 책임지는 민간이나 공공 부문(responsible sector)은 병,의원과 같은 전문의료기관이나 전문노인병원이 속하게 된다. 보건복지가족부에서는 질병정책과와 암정책과가 담당을 하게 된다.
- ④ 기능저하노인(complication patients): 3차 예방에 속하는 단계이며, 건강관련 삶의 질을 최적화 하는 것을 목표로 하는 단계이다. 중재의 내용으로는 기능적 독립성을 유지하는 것, 장기요양보험에 가입하는 것을 예방 또는

연기, 적절한 치료와 지속적인 관리, 가족지원을 필요로 하는 단계이다. 이 단계를 책임지는 민간이나 공공 부문(responsible sector)은 일차진료와 지역사회가 속하게 된다. 보건복지가족부에서는 건강정책과가 담당을 하게 된다.

- ⑤ 말기환자 노인(terminal stage): 질환을 관리(care)하는 것을 목표로 하는 단계로 중재의 내용으로는 사회적, 가족지원을 필요로 하는 단계이다. 이 단계를 책임지는 민간이나 공공 부문(responsible sector)은 장기요양보험 제도(시설재가)이며 보건복지가족부에서는 요양보험제도과가 담당을 하게 된다.

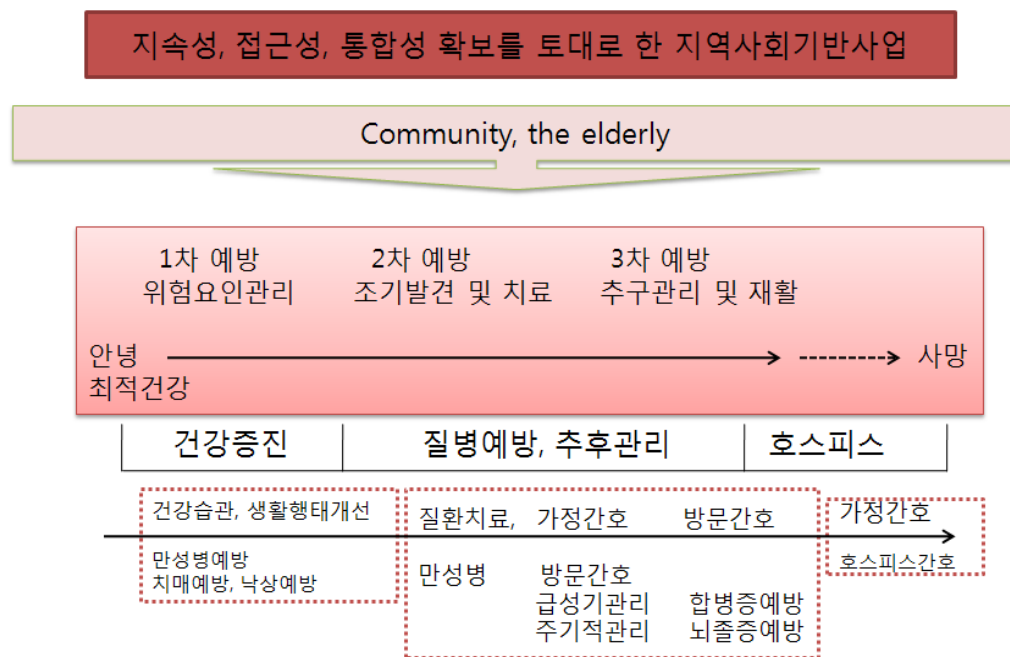


<그림 21> 국가차원의 노인정책 결정과정 및 접근전략 모형

4) 지역사회(보건소)의 노인정책 기본 접근전략 모형

지역사회(보건소)의 노인정책 기본 접근 전략을 <그림 22>로 도식화하였다. 내용을 간략히 살펴보면 다음과 같다. 지역사회에서는 지속성과 접근성, 통합

성 확보를 토대로 한 지역사회기반사업을 바탕으로 질환의 screening, case management를 실시하여야 한다. 1차 예방 단계에서는 위험요인 관리를 목표로 하여 건강증진을 실시하여 만성병의 예방, 치매예방, 낙상예방 등을 목표로 하는 건강습관 및 생활행태개선을 내용으로 한다. 2차 예방 단계에서는 질병의 조기발견 및 치료를 목표로 하여 질병예방과 추후관리를 실시하여야 한다. 그 내용으로는 만성병의 질환치료, 방문간호나 급성기 관리 및 주기적 관리 같은 가정간호, 합병증 예방과 뇌졸중 예방을 위한 방문간호가 이에 속하게 되겠다. 마지막으로 3차 예방 단계에서는 추구관리 및 재활을 목표로 하여 가정간호를 통한 호스피스를 실시하여야 한다.



<그림 22> 지역사회(보건소)의 노인정책 기본접근 전략

9. 보건복지가족부 노인건강종합대책 T/F (안)

본 연구의 핵심내용인 노인건강증진 종합대책 및 관리방안이 구체적으로 제시되지 않았는데 그 이유는, 본 연구와 동기간(2008.9월 ~ 2009.2월)에 복

지부 건강정책국내의 노인건강증진 종합대책T/F가 생기면서 중복되는 연구가 되었다. 노인건강증진 종합대책 T/F는 2주에 한번 6개 분야의 종합대책 세부안의 검토, 각 세부안의 문제점, 추진방향, 예산 등을 검토하였다. 본 연구의 책임자가 T/F에 들어가서 함께 일을 하게 되어 이 정책연구를 제안한 질병관리과와 질병관리본부와의 회의에서 새로운 아이템을 만드는 것보다는 우리나라 노인정책을 만드는데 어떤 기준을 가지고, 어떤 목표를 향해, 어떻게 할 것인지, 오히려 큰 그림안에서 우리의 위치는 어디이고, 어디로 나아가야할 방향을 제시하는 것이 본 연구의 목적으로 적합하다는 결론으로 내리고 구체적인 방안은 복지부 노인건강증진 종합대책 T/F에서 진행하고 있는 것을 받아들이기로 하였다. 복지부에서 진행하고 있는 노인건강종합대책 T/F에서 진행하고 있는 내용의 개요는 아래의 <표 35>에 제시하였고, 자세한 내용은 확정된 안이 아니기 때문에 아직 공개하지 못했다.

○ 목적

- 노인건강 확보 및 노인의료비 절감을 위해 노인건강종합대책 수립

○ 구성: 총 23인(팀장: 건강정책국장)

- 학계·전문가(14인): 노인의학, 노인병, 예방의학, 내과, 가정의학, 사회의학, 영양, 운동, 간호 등 관련 교수
- 유관기관(3인): 도보건위생과, 보건소장, 건보공단, 건강증진사업지원단 등
- 정부(6인): 건강정책과, 질병정책과, 노인정책과, 보험정책과, 질병관리본부 등

<표 35> 노인건강종합대책 T/F 안

주요 정책과제 명	담당부서	협조부서
I. 노령기 기초건강증진 강화		
1) 운동, 영양, 금연 등 건강행태개선 토털케어 체계 마련 ① 건강생활 실천을 지원하는 토털 서비스제공 체계 마련 ② 건강생활 실천과 다른 보건사업과의 연계 운영 방안 마련 ③ 전국적인 노인 생활체육 활성화를 위한 국민 운동 추진	건강증진과	건강보험공단 문화체육관광부 체육국
2) 취약계층 노인을 위한 건강관리 강화	건강증진과	건강정책과

3) 제3차 국민건강증진종합계획('11~'20) 수립		건강정책과
II. 중증질환의 조기 발견		
1) 5대암 검진 수검률 제고 ① 암 조기발견-완치를 지지하는 사회적 환경 조성 ② 암검진 비용에 대한 본인부담 경감 ③ 암검진기관 확충 및 접근성 개선	암정책과	보험정책과 요양보험제도과
2) 노령기 중증질환을 목표로 한 건강검진체계 개편 ① '심·뇌혈관 질환' 예방을 목표로 건강검진체계 개편 ② 노인에게 대하여 특화된 건강검진 항목 추가	건강증진과	보험정책과
3) 직장내 건강검진률 향상 ① 건강검진률에 따른 산재보험료를 차등화 ② 건강검진 수검을 위한 'Healthy Holiday' 휴가제도 도입	건강증진과 암정책과	노동부 산업안전보건국 산재보험과
III. 기저질환의 적정 관리로 중증질환 악화 방지		
1) 고위험군에 대한 건강검진 사후관리 서비스 제공 ① 사후관리 대상 중점질환 선정 및 관리모형 개발 ② 건강관리서비스 바우처·인센티브 도입	건강증진과	건강정책과
2) 고혈압·당뇨병 등 만성질환 관리체계 혁신 ① 효과적인 만성질환 등록·관리모형 개발 ② 등록관리 시스템을 기반으로 만성질환 건강 포인트 도입 ③ 의료기관에 대한 성과연동 지불체계(P4P) 도입	질병정책과	보험급여과 질병관리본부 만성병조사팀
VI. 중증질환자 사후관리로 재발 방지		
1) 중증질환자 사후관리 모형 개발 및 역할 재정립 ① 중증질환자 정보 등록 및 사후관리 모형 개발 ② 각 전달 체계 별 역할 분배 및 연계 방안 마련 ③ 요양병원, 요양시설 등의 건강관리 기능 강화	질병정책과 건강정책과	보험정책과 노인정책과 보험급여과 요양보험운영과
2) 간병·가정간호서비스의 질적 수준 제고 ① 간병인력에 대한 국가자격 도입 검토 ② 가정간호서비스 활성화를 위한 건강보험 수가 체계 개편	의료제도과 보험급여과	

V. 삶의 질을 악화시키는 다빈도 질환 예방관리		
1) 치매 조기 검진 및 예방관리 강화 ① 노인치매 조기검진체계 구축 ② 치매의심환자에 대한 예방서비스 제공	노인정책과	건강증진과
2) 눈·귀 건강관리 강화 ① 65세 이상 건강검진에 안저검사 추가 ② 저소득층 황반변성 노인환자 지원사업 신설 ③ 건강검진 이후 경도난청 환자 사후관리교육 강화 ④ 저소득층 노인난청에 대한 보청기 지원 및 관리 제공	질병관리본부 만성병조사팀	보험급여과 건강증진과
3) 노인 의치보철 지원 확대 및 구강건강 예방 강화 ① 보건소 저소득층 의치보철사업 확대 실시 ② 취약노인에 대한 불소도포·스케일링사업 실시	생활위생과	
4) 낙상 등 손상방지를 위한 대책 수립 ① 가구 환경 조사 및 안전수칙 제정·공포 ② 저소득 취약노인에 대해 미끄럼 방지 장비 등 환경 지원	질병관리본부 만성병조사팀	질병정책과
5) 골다공증, 관절염 등 근골격질환 관리 강화 ① 근골격질환 예방·관리를 위한 생활수칙 제정 및 홍보 ② 저소득 관절염 노인에 대한 관절치환술 지원	질병관리본부 만성병조사팀	질병정책과
VI. 노인 건강정책 인프라 확충 및 효율화		
1) 노인건강 통계 신설 및 정책 평가기반 강화 ① 국민건강영양조사 중 노인건강통계 강화 ② 시군구별 노인건강실태조사 실시	질병관리본부 만성병조사팀	건강정책과
2) 노인 건강전달체계 기능 재정립 및 연계체계 구축	건강정책과	노인정책과 요양보험운영과 보험정책과 노인지원과
3) 노인 건강정책을 위한 재정투자 확대	건강정책과	예산과

10. 노인건강지표 항목 개발

노인건강 종합계획을 수립하여 사업을 실시하려면 관리 목표와 구체적인 성과지표가 설정되어야 한다. 명확한 목표와 달성할 지표는 사업의 평가뿐만 아니라 관리 전략에서도 필수적인 것이다. 우리나라 Health People 2010에서는 노인건강지표로는 ADL 밖에 없다. 따라서 일본, 미국의 사례를 참조하여 노인건강지표에 대한 항목만 우선 설정하였다.

측정가능한 지표를 자세히 제시할 수 없는 것은 우리나라의 baseline data가 없기 때문에 선불리 설정할 수 없었으며, 지금 준비 중인 Health People 2010에서는 다음의 표를 참조하여 구체적이고 실현가능한 지표 수준을 만들어야 할 것이다.

<표 36> 노인건강지표 항목

영역	지표 항목	사업관리 목표(2020)
예방접종, 건강진단	- 인플루엔자 예방접종률 - 파상풍 수검율 - 건강진단 수검율	
영양, 식생활	- 하루 3끼 먹는자 비율 - 과체중 유병률, 비만율 - 소금 섭취량	(예)과체중 유병률 25%에서 20%로 줄인다. (예) 1일 소금섭취량 15gm에서 10gm으로 줄인다.
신체활동, 운동	- 규칙적인 운동자 비율 - 일상생활에서 걷기 - 외출 가능자	(예)1주일 3회 이상 30분 이상 운동자 15%에서 25%로 증가한다.
금연	- 흡연율 - 금연 프로그램 참여자율, 금연율	예) 65세 이상 노인의 흡연율 30%에서 25%로 줄인다.
절주	- 고도음주자율 - 절주 프로그램 참여자율, 절주율	
정신건강	- 자살자 수 - 우울증 - 인지기능저하, 치매율	

구강보건	- 치아 손실 - 치과 검진율 - 의치	(예) 1년간 정기적인 치과 검진 수진자율 10%에서 20% 로 증가
골건강	- 골다공증 - 낙상경험, 골절률	
당뇨병	- 검진 및 추후관리 - 유병률 - 지속 치료율/관리율 - 합병증 발생률	
고혈압	- 고혈압 유병률 - 지속 치료율/관리율	
뇌심혈관질환	- 관상동맥 사망률 - 뇌혈관 질환 사망률 - 고지혈증 유병률 - 칼슘, 포타슘 섭취량	
암	- 5대 암 검진률	

11. 향후 계획

본 연구결과로 노인건강증진 종합대책을 위한 향후 필요한 요건들을 정리해 보면 다음과 같다.

- 1) 국가의 노인보건정책에 대한 비전 및 목표 합의가 필요하다.
- 2) 보건복지가족부의 노인보건정책 부서의 통합 및 의사결정과정의 개선이 필요하다.
- 3) 체계적인 국민건강증진 운동을 전개하여 전 국민 건강증진에 대한 홍보를 강화하여야 한다.
- 4) 노인보건의료전달체계를 구축하여 각 부서의 역할과 기능을 명확히 하여 연계와 통합을 강화하여야 한다.

- 5) 지속적으로 노인 건강관련 자료를 수집하고 분석하여 근거중심 정책의 기반을 확립하고 정책의 평가를 하여야 할 것이다.
- 6) 질관리 및 평가를 체계적으로 지속하여야 한다.
- 7) 노인건강관리 예산 투입을 적절히 하여야 한다.
- 8) 보건의료-복지 통합(연계)연계 시스템을 구축하여 서비스의 통합을 시도 하여야 한다.

제 4 장 연구목표 달성도 및 대외기여도

1. 연구목표 달성도

이 연구의 목적은 우리나라 노인의 건강수명 연장과 삶의 질 향상을 위하여 고령인구가 점증하고 있는 우리나라의 사회, 경제, 문화적 여건 변화 속에서 노인계층을 위한 노인 건강유지 및 증진을 위한 종합대책 및 관리방안을 개발하기 위함이며, 아래와 같은 구체적 목표를 설정하여 연구를 수행하였는데 연구결과에서 언급한 바와 같이 모두 목표가 차질 없이 달성되었다고 생각한다.

- 1) 우리나라 노인의 건강수준과 주요 건강문제(질병), 그리고 노인의료비에 대한 실태를 파악하였다.
- 2) 보건복지가족부 부서별, 정책별로 분산되어 있는 노인관련 정책, 법률 그리고 의사결정과정 등을 파악하였다.
- 3) 현재 시행중인 노인 건강대책의 사업범위 및 주요 사업(프로그램)을 파악하였다.
- 4) 노인 건강관리를 위한 정책 및 사업범위의 우선순위 설정을 위한 기준을 마련하고 이에 의해 우선순위를 설정하였다.
- 5) 근거중심의 노인 건강증진 종합대책을 위한 국가 비전과 장·단기 목표를 개발하였다.
- 6) 노인 건강증진의 목표를 달성할 수 있는 국가차원 및 지역사회(보건소)차원에서의 관리전략과 평가지표항목을 개발하여 효과적인 추진전략을 제시하였다.

2. 대외 기여도

이 연구에서는 우리나라의 노인건강종합대책을 위한 기본 방향을 제시하였다. 그동안 노인건강을 위한 종합대책이 없는 실정에서 국가의 노인정책에 관한 비전, 목표 및 평가지표 항목 등 기본전략을 개발하였기에 종합적인 노인건강관리 방안을 위한 자료를 제공하는 데에 효과적인 것으로 평가된다.

- (1) 이 연구는 보건복지가족부의 노인 관련 정책 및 사업을 조사하여 분석하였으므로, 노인을 위한 건강정책과 관련된 서비스를 개발하는 부처간 사업내용을 상호 이해하고 협조할 수 있는 기초 자료를 제공하였다.
- (2) 서비스를 직접 제공하는 보건소 조사를 통하여 노인관련 사업 및 프로그램의 종류와 문제점 등을 파악할 수 있음으로서 종합적이고 체계적인 노인건강 서비스 개발에 기여할 것으로 생각된다.
- (3) 향후 Health People 2020에서 노인건강에 대한 평가지표를 만드는데 기초 자료로 활용할 수 있다.
- (4) 노인을 위한 보건의료와 복지의 통합적 서비스를 위한 접근전략을 어느 기관에서도 활용이 가능하다.
- (5) 노인의료전달체계에서 각 기관의 역할과 기능을 제시하였으므로 보건의료·복지서비스의 연계가능성에 대한 자료로 활용할 수 있어 향후 우리나라 노인을 위한 장기요양서비스 정책에 참고할 수 있는 자료를 제공하였다.

제 5 장 연구결과의 활용계획

1. 활용 계획

이 연구는 우리나라 노인의 건강상태와 관련된 정책, 사업, 법 등을 조사하여 분석하였으므로, 노인을 위한 보건정책과 관련된 서비스를 개발하기 위한 기초 자료를 제공하였다. 특히 국가의 노인보건정책에 관한 비전과 목표 및 평가지표 항목들을 제시하였으므로 중장기 노인건강증진을 위한 실제적이고 구체적인 종합 대책을 수립하는데 활용이 가능하다.

또한 보건복지가족부의 노인정책 관련 부서의 연계가능성 및 문제점들을 제시하였고, 물론 노인에게 직접 서비스를 제공하는 보건소에서도 노인을 위한 통합적 관리방안을 수립하는데 기여할 것으로 기대된다.

2. 추가연구의 필요성

이 연구결과로 다음과 같은 지속적인 추진과제가 진행되어야 할 것으로 생각됩니다.

- 1) 국가의 노인보건정책에 대한 비전 및 목표에 대한 합의가 필요하다.
- 2) 보건복지가족부의 노인보건정책 부서의 통합 및 의사결정과정의 개선이 필요하다.
- 3) 체계적인 국민건강증진 운동(movement)을 전개하는 전국민 건강증진에 대한 홍보 전략을 수립하여야 한다.
- 4) 노인보건의료전달체계를 구축하여 각 기관별 역할과 기능을 명확히 하고, 보건-의료-복지 통합(연계)시스템을 구축하여 서비스의 통합을 시도하여야 한다.
- 5) 지속적으로 노인 건강관련 자료를 수집하고 분석하여 근거중심 정책의 기반을 확립하여 서비스 질 관리 및 평가(지표) 체계를 구축하여야 한다.
- 6) 노인건강관리를 위한 예산 마련 방안을 강구하여야 한다.

참 고 문 헌

- 건강보험심사평가원. 2005
- 건강보험통계연보. 2000, 2001, 2002, 2003
- 국립사회보장·인구문제연구소: 인구통계자료집. 2006
- 국민건강보험공단. 내부자료. 2008
- 국민건강영양조사. 2005
- 기초노령연금법
- 김성순: 고령사회에 대비한 노인복지법의 문제점과 개선방향. 한국노인복지학회. 2002
- 김태현: 노년학. 교문사. 1999
- 유승흠, 이윤환: 노인보건학. 계축문화사. 2007
- 노인복지법
- 노인장기요양보험법
- 서순림: 노인건강증진. 현문사. 2006
- 송미순, 김신미, 오진주: 노인간호의 연구와 전망. 서울대학교출판부, 1997
- 이가옥: 노인복지의 현황과 과제. 나남출판. 1999
- 이순형: 노인의학. 의학교육연수원 편. 서울대학교출판부. 2003
- 이용석: 노인장기요양보험법의 주요 내용과 문제점에 대한 검토, 한국보험학회 79권. 2008
- 이인숙: 허약 예방을 위한 맞춤형 방문건강관리사업 관리 방안. 한국농촌의학·지역보건학회 추계학술대회 . 2008
- 이정애: 노인건강증진 허브보건소 사업. 건강증진기금연구사업 보고서. 2006
- 이정애: 우리 나라 노인보건 현황 및 향후 발전방향. 노인보건사업의 발전방향모색을 위한 워크샵, 광주. 1997
- 장성통계연보: 장성군. 2001
- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률
- 장인협, 최성재: 노인복지학. 서울대학교출판부. 서울. 1996
- 정경희 외: 1998년도 전국노인생활실태 및 복지욕구조사. 한국보건사회연구원. 1998
- 정두채: 만성퇴행성질환 국가관리체계 구축연구. 한국보건사회연구원. 1998

- 조남훈, 문현상, 이삼식, 김승권, 오영희: 최근의 인구동향과 대응전략. 한국보건사회연구원. 1998
- 조성일: 건강증진사업을 위한 보건소와 민간병원의 협력 모형 개발. 보건복지가족부 건강증진기금 연구사업 보고서. 2003
- 조유향: 노인보건. 현문사, 1995
- 최신타 역: 노년사회학. 경문사. 1985
- 통계청: 가계조사. 각년도
- 통계청: 고령자 통계. 2007
- 통계청: 사망원인 통계. 각년도
- 통계청: 인구 동태 통계. 각년도
- 통계청: 장래인구추계. 2006
- 한국보건사회연구원: 2004년도 전국 노인생활실태 및 복지욕구조사. 2004
- OECD health data. 2007
- U.S. Department of Health and Human Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Planned Approach to Community Health: Guide for the Local Coordinator. Atlanta, GA;1993
- U.S. Department of Health and Human Services. Healthy People 2010: Understanding and Improving Health, 2nd ed. Washington, DC: U.S. Government Printing Office; November 2000: 17, 24
- UN: The Sex and Age distribution of world population

<부록 1>

보건소 노인건강증진담당자 설문지

안녕하십니까?

지역 일선에서 국민 건강증진을 위한 노력에 감사드리며, 본 설문지는 보건복지부의 용역과제인 「노인건강증진을 위한 종합대책 및 관리방안 개발」을 위하여 보건소에서 노인건강증진 업무를 담당하고 계시는 분들에게 국가 노인건강증진 정책 개발을 위한 기초 자료를 생성하기 위하여 실시되는 것입니다. 조사내용은 코드화하여 입력될 것이며 귀하께서 소속된 보건소에 대한 부분과 설문내용은 보안 유지하도록 하겠습니다. 평소 귀하께서 노인건강증진 관리 사업을 수행하시면서 고민하셨던 내용을 솔직히 답변하여 주시면 감사드리겠습니다.

연구 책임자 : 전남의대 이정애(062-220-4163)

공동 연구자 : 전남의대 신준호(062-220-4164),

전남의대 신민호(062-220-4166)

서남의대 이영훈(061-620-0370)

연구 보조원 : 전남의대 김혜연(062-220-4170)

전남의대 윤우준(062-220-4170)

설문지 보내실 곳 : Fax (062)233-0305

☐ 설문 응답자의 일반적인 특성

소속 보건소명		65세이상 인구비율	%	지역관할 인구	명
보건소 형태	① 대도시형 ② 도시형 ③ 도농복합형 ④ 농촌형				

1. 지역사회에서 노인을 위한 프로그램으로 필요하다고 생각하시는 정도를 표시해주시시오.

만성질환관리	고혈압 등록관리사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
	당뇨 등록관리사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
	고지혈증 등록관리사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
심뇌혈관질환	뇌졸중 등록관리사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
	심근경색 등록관리사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
정신질환	치매 등록관리사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
	우울증 등록관리사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
관절질환	골다공증 예방관리사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
	관절염 예방관리사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
건강증진	운동 사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
	영양 사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
	절주 사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
구강보건	구강보건사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
	무료의치보철사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
손상관리	낙상방지 사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
암관리	채가 암관리사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
	말기암환자전문기관 운영지원	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
기타	귀, 코, 목 질환 예방관리 사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)
	눈질환 예방관리사업	1점 (필요성이 없다)	5점	10점 (정말 필요하다)

2. 현재 보건소에서 실시하고 있는 구체적인 사업은 무엇입니까?(노인건강증진
자조교실 및 만성질환관리사업 등을 포함하여 작성하여 주십시오)

○ 투입요소

예 산	천 원	인 력	전담 : 정규(명), 일용(명), 계약(명) 겸임 : 정규(명), 일용(명), 계약(명)	
위탁운영여부	① 예() ② 아니오		위탁 운영체	

○ 사업내용(구체적으로 기술, 각 사업별 사업대상인원 명시)

사업내용		대상인원	
사업내용		대상인원	
사업내용		대상인원	

○ 사업의 목표(결과(또는 산출) 목표 위주로 작성)

사업목표	
사업목표	
사업목표	

3. 보건소에서 노인보건 프로그램 시행시 어려운 부분은 무엇입니까?

--

4. 국가가 중점을 두고 실시해야할 노인건강 프로그램이라고 생각하는 정도를 표시해주시십시오.

만성질환관리	고혈압 등록관리사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
	당뇨 등록관리사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
	고지혈증 등록관리사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
심뇌혈관질환	뇌졸중 등록관리사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
	심근경색 등록관리사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
정신질환	치매 등록관리사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
	우울증 등록관리사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
관절질환	골다공증 예방관리사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
	관절염 예방관리사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
건강증진	운동 사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
	영양 사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
	절주 사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
구강보건	구강보건사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
	무료의치보철사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
손상관리	낙상방지 사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
암관리	재가 암관리사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
	말기암환자전문기관 운영지원	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
기타	귀,코,목 질환 예방관리사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)
	눈질환 예방관리사업	 1점 (필요성이 없다) 5점 10점 (정말 필요하다)

<부록 2> 워크샵일정

노인건강증진을 위한 종합대책 및 관리방안개발 전문가 워크샵

- ◎ 일시 : 08. 12. 18(목) 14:00~18:00
- ◎ 장소 : 전남대학교 의과대학 예방의학교실 세미나
- ◎ 일정

<1 부> 노인건강증진 종합대책의 필요성 및 복지부 정책소개		
14:00~14:30	노인의료비 증가와 노인대상 건강관리사업의 중요성	김혜연 (전남의대 예방의학교실)
14:30~15:10	보건복지가족부의 노인관련 정책 소개	신준호 (전남의대 예방의학교실 부교수)
좌장 : 이정애(전남대학교 예방의학과 교수)		
15:10~15:50	종합토의	<토론자> 박종춘(전남의대 내과 교수) 장경식(조선의대 내과 교수) 정진원(원광의대 내과 교수)
15:50~16:00	Coffee Break	
<2 부> 노인건강증진을 위한 종합대책 발전방향		
16:00~16:30	공중보건학적 관점에서의 노인의 질병관리	정은경(전남의대 의학교육학 조교수)
좌장 : 신일선(전남의대 정신과 교수)		
16:30~17:30	종합토의	<토론자> 박옥영(서남의대 내과 교수) 정상영(전남의대 외과 교수) 이삼규(전남의대 재활의학과 교수) 임건한(베스트 신경과 과장) 김 원(광주보훈병원 내과 과장)
17:30~18:00	결론 및 노인건강문제 우선순위 설정	이정애(전남의대 예방의학 교수)

- ◎ 후원 : 전남대학교 의과대학 노화연구센터

<부록 3> 보건소에서의 노인보건사업의 종류

골다공증 및 낙상

(1) 골다공증성 골절의 현황 및 의료이용 실태 파악

- 국민건강보험공단 자료에 의하면 골다공증의 진료 건수는 371,042건임. 골다공증 수진 건수로 파악된 의료이용은 14.7%, 치료제 매출액 기준으로 본 치료 배율은 약 14.3%에 불과함.
- 대표적인 골다공증성 골절인 손목골절, 대퇴부골절, 척추골절의 발생율은 2005년 기준 각각 손목골절 남자 8,390건, 여자 37,472건, 대퇴부골절 남자 7,631건, 여자 16,066건, 척추골절 남자 23,393건, 여자 83,257건임. 단 척추골절은 75%가 무증상으로 알려져 전체 발생율을 반영 못함.
- 골다공증 조사-감시 체계 파악 및 개선 방안 검토
현행 정부-지방자치단체의 골다공증 조사-감시 체계조사결과 정부차원의 관리프로그램은 없었다. 골절에 대한 감시를 위해 전국거점 병원의 네트워크를 구축하여 네트워크 병원을 주축으로 하는 손목골절과 고관절 골절에 대한 보고체계를 구축할 필요가 있다.
- 노인에서의 골다공증 방지를 위한 운동 가이드라인
 - 운동은 근력을 증가시킬 수 있도록 충분한 강도가 되는 것이 필요하다. 근력 약화가 낙상의 주 위험인자로 알려져 있기 때문이다. 근력 강화를 위한 저항 훈련은 근육을 키우는데 가장 좋은 운동이지만 유산소 지구력 운동도 근력을 어느 정도 호전시킬 수 있다.
 - 균형 훈련은 낙상을 예방하는 프로그램의 일부로서 매우 중요하다. 여기에는 균형훈련 등이 포함된다. 체중을 부하시키고 균형 유지를 위해 힘이 들어가게 하는 운동은 모두 균형 유지 능력을 향상시키고 낙상을 감소시킨다.

- 운동은 평균 일주일에 3번씩 한번 할 때 30-45분간 하고 이를 적어도 3개월 동안 지속해야 근력과 균형에 실질적인 효과가 있다. 그리고 만약 도움이 된다면 이를 지속해야 한다.
- 낙상으로 고생하는 사람들은 운동 능력 검사를 포함하여 낙상 위험평가를 받아야 한다.

(2) 정부 주도의 보건시스템에서의 골다공증 예방대책

- 정부와 보건소 등의 공공의료전달체계의 적절한 역할은 가장 중요할 수 있다. 이러한 공공 보건시스템의 가장 중요한 역할은 국민들과 의사들에게 골건강의 중요성을 알리고, 골질환에 대한 예방, 평가, 치료로서 가장 좋은 방법을 소개하는 것이다.

(가) 의료계, 지역사회 단체, 공중보건체계 간의 연결 확대

현재는 주로 민간 의료계 위주로 골다공증의 진료가 이루어지고 있지만 향후 노령화에 따라 급격히 증가하게 될 골다공증 및 골절은 대표적인 만성 퇴행성 질환의 하나로 정부 주도의 관리체계의 필요성이 대두될 수 있다. 현재는 민간과 공공 부문의 연결고리가 없지만 **향후 공공부문에서는 낙상방지 교육과 골밀도 스크리닝 정도를 제공하고 민간 부문에서는 일차 진료 혹은 전문가에 의한 진료를 담당할 수 있을 것이다.**

(나) 1차 의료인에 대한 교육 지원

정부가 취할 수 있는 또 다른 접근법은 1차 의료진들이 골건강을 증진시키고 골질환을 이해하고 치료하는데 더욱 능숙해지도록 하는 재교육을 지원하는데 있다. 정부는 학회 등 전문가 집단과 협력해 연수강좌나 세미나를 공동 후원하고, 교육과정을 개발하고 발전시켜나갈 수 있다.

(다) 골건강에 대한 대국민 홍보

- ① 청소년들에게는 영양(칼슘과 비타민 D섭취 등), 생활습관변화(금연, 절주 등), 최대 골질량을 이루기 위한 신체활동을 강조할 수 있다. 이와 대조되게 이미 골다공증으로 인한 골절로 고생하고 있는 노년층에게 주는 메

시지는 적절한 약물치료와 실질적 예방조치를 받고 있는지 여부에 초점을 맞추어야 한다.

- ② 매체 활용: 젊은 층은 인터넷, 저녁 텔레비전과 극장 등의 광고, 젊은 취향의 잡지가 효과를 높일 수 있을 것이다. 노인들은 낮 시간 TV, 잡지, 노인정 등에서 가장 와 닿을 수 있을 것이다. 예를 들어 다음과 같은 낙상 방지 수칙을 매체를 통해 홍보하는 것 등이 좋은 방법이 될 수 있다.

1. 규칙적인 운동을 시작하라	•운동은 낙상을 예방하는 가장 중요한 방법임. 운동은 근력을 강화시키고 균형감각을 개선시키는데 도움을 줌. 운동 부족은 근력 약화를 초래하고 낙상 위험을 증가시킨다.
2. 집에서 넘어지기 쉬운 위험을 제거하라	•가. 걸어가는 공간에 걸려 넘어질 수 있는 물건들(책, 종이, 옷가지)등을 치울 것 •나. 카펫이 미끄러지지 않게 고정할 것 •다. 자주 쓰는 물건을 꺼낼 때 받침대를 놓지 않고 꺼낼 수 있도록 선반의 낮은 곳에 놓을 것 •라. 변기, 욕조 주변에 손잡이를 설치할 것 •마. 욕조 바닥에 미끄러짐을 예방할 수 있는 고무 깔판을 놓을 것 •바. 집의 조명을 더 밝게 할 것 •사. 계단에 손잡이를 만들 것 •아. 발바닥에 미끄러짐을 예방할 수 있는 신발 깔창을 깔 것
3. 복용 중인 약 중 낙상을 유발할 만한 약이 있는지 확인하라	•예를 들면 수면제, 안정제, 혈압약 등 낙상을 유발할 만한 약이 있을 수 있다.
4. 시력을 확인하라	•안과에 가서 시력을 확인 할것. 안경 뒤통수가 안 맞을 수도 있고 백내장이 나 녹내장이 있을 수도 있음. 시력이 나쁘면 낙상의 위험이 증가한다.

생애전환기 건강진단

(1) 생애주기별 평생건강관리체계 구축

- 사전예방적·생애주기별 건강증진사업 추진 및 모자보건, 학교보건, 직장보건, 노인보건 등 보건의료서비스 체계화

《 현행 건강검진과 생애전환기 건강진단 비교 》

예방서비스 주요 영역	현행 건강검진	생애전환기 일제 건강진단
건강위험 평가	체계적인 건강위험 평가를 위한 문진 및 검사항목 미흡	체계적인 건강위험평가도구 도입 - Health Risk Appraisal - 노인 신체기능 평가
예방접종	제공하지 않음	성인 예방접종(인플루엔자) 등 바우처 형태로 제공 검토
선별검사	성별, 연령별 건강문제를 고려하지 않은 획일적인 검사항목으로 구성	성별, 연령별 특성을 고려한 과학적 건강검진 프로그램 제공
생활습관개선 상담	제공하지 않음	생활습관개선 처방 도입

(2) 생애전환기 건강진단의 신규 도입 프로그램

- 연령별 검사항목 추가
 - 40세: 우울증, TG, HDL, Cr
 - 66세: 40세 +치매, 골다공증(여자)
- 건강위험평가(Health Risk Appraisal, HRA)
 - 현재 건강보험공단에서 일부 가입자를 대상으로 시행하고 있는 건강위험평가 내용을 보완하여 전체 대상자로 확대
 - 한국형 심뇌혈관질환 위험도 예측모형 개발
- 노인기능평가 도입
 - ADL, IADL, 낙상경험, 배뇨장애
 - 근력, 평형성

<건강위험요인평가>

건강위험요인	현재상태	목표	건강신호등		
			안전	경계	위험
비만 평가 (체중/허리둘레)	비만/복부비만 (74Kg/91cm)	정상 체중/허리둘레 (53~66Kg/90cm미만)			
음주	위험음주	하루 2잔 미만			
흡연	과거흡연	금연유지			
운동 (신체활동)	부족	충분한 신체활동			
혈압 (mmHg)	135/83	120/80미만			
공복혈당 (mg/dL)	120	110미만			
LDL 콜레스테롤 (mg/dL)	162	100미만			

(3) 일본의 건강보험 특정건강검진 내용

① Metabolic syndrome(대사증후군, 내장지방증후군)에 초점을 둠

※ 복부에 지방이 쌓이는 내장지방형 비만에 고혈압, 고혈당, 지질이상(지질이상)의 위험인자를 중복하여 가지고 있으면서 생활습관병 발병확률이 높은 상태를 “metabolic syndrome”라 함

② 생활습관병은 비만증이나 고혈압, 고지혈증, 당뇨병 등인데, 이러한 질병은 각각이 독립된 별도의 질병이 아니고, 내장에 지방이 축적한 ‘내장지방형 비만’이 공통의 원인임이 규명됨

③ 이러한 위험인자의 수가 많으면 많을수록 생명에 깊게 관련되는 심장질환이나 뇌졸중 발병할 위험이 높아짐

④ 특정건강검진은 내장지방형 비만을 발견하기 위한 복부둘레 측정이나 심장질환이나 뇌졸중 등의 위험인자를 판정하기에 효과적인 **LDL콜레스테롤 검사**와 **당뇨의 관리 정도를 평가하기 위해 공복시 혈당과 HbA1c를 검사항목에 포함하여**, metabolic syndrome 해당자나 예비군을 가능한 빨리 발견하는 검진을 실시

⑤ 특정보건지도는 검진결과에 따라 본인이 건강상태를 이해하고, 생활습관 개선을 위해 자주적인 대응방법을 계속적으로 시행할 수 있도록, 전문가(의사·보건사·관리영양사)에 의한 생활습관개선 등을 서포터 함.

□ 특정건강진단 항목

○ metabolic syndrome(내장지방증후군)에 주목한 건강진단으로 다음 항목임

기본적 항목	○ 질문표(복약력, 흡연력 등) ○ 신체계측(신장, 체중, BMI, 복위) ○ 혈압측정 ○ 이학적 검사(신체진찰) ○ 소변검사(뇨당, 뇨단백) ○ 혈액검사 :지질검사(중성지방, HDL콜레스테롤, LDL콜레스테롤) ,혈당검사(공복시 혈당 또는 HbA1c), 간기능검사(GOT, GPT, γ-GTP)
정밀 건강진단 항목	※ 일정한 기준 하에 의사가 필요하다고 인정한 경우에 실시 ○ 심전도 ○ 안저검사 ○ 빈혈검사(적혈구, 혈색소량, 헤마토크리트치)

□ 우리나라의 생애전환기 건강진단의 문제점

	문제점	대안방안
(1) 만 40세와 만 66세 건강진단	만 40세와 만 66세의 건강검진 기간의 term 이 너무 길다.	5년 이내로 검사 주기를 및 횟수를 늘리자
(2) 건강진단 후 발견된 질환	발견된 질환의 관리와 교육이 되지 않고 있다.(현재 의사에게 상담비 1회만 인센티브로 주고 있다.)	의사의 교육에 인센티브를 주어서 제대로 된 교육을 지속적으로 받도록 하자
(3) HbA1c 측정 안함	일본의 경우 HbA1c를 측정하여 당뇨의 조절 및 평가를 위한 수단으로 사용하고 있지만, 우리나라의 경우는 측정하지 않고 있다.	HbA1c 측정항목을 추가하자

노인장기요양보험제도

(1) 현황

- 고령화가 진전됨에 따라 치매, 중풍 등 장기 수발서비스를 필요로 하는 노인이 증가
 - 핵가족화, 여성의 사회참여 증가 등으로 가족에 의한 수발보호는 한계
 - 또한 가정에서 감당하기 어려울 정도의 간병비용 부담은 국가에서 책임져야 할 심각한 문제로 대두
- 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인에게 목욕, 간호 및 가사지원 등 수발급여를 제공함으로써 삶의 질을 향상시키고 그 가족의 복지증진을 위하여 노인수발보험제도의 도입 필요성 증대
- 1차 시범사업('05.7~'06.3) 완료
 - 지역: 광주 남구, 수원, 강릉, 안동, 부여, 북제주
 - 대상: 국민기초생활보장 수급자를 대상으로 판정기준·절차, 수가, 비용심사, 지불체계 등 운영체계의 기술적인 검증 및 보완 실시
- 2차 시범사업('06.4~'07.3) 완료
 - 지역: 부산 북구, 광주 남구, 수원, 강릉, 안동, 부여, 완도, 북제주
 - 대상: 일반노인 중등증 이상(1~3등급)을 대상으로 본 사업과 유사한 형태로 운영체계를 전반적으로 검증

(2) 추진계획

- '08.7월 노인수발보험제도 본격 시행
- [노인수발보험법 제정] ('06.2월 정부안 국회제출)
 - 대상: 65세 이상 노인 및 64세 이하의 치매·뇌혈관성 질환 등 노인성 질병을 가진 자

* '08) 85천명(1~2등급) → '09) 87천명 → '10) 166천명(1~3등급)

《 수발급여의 종류 》

종류	내용	운영기관
재가수발급여	· 가정수발 · 목욕수발 · 간호수발 · 주·야간보호수발 · 단기보호수발	· 수발기관 · 방문간호기관 · 주·야간보호시설 · 단기보호시설
시설수발급여	· 시설 입소 수발	· 노인의료복지시설 (요양시설, 전문요양시설 등)
특별현금급여	· 가족수발비 · 특례수발비 · 요양병원수발비	

○ 질 높은 수발서비스 제공을 위한 적정수가 모형 개발

- 수발급여 유형 및 중증도별 차등수가 기준 마련 등

○ 제도의 원활한 시행을 위한 사전준비 조치

- 건강보험공단의 실무조직 구상, 인력 배치 및 전산 시스템 구축

- '08년 초부터 수발인정 신청 접수 및 등급 판정 개시

□ 3차 시범사업('07.4 ~ '08.6) 실시

○ 2차 시범사업 결과를 토대로 대상자, 지역, 서비스 내용 등을 확대하여

본 사업과 동일하게 실시하되, 보험료 부과 · 징수는 근거법령 제정 후
실시여부 추후 검토

수발급여의 종류

- 재가수발급여: 가정 등에서 일정한 시간 또는 단기간 동안 제공 하는 수발급여
- 시설수발급여: 수발기관의 시설에 장기간 동인 입소시켜 제공 하는 수발급여
- 특별현금급여: 가족수발비, 특례수발비, 요양병원수발비
 - - 특례수발비: 수발기관이 아닌 노인요양시설 등의 기간 또는 시설에서 재가수발급여 또는 시설수발급여에 상당한 수발급여를 받은 경우, 수발급여비용의 일부를 기준에 따라 수급자에게 지급

구분	독일	일본
가입자	공적 질병보험가입자	• 제1호: 65세 이상 • 제2호: 40~64세
수급권자	연령에 관계없이 거동불편 장애인을 포함한 모든 가입자	• 제1호: 요개호 1~5등급, 요지원자 • 제2호: 초로기 치매, 뇌혈관 장애 등 노화에 기인하는 15개 질병에 의한 요개호 · 요지원자
수발등급	- 요양등급: 1~3등급 • 평가판정항목: 36항목 ※신청→자격심사→판정의뢰→방문조사(MDK)→조사내용보고→등급통호	- 요양등급: 요개호 1~5등급, 요지원 등급 • 평가판정항목: 79항목 ※신청→방문조사→컴퓨터 1차판정→개호인정심사회의 2차판정→등급통보
재원구성	- 보험료 100%	- 보험료(45%)+공비(45%, 정부·시정촌 각각 1/2)+이용자 본인부담(10%)

본인부담	- 월 한도액 초과금액 • 실제 서비스 이용액 중에서 시설 50~60%, 재가 30% 수준 * 시설의 숙박비·식비	- 서비스 이용액의 10% ※시설(단기보호시설 포함) 거주비용과 식비 본인 부담('05.10월 실시)
보험료 부담	총수입의 1.7%(노사 각각 50%)	- 1호: 약 3,293엔(평균) - 2호: 0.9%(평균 약 3,043엔, 노사 각각 50%)
총 지출비용('03년)	176억 유로	5.7조엔

(1) 고혈압관리

- 우리나라 성인의 약 30% 이상에서 발견되는 매우 흔한 순환기 질환
일반적으로 증상이 없으므로 혈압을 측정하지 않으면 진단되기 어렵고, 진단이 되더라도 치료의 필요성을 느끼지 못하는 경우가 많음

가. 고혈압의 기준

- 만 18세 이상의 성인이 1주일 이상의 간격을 두고, 편안한 상태에서 2회 이상 측정한 수축기 혈압을 기준으로 하며, 수축기 혈압 140mmHg 이상이거나 확장기 혈압 90mmHg 이상 또는 두 가지가 함께 존재할 경우로 정의
- 노인의 경우 백의 고혈압, 수축기 고혈압, 가성 고혈압의 빈도가 높음, 혈압 측정을 좌위와 직위에서 모두 측정하여 기립성 저혈압의 유무를 확인해야 함

나. 고혈압의 비약물적 치료

- 생활습관 교정 : 비만 환자에서의 체중 감량과 적절한 식이조절, 운동과 절주
- 저염식 : 혈압 강하 효과와 함께 혈압약의 강압 효과 증대
- 지방섭취 감소 : 혈압과 직접적 관계는 없지만, 전체적인 심혈관 질환의 감소에 있어 필수적
- 금연 : 흡연은 동맥경화를 증가시키고, 심혈관 질환의 위험성을 증가시킴
- 절주 : 음주는 만성적으로 혈압을 상승시키는 효과 있다고 함

(2) 당뇨병관리

- 인슐린 분비 혹은 작용의 이상으로 혈액 내 포도당 농도가 증가하여 신장, 망막, 신경계통의 미세혈관 합병증과 뇌졸중, 협심증, 심근경색 및 말초혈관 질환 등의 합병증을 일으키는 일련의 대사질환

- 유병율은 사회 환경과 식생활의 변화, 그리고 고령화 사회로의 진입에 따라 증가되고 있으며, 당뇨병의 합병증으로 인한 삶의 질 저하와 사망률의 증가는 사회경제적인 문제가 됨

가. 당뇨병의 분류

- 제1형 당뇨병 : 베타세포의 파괴로 절대적인 인슐린 결핍을 보이는 당뇨병
- 제2형 당뇨병 : 인슐린 저항성이 있으면서 점진적인 인슐린 분비의 결핍이 진행되는 당뇨병

나. 당뇨 진단 기준

- 전형적인 증상 (다음, 다뇨, 이유없는 체중감소) + 무작위 혈장 혈당 $\geq 200\text{mg/dl}$
- 공복 혈장 혈당 (최소 8시간 이상 열량 섭취가 없는 상태) $\geq 126\text{mg/dl}$
- 75g 경구당 부하검사에서 2시간 혈장 혈당 농도 $\geq 200\text{mg/dl}$

<당뇨 전단계>

- 공복혈당장애 : 공복 혈장 혈당 $110\text{-}125\text{mg/dl}$
- 내당능장애 : 2시간 혈장 혈당 농도 $140\text{-}199\text{mg/dl}$

다. 당뇨 합병증

- 당뇨병성 망막증 : 실명의 주요 원인, 제 1형 당뇨병은 발병 후 3-5년 내, 제 2형 당뇨병은 발병 진단시 안저 검사 권장. UKPDS 결과 엄격한 혈당 및 혈압 조절이 망막병증의 위험과 진행을 감소, 지연시킬수 있음을 시사
- 당뇨병성 신병증 : 당뇨병 환자의 20-40%에서 발생, 말기 신부전의 주요 원인
- 당뇨병성 신경병증 : 당뇨병 환자에서 가장 흔한 합병증 중의 하나. 비외상성 하지 절단의 주요 원인

- 당뇨병은 심뇌혈관질환의 치명율을 2-4배 이상 증가시키며, 당뇨 환자의 80%는 심혈관질환으로 사망

라. 당뇨병 관리

- 당화 혈색소 A1c < 7.0%
- FPG (공복혈당) 90~130 mg/dL
- 혈압 < 130/80 mmHg
- LDL-C (저밀도지단백질) < 100 mg/dL, TG < 150 mg/dL
- 매년 안저 검사, 요단백질 검사, 발검사, 아스피린 복용, 독감 & 폐렴구균 예방접종 등

마. 당뇨병의 비약물적 치료

- 환자 교육, 식사 요법, 운동 요법

바. 노인 당뇨병의 특징

- 유병률이 높음
- 연령에 따른 당내성 감소
- 고혈압, 흡연, 고지혈증, 근골격계 질환 등의 동반질환이 많음
- 인지기능, 시력, 손놀림 등이 저하 - 인슐린 사용 어려움.
- 저혈당 또는 고혈당의 위험 증가
- 당뇨 이외의 여러 약제 복용

사. 노인 당뇨병의 관리

- 팀 접근 - 의사, 병원, 지역사회..등
- 목표 혈당치, 당뇨 교육, 관리 평가에 대해 개인적인 특성을 고려
- 고혈당 이외의 다른 심혈관 질환의 위험인자 조절이 사망률이나 이환율을 감소시킬 수 있음

<고혈압과 당뇨병의 증가 추이>

	2002년	2003년	2004년	2005년	연평균 증가율
고혈압	319	356	386	425	9.9
당뇨병	134	148	157	174	9.2

자료원 : 국민건강보험공단, 건강보험통계연보 각년도 (2002-2005)

만성질환자 추이 (건강보험 + 의료급여) (단위: 만명, %)

<고혈압과 당뇨병의 연령별 유병률, 인지율, 치료율, 조절율>

질병명 / 연령		유병률(%)	인지율(%)	치료율(%)	조절율(%)
고혈압	30-39	9.3	22.0	8.0	71.0
	40-49	21.0	42.0	26.0	54.0
	50-59	43.6	66.0	52.0	60.0
	60-69	55.6	75.0	64.0	53.0
	70+	57.1	71.0	63.0	50.0
	계(30세이상)	29.4	59.8	47.1	54.9
당뇨병	30-39	1.4	28.2	5.0	-
	40-49	7.4	47.5	24.1	24.8
	50-59	14.0	72.5	56.3	43.8
	60-69	18.1	80.6	59.3	46.6
	70+	17.9	81.6	67.3	38.7
	계(30세이상)	9.1	68.0	48.8	41.2

자료원 : 국민건강영양조사 제3기(2005) 심층분석 -건강면접 및 보건 의식 부문, 2007

일개 보건소의 노인관련사업

(1) 맞춤형방문보건사업

- 기존의 취약계층, 만성질환자에게 서비스를 전달하는 좁은 의미의 방문보건사업에서 질병이 발생하여 병의원에 가기 전 단계에 행해지는 질병예방 및 건강증진 활동을 총칭하는 넓은 의미의 새로운 환경, 새로운 변화에 맞추는 방문보건사업 추진
- 맞춤형방문건강관리사업 우선순위 사업 대상자가 대부분 65세 이상 지역 노인인구로 사업대상자가 중복되며 사업추진 방향이 일치하여 우리구에서 역점적으로 실시하고 있는 노인보건사업과 매칭하여 사업 추진
- 사업추진을 기초조사, 서비스제공 등으로 구분하는 멈춤의 사업에서 탈피한 기초조사 실시하면서 요구되는 서비스를 제공하는 연속성 상의 사업 추진
 - 1단계 : 기초조사에 주력
 - 2단계 : 등록체계구축 주력
 - 3단계 : 서비스제공, 지속관리 주력
- 단독적, 실적위주, 개별접근 환자중심의 로봇화된 행정적 환자 관리에서 대상자, 질병별 다양한 접근 및 서비스 제공을 위한 지역사회 자원, 연계체계를 구축, 활용하는 케이스메니저, 보건서비스 전달체계자로서의 사업 추진

(2) 만성질환관리사업

- ① 100세 건강 강좌
 - 기 간 : 3월 ~ 11월
 - 장 소 : 노인복지회관, 보건교육실, 종교단체(교회, 성당)
 - 내 용 : 만성질환 예방 및 관리를 위한 질병, 식이, 운동, 스트레스 관리법

② 고혈압 자조 관리 교실 - 120.80 우리 함께 노력해요

- 교육 기간 : 4월 ~ 6월, 주 1회 4주 모임
- 교육 인원 : 20 ~ 25명
- 교육 장소 : 보건교육실
- 교육 내용 : 고혈압 관리, 운동요법, 저염식이 교육, 스트레스 관리

③ 당뇨병 자조 관리 교실

- 교육 기간 : 9월 ~ 11월, 주 1회 4주 모임
- 모집 인원 : 20 ~ 25명
- 교육 장소 : 보건교육실
- 교육 내용 : 당뇨병 관리, 올바른 운동.식이요법, 발관리, 스트레스 관리

④ 짜게 먹는 식습관 고혈압 저염식이 조리실습

- 참여 대상 : 고혈압 대상자 및 가족
- 참여 인원 : 20 ~ 25명
- 실습 장소 : 호남직업전문학교
- 실습 내용 : 고혈압 저염식이 조리실습 및 시식

⑤ 건강한 식습관 형성을 위한 당뇨병 시식회

- 참여 대상 : 당뇨병으로 치료.관리 중인 대상자 및 가족
- 참여 인원 : 40 ~ 45명
- 교육 내용 : 식습관 개선 및 형성을 위한 당뇨뷔페 및 시식

⑥ 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 합병증 검사

- 검사 대상 : 고혈압.당뇨병.고지혈증으로 진단받고 치료 중인 분
 - 검사 기간 : 3월 ~ 11월
 - 검사 장소 : 보건소 및 관내 안과
 - 검사 항목 : 혈액검사, 흉부 엑스레이, 심전도, 당화혈색소 검사, 안과검진
- ※ 검사 접수는 보건소 1층 진료실이며, 안과검진은 진료실에서 안과의뢰서를 가져가셔야 받으실 수 있습니다.
- 검사 비용 : 무료

(3) 어르신 무료의치보철사업

치아의 결손으로 음식물 섭취가 자유롭지 못한 국민기초생활보장수급 노인들을 대상으로 의치보철을 보급하여 구강기능 회복에 기여하고 건강한 생활을 영위할 수 있도록 하기 위함

- 기간 - 3월 ~ 12월
- 대상 - 65세 이상 국민기초생활보장 수급 대상자 18명
- 장소 - 보건(지)소에서 전신건강상태기록 및 구강상태를 1차로 검진한 후 의치보철이 가능한 대상자를 선정하여 치과의원에 시술 의뢰
- 시술대상자 : 전부의치 또는 부분의치 무료시술
- 진료비 - 무료

○ 경로당방문구강보건사업

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 방문구강보건사업 연계 경로당방문
- 장 소 : 해당 경로당
- 내 용 :
구강검진, 잇솔질 교습, 틀니관리방법, 구강위생용품배부,
불소도포 : 치아표면에 불소를 발라 치아의 뿌리면 충치예방 및 시린이 방지

(4) 치매, 정신보건 사업

치매 조기발견 및 치료를 위해 대학병원 등 지역사회 인적·물적자원을 활용하여 어르신들의 건강 및 독립성이 최대 유지되도록 하기 위해서 치매어르신을 위한 은빛노후관리를 실시하고 있습니다.

가. 치매 어르신 조기발견을 위하여

- 치매 전수조사(어르신 정신건강조사)
- 치매선별검사
- 치매의심자 대학병원 연계 치매 정밀검진

나. 재가 치매 어르신을 위한 서비스

- 의료재활서비스 : 치매 평가, 신체상태 관리, 문제행동 관리, 의료정보 제공 등
- 사회재활서비스 : 일상생활관리, 대인관계 기술훈련, 사회적응훈련 등 연계
- 사회복지서비스 : 자원봉사 연계, 물품 지원, 복지관 연계, 배회팔찌 제공 등

다. 지역 어르신을 위한 치매예방교육

- 치매상담센터 운영(☎ 062-608-2777)
- 지역 어르신을 위한 치매예방 교육
- 경도인지장애 어르신을 위한 치매예방 프로그램
- 치매예방 홍보

(5) 운동, 영양, 절주사업

가. 노인 운동 프로그램

- 목적 : 노년기 급격한 체력저하를 예방하고 건강한 생활을 유지 할 수 있도록 하기 위함.
- 교육시기 : 2008년 4월 이후
- 교육대상 : 동구관내 60세 이상 노인이 10인 이상 모이는 장소면 어디나
- 예약시기 : 연중 수시
- 교육예약 : 062-608-2726
- 교육내용
 - 기본 프로그램 : 주3회 1시간 씩, 3개월 이상
 - 낙상예방운동
 - 요실금 예방운동
 - 유연성 운동(요가)
 - 근력 강화 운동

나. 노인 영양상담 프로그램

- 목적 : 노인의 영양 관련 지식 향상과 고른 영양섭취 유도
- 시기 : 연중

- 교육대상 : 60세 이상 동구 관내 주민이면 누구나
- 장소 : 동구보건소 2층 상담실, 10인 이상이 모이는 장소면 어디나
- 예약시기 : 연중 수시
- 문의전화 : 062-608-2726
- 교육내용
 - 기본 영양상담(20분 소유)
 - Can-pro를 이용하여 전체 영양소 섭취 비율과 영양소별 권장량 비교
섭취 정도 분석 (40분 이상 소유)
 - 과잉 및 부족 영양소와 올바른 섭취 방법